

CẨM NANG DÀNH CHO BẠN

Thai kỳ khỏe mạnh

Ấn bản thứ 12 • Bản dịch tiếng Việt



Cẩm nang dành cho bạn: Thai kỳ khỏe mạnh

Thân gửi các bậc cha mẹ tương lai,

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Cleveland Clinic để chăm sóc sản khoa và cho phép chúng tôi được đồng hành đón thiên thần nhỏ (hoặc các thiên thần nhỏ) của bạn chào đời! Đây là quãng thời gian đầy háo hức, và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ để trải nghiệm của bạn được trọn vẹn nhất.

Quyết định trở thành cha mẹ là một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Vì trẻ sinh ra không kèm theo "sách hướng dẫn sử dụng", bạn sẽ cần đến đội ngũ y tế để được tư vấn và hướng dẫn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn những thông tin tốt nhất để bạn đưa ra các quyết định sáng suốt.

Đội ngũ bác sĩ sản khoa, bác sĩ chuyên khoa y học bà mẹ – thai nhi và nữ hộ sinh được đào tạo bài bản của chúng tôi đỡ đẻ hơn 13.000 em bé mỗi năm tại ba bệnh viện. Chúng tôi rất vui được là một phần trong ê-kíp của bạn và mong bạn sẽ tiếp tục tin tưởng chúng tôi trong mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Để biết thêm thông tin về các bác sĩ và dịch vụ, hãy truy cập clevelandclinic.org/obstetrics.

Với những sản phụ từng trải qua bạo lực tình dục hoặc sang chấn khác, Cleveland Clinic đã xây dựng chương trình M-Power nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc thấu hiểu sang chấn, đặt nhu cầu của bạn lên hàng đầu. Cách tiếp cận toàn diện, giàu lòng trắc ẩn này giúp bạn cảm thấy sẵn sàng cho cuộc chuyển dạ, cuộc sinh và giai đoạn sau sinh.

Cleveland Clinic phối hợp cùng Sở Y tế bang Ohio thúc đẩy "giấc ngủ an toàn" cho trẻ, chủ động góp phần giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ nhỏ. Nguyên tắc ABC của giấc ngủ an toàn là: luôn đặt bé nằm ngửa, ngủ một mình trong cũi riêng, chỉ với đệm cứng và ga trải vừa khít.

Nuôi con bằng cách nào là lựa chọn mà mọi cha mẹ đều phải đối mặt. Các bệnh viện sản của Cleveland Clinic ủng hộ việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và đang thực hiện những bước đi đặc biệt để tạo môi trường tốt nhất cho việc nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Chúng tôi nỗ lực duy trì danh hiệu "Bệnh viện Thân thiện với Trẻ em" (Baby Friendly Hospital), được xét công nhận lại 5 năm một lần. Sáng kiến Bệnh viện Thân thiện với Trẻ em (www.babyfriendlyusa.org) là chương trình quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Sữa mẹ mang lại khởi đầu không gì sánh được cho trẻ và được Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến nghị là nguồn dinh dưỡng chính trong năm đầu đời. Các nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ bú mẹ khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ nhũ nhi (SIDS), ít mắc ung thư trẻ em và đái tháo đường hơn.

Bên cạnh hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và hỗ trợ sinh, Cleveland Clinic còn giúp bạn chuẩn bị cho "ngày trọng đại" qua các lớp học như "Baby Basics" (Kiến thức cơ bản về trẻ

sơ sinh) và "Boot Camp for New Dads" (Khóa huấn luyện cho các ông bố mới). Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn cho con bú, tài liệu hướng dẫn và các nhóm hỗ trợ. Các bác sĩ nhi và bác sĩ gia đình của Cleveland Clinic hỗ trợ chăm sóc trẻ khỏe tại trung tâm y tế gia đình và các bệnh viện lân cận. Bạn có thể xem lịch các lớp học tiền sản tại clevelandclinic.org/childbirth. Cuốn sách này có thể truy cập tại clevelandclinic.org/healthypregnancyguide.

Để có thêm thông tin nhằm đưa ra quyết định sáng suốt về dinh dưỡng cho bé, chúng tôi khuyến khích bạn trao đổi với nhân viên y tế của mình.

Trân trọng,

Đội ngũ Sức khỏe Phụ nữ của bạn

M Ụ C L Ụ C

1. Chăm sóc mẹ

- › Chăm sóc trước sinh
- › Vitamin cho bà bầu
- › Hướng dẫn dùng thuốc trong thai kỳ
- › Dinh dưỡng tốt trong thai kỳ
- › Chăm sóc răng miệng trong thai kỳ
- › Chăm sóc sản khoa trọn gói ("global")
- › Xét nghiệm HIV
- › Tiêm vắc-xin trong thai kỳ
- › Bệnh lây truyền qua đường tình dục và thai kỳ
- › Hút thuốc ảnh hưởng đến bạn và em bé như thế nào
- › Tăng huyết áp
- › Đái tháo đường thai kỳ
- › Bệnh Toxoplasma và thai kỳ
- › Ứng phó với những thay đổi cơ thể khi mang thai
- › Tìm tư thế thoải mái
- › Tập luyện trong thai kỳ
- › Mang thai, sinh con và kiểm soát tiểu tiện
- › Quan hệ tình dục trong thai kỳ
- › Giấc ngủ trong thai kỳ
- › Đi lại, du lịch trong thai kỳ
- › Trầm cảm trong thai kỳ

2. Ba tháng đầu thai kỳ

- › Ba tháng đầu thai kỳ của bạn
- › Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế
- › Siêu âm trước sinh
- › Hướng dẫn về buổi hẹn siêu âm
- › Sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể
- › Mã CPT của các xét nghiệm di truyền

3. Ba tháng giữa thai kỳ

- › Ba tháng giữa thai kỳ của bạn
- › Chào mừng đến với ba tháng giữa
- › Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế
- › Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống

4. Ba tháng cuối thai kỳ

- › Ba tháng cuối thai kỳ của bạn
- › Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế trong ba tháng cuối
- › Đếm cử động thai (máy đập)
- › Non-stress test (đo tim thai không kích thích)

- › Liên cầu khuẩn nhóm B và thai kỳ
- › Chuyển dạ thật và chuyển dạ giả
- › Chuyển dạ sinh non
- › Chuẩn bị đồ đi sinh
- › Ngày bé chào đời
- › Các phương pháp sinh
- › Các lựa chọn giảm đau khi sinh

5. Sau sinh

- › Những điều sẽ diễn ra sau sinh
- › Thay đổi cơ thể sau sinh
- › Rách âm đạo
- › Biện pháp tránh thai tác dụng kéo dài có hồi phục
- › Trầm cảm sau sinh
- › Tập luyện sau sinh

6. Nuôi con bằng sữa mẹ

- › Lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ
- › Mẹ con ở cùng phòng 24 giờ
- › Da kề da cho mẹ và bé
- › Cho con bú những tuần đầu
- › Thuốc không kê đơn khi cho con bú
- › Tránh thai khi cho con bú

7. Chăm sóc bé

- › Giấc ngủ an toàn
- › Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện
- › Ngoại hình trẻ sơ sinh
- › Hành vi của trẻ sơ sinh
- › Khi nào cần gọi bác sĩ
- › Chăm sóc và theo dõi rốn
- › Cắt bao quy đầu
- › Tiêm chủng cho trẻ
- › Thêm bé vào hợp đồng bảo hiểm
- › Bạn đang tìm bác sĩ nhi?
- › Chọn ghế ngồi ô tô cho bé

LOẠI VẤN ĐỀ	CÁC THUỐC AN TOÀN CÓ THỂ DÙNG TRONG THAI KỲ
Dị ứng	Diphenhydramine (Benadryl®) Loratidine (Claritin®) Cetirizine (Zyrtec®)
Cảm lạnh và cúm	Diphenhydramine (Benadryl®)* Dextromethorphan (Robitussin®)* Guaifenesin (Mucinex® [loại đơn chất])* Kem bôi bạc hà Vicks Vapor Rub® Viên ngậm ho có tinh dầu bạc hà hoặc không có bạc hà (Với người đái tháo đường thai kỳ, viên ngậm ho không đường không được chứa hỗn hợp thảo dược hoặc aspartame); pseudoephedrine ([Sudafed®] sau 3 tháng đầu); acetaminophen (Tylenol®)* Nhỏ hoặc xịt mũi nước muối sinh lý Súc họng nước muối ấm *Lưu ý: Không dùng dạng "SA" (phóng thích kéo dài) hoặc dạng "đa triệu chứng" của các thuốc này. Không dùng Nyquil® hoặc thuốc generic tương ứng vì có hàm lượng cồn cao.
Tiêu chảy	Loperamide ([Imodium®] sau 3 tháng đầu, chỉ dùng trong 24 giờ)
Táo bón	Chất xơ methylcellulose (Citrucel®) Docusate (Colace®) Psyllium (Fiberall®, Metamucil®) Polycarbophil (FiberCon®) Polyethylene glycol (MiraLAX®)* *Chỉ dùng thỉnh thoảng
Thuốc mỡ sát khuẩn (sơ cứu)	Bacitracin Neomycin/polymyxin B/bacitracin (Neosporin®)
Đau đầu	Acetaminophen (Tylenol)
Ợ nóng	Nhôm hydroxide/magnesi carbonat (Gaviscon®)* Famotidine (Pepcid AC®) Nhôm hydroxide/magnesi hydroxide (Maalox®) Calci carbonat/magnesi carbonat (Mylanta®) Calci carbonat (Titrilac®, Tums®) *Chỉ dùng thỉnh thoảng
Trĩ	Phenylephrine/dầu khoáng/petrolatum (Preparation H®) Cây phi - witch hazel (miếng lót hoặc thuốc mỡ Tucks®)
Thuốc xua côn trùng	N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET®)
Buồn nôn và nôn	Doxylamine (Unisom Sleeptab) Vitamin B6 25mg, ngày 3 lần, phối hợp doxylamine 12,5mg trước khi ngủ để dự phòng buồn nôn. Cao gỪng 125–250mg mỗi 6 giờ.
Phát ban	Kem diphenhydramine (Benadryl) Kem hoặc thuốc mỡ hydrocortisone Tắm bột yến mạch (Aveeno®)

LOẠI VẤN ĐỀ	CÁC THUỐC AN TOÀN CÓ THỂ DÙNG TRONG THAI KỲ
Mất ngủ	Diphenhydramine (Unisom SleepGels®, Benadryl)
Nhiễm nấm âm đạo	Miconazole (Monistat® 7-Day)

*Xin lưu ý: Không có thuốc nào được coi là an toàn 100% khi dùng trong thai kỳ.

1. Chăm sóc mẹ

- › Chăm sóc trước sinh
- › Vitamin cho bà bầu
- › Hướng dẫn dùng thuốc trong thai kỳ
- › Dinh dưỡng tốt trong thai kỳ
- › Chăm sóc răng miệng trong thai kỳ
- › Chăm sóc sản khoa trọn gói ("global")
- › Xét nghiệm HIV
- › Tiêm vắc-xin trong thai kỳ
- › Bệnh lây truyền qua đường tình dục và thai kỳ
- › Hút thuốc ảnh hưởng đến bạn và em bé như thế nào
- › Tăng huyết áp
- › Đái tháo đường thai kỳ
- › Bệnh Toxoplasma và thai kỳ
- › Ứng phó với những thay đổi cơ thể khi mang thai
- › Tìm tư thế thoải mái
- › Tập luyện trong thai kỳ
- › Mang thai, sinh con và kiểm soát tiểu tiện
- › Quan hệ tình dục trong thai kỳ
- › Giấc ngủ trong thai kỳ
- › Đi lại, du lịch trong thai kỳ
- › Trầm cảm trong thai kỳ

Chăm sóc trước sinh: Buổi khám thai đầu tiên

Vì sao chăm sóc trước sinh lại quan trọng?

Khám thai định kỳ với nhân viên y tế trong suốt thai kỳ rất quan trọng để bảo đảm sức khỏe cho bạn và em bé. Bên cạnh việc chăm sóc y tế, chăm sóc trước sinh còn bao gồm giáo dục về thai nghén và sinh nở, cùng với tư vấn và hỗ trợ.

Việc thăm khám thường xuyên giúp bạn theo dõi sự phát triển của em bé, đồng thời là dịp để bạn đặt câu hỏi. Hầu hết các cơ sở y tế đều hoan nghênh chồng/bạn đời của bạn cùng tham dự mỗi buổi khám, cũng như những người thân quan tâm.

Buổi khám đầu tiên diễn ra như thế nào?

Buổi khám đầu tiên nhằm đánh giá sức khỏe chung của bạn và giúp nhân viên y tế nhận biết các yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thai kỳ. Buổi khám này thường kéo dài hơn các lần sau. Mục đích của lần khám đầu là:

- Xác định ngày dự sinh.
- Tìm hiểu tiền sử bệnh của bạn.
- Khai thác tiền sử bệnh của các thành viên trong gia đình.
- Xác định xem bạn có yếu tố nguy cơ nào cho thai kỳ hay không, dựa trên tuổi, tình trạng sức khỏe và/hoặc tiền sử cá nhân, gia đình.

Bạn sẽ được hỏi về những lần mang thai và phẫu thuật trước đây, các bệnh đang mắc, và việc có tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm nào không. Ngoài ra, hãy báo cho nhân viên y tế biết mọi loại thuốc (kê đơn hoặc không kê đơn) bạn đã và đang dùng. Chúng tôi sẽ hỏi một số câu hỏi riêng tư, nhưng bạn hãy yên tâm rằng mọi thông tin bạn cung cấp đều được giữ bí mật tuyệt đối.

Khám thực thể

Khám thực thể toàn diện cũng là một phần của buổi khám đầu. Bạn sẽ được cân, đo huyết áp, khám tim, phổi và vú. Buổi khám đầu còn bao gồm khám vùng chậu (khám phụ khoa).

Khám vùng chậu

Khi khám vùng chậu, nhân viên y tế sẽ thăm khám bằng hai tay (hai ngón tay trong âm đạo và một tay trên bụng) để xác định kích thước tử cung và khung chậu. Nhân viên y tế cũng có thể nghe tim thai bằng một dụng cụ đặc biệt gọi là doppler, sử dụng siêu âm (sóng âm tần số cao). Doppler thường chưa phát hiện được tim thai trước tuần thứ 10 đến 12 của thai kỳ.

Xét nghiệm

Trong 3 tháng đầu, bạn sẽ được chỉ định nhiều xét nghiệm, bao gồm:

- Công thức máu toàn phần (CBC): sàng lọc các vấn đề về máu, chẳng hạn thiếu máu (thiếu sắt).

- Nhóm máu và sàng lọc kháng thể: xác định nhóm máu và yếu tố Rh (một kháng nguyên hay protein trên bề mặt hồng cầu có thể gây phản ứng miễn dịch).
- Sàng lọc bệnh hồng cầu hình liềm.
- Xét nghiệm lậu và Chlamydia.
- SMA: sàng lọc đột biến gen gây bệnh teo cơ tủy sống.
- Viêm gan C.
- RPR: sàng lọc giang mai (một bệnh lây truyền qua đường tình dục).
- Rubella: kiểm tra khả năng miễn dịch (bảo vệ) với bệnh sởi Đức.
- HBsAg: xét nghiệm viêm gan B (một bệnh nhiễm trùng gan).
- Tổng phân tích nước tiểu: kiểm tra nhiễm trùng thận và bàng quang.
- HIV: sàng lọc kháng thể trong máu.
- Cystic Fibrosis (xơ nang): sàng lọc người mang gen CF.

Ngày dự sinh được tính như thế nào?

Thông thường, ngày dự sinh được tính bằng 280 ngày (40 tuần, khoảng hơn 9 tháng) kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Tuy nhiên, nếu kinh nguyệt của bạn không đều hoặc chu kỳ không phải 28 ngày, ngày dự sinh có thể khác với quy tắc "280 ngày". Nhân viên y tế có thể chỉ định siêu âm để xác định ngày dự sinh nếu chưa chắc chắn dựa trên chu kỳ kinh.

Một thai kỳ đủ tháng kéo dài 37 đến 42 tuần, vì vậy ngày sinh thực tế có thể khác với ngày dự sinh (EDD hay EDC – ngày dự kiến sinh). Thực tế chỉ có rất ít em bé chào đời đúng ngày dự sinh.

Trong thai kỳ, tôi cần đi khám bao lâu một lần?

Lịch khám thai phụ thuộc vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc các yếu tố nguy cơ của từng người. Nhìn chung, lịch khám được khuyến nghị như sau:

- 4 tuần một lần cho đến tuần 28.
- 2-3 tuần một lần từ tuần 28 đến tuần 36.
- Hằng tuần từ tuần 36 cho đến khi sinh.

Trong các buổi khám, bạn đừng ngại đặt câu hỏi. Việc chuẩn bị sẵn danh sách câu hỏi mang theo sẽ rất hữu ích.

Những gì được theo dõi ở các lần khám sau?

Ở các buổi khám thai, bạn sẽ được kiểm tra cân nặng, huyết áp, và xét nghiệm nước tiểu tìm đường và protein. Tử cung sẽ được đo để theo dõi sự phát triển của thai. Tim thai cũng sẽ được kiểm tra (thường bắt đầu từ tuần thứ 10 đến 12).

Tùy tình trạng riêng hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn, có thể cần thêm các xét nghiệm khác.

Trong tháng cuối, các buổi khám sẽ có thêm phần trao đổi về chuyển dạ và sinh nở. Bạn có thể được thăm khám trong (khám âm đạo) để kiểm tra cổ tử cung (phần thấp nhất của tử cung) xem đã mở miệng đi (gọi là xóa) và mở ra (gọi là mở cổ tử cung) hay chưa.

Vitamin cho bà bầu

Vitamin cho bà bầu là gì?

Vitamin cho bà bầu (prenatal vitamins) là loại vitamin tổng hợp được bào chế riêng, khuyến nghị cho phụ nữ mang thai dùng vì sức khỏe của chính mình cũng như của em bé. Các vitamin này bù đắp những thiếu hụt dinh dưỡng trong chế độ ăn của bạn khi mang thai. Tuy viên bổ sung chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, nhưng thành phần acid folic, sắt và calci là đặc biệt quan trọng. Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) khuyến nghị phụ nữ mang thai và cho con bú nên bổ sung trung bình mỗi ngày ít nhất 200 mg acid docosahexaenoic (DHA) bên cạnh viên vitamin bà bầu. Vitamin bà bầu cũng như DHA có thể mua không cần đơn hoặc theo đơn.

Vì sao phụ nữ mang thai cần nhiều acid folic, sắt và calci?

Bổ sung acid folic giúp giảm nguy cơ sinh con mắc dị tật bẩm sinh nghiêm trọng của não và tủy sống, gọi là dị tật ống thần kinh. Trẻ bị nứt đốt sống (spina bifida) – dị tật ống thần kinh hay gặp nhất – sinh ra với cột sống không phát triển hoàn chỉnh. Các dây thần kinh bị lộ ra ngoài sẽ tổn thương, khiến trẻ bị liệt ở các mức độ khác nhau, không tự chủ đại tiểu tiện, và đôi khi chậm phát triển trí tuệ. Một số phụ nữ có nguy cơ cao hơn sinh con bị dị tật ống thần kinh hở, bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở) người có tiền sử gia đình bị nứt đốt sống và người đang dùng thuốc chống động kinh. ACOG khuyến nghị bổ sung thêm acid folic cho những phụ nữ thuộc nhóm nguy cơ cao này. Bác sĩ sẽ trao đổi cụ thể với bạn và trong một số trường hợp có thể giới thiệu bạn đi tư vấn di truyền.

Dị tật ống thần kinh hình thành trong 28 ngày đầu sau thụ thai. Vì khoảng một nửa số trường hợp mang thai là ngoài kế hoạch, Cơ quan Y tế Công cộng Hoa Kỳ (U.S. Public Health Service) khuyến nghị mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên bổ sung 400 microgam acid folic mỗi ngày. Acid folic có trong các nguồn tự nhiên: rau lá xanh, các loại hạt, đậu và trái cây họ cam quýt. Nó cũng có trong nhiều loại ngũ cốc ăn sáng tăng cường vi chất và một số viên bổ sung vitamin.

Bổ sung calci trong thai kỳ giúp người mẹ không bị mất mật độ xương của chính mình, vì thai nhi sử dụng khoáng chất này để phát triển xương. Bổ sung sắt giúp máu của cả mẹ và bé vận chuyển oxy tốt hơn.

Viên vitamin uống hằng ngày không thể thay thế một chế độ ăn lành mạnh, nhưng hầu hết phụ nữ mang thai và cho con bú vẫn cần bổ sung để bảo đảm đủ các khoáng chất này.

Hướng dẫn dùng thuốc trong thai kỳ

biết bạn đang mang thai, và nhớ trao đổi kỹ về lợi ích và nguy cơ của thuốc mới đó.

Mặc dù một số thuốc được coi là an toàn trong thai kỳ, tác động của nhiều thuốc khác lên thai nhi vẫn chưa được biết rõ. Một số thuốc gây hại nhiều nhất cho thai đang phát triển khi dùng trong 3 tháng đầu của thai kỳ — thường là trước cả khi người phụ nữ biết mình có thai.

Ma túy/Rượu bia

Các chất ma túy không tốt cho sức khỏe của bạn, và còn tệ hơn nữa cho sức khỏe của thai nhi, vì các chất này truyền sang em bé trong khi bạn mang thai. Các chất ma túy như "bụi thiên thần" (angel dust/PCP), cocaine, crack, heroin, LSD, cần sa và ma túy đá (speed) làm tăng nguy cơ em bé sinh ra với nhiều vấn đề. Khi người mẹ mang thai uống rượu hoặc dùng ma túy, em bé cũng "dùng" theo. Những chất này có thể đi qua bánh rau và đến em bé qua dây rốn. Rượu, thuốc lá và ma túy có thể dẫn đến sinh non, dị tật bẩm sinh, nhẹ cân, rau bong non, rối loạn phổ rượu bào thai, sảy thai, thai chết lưu và các vấn đề về phát triển/hành vi. Theo tổ chức March of Dimes, không có mức rượu hay cần sa nào được chứng minh là an toàn trong thai kỳ. Có thể bạn biết những người uống rượu thường xuyên khi mang thai mà con sinh ra trông vẫn khỏe mạnh; cũng có thể bạn biết những người chỉ uống rất ít mà con lại gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Mỗi thai kỳ mỗi khác, và rượu có thể gây hại cho em bé này nhiều hơn em bé khác. Do gan còn rất nhỏ, em bé không thể phân giải rượu tốt như bạn.

Heroin là ma túy được chế từ hạt cây thuốc phiện, thường tiêm bằng kim, nhưng cũng có thể hút hoặc hít. Dùng heroin khi mang thai rất nguy hiểm, nhưng bạn đừng tự ý ngừng thuốc khi chưa được nhân viên y tế điều trị. Ngừng đột ngột có thể gây hậu quả nặng nề. Có những thuốc giúp bạn giảm dần sự lệ thuộc heroin như methadone hoặc buprenorphine.

Hãy cho nhân viên y tế (bác sĩ, dược sĩ...) biết nếu bạn từng dùng ma túy hoặc đang nghiện bất kỳ chất nào, để họ giảm thiểu nguy cơ cho em bé. Họ luôn sẵn sàng điều trị và hỗ trợ bạn. Tại Việt Nam, hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ sản khoa hoặc cơ sở y tế nơi bạn khám thai để được tư vấn và giới thiệu điều trị phù hợp; trường hợp cấp cứu, gọi 115.

Hướng dẫn với thuốc kê đơn

Nếu bạn đang dùng thuốc kê đơn từ trước khi mang thai, hãy hỏi nhân viên y tế về mức độ an toàn của việc tiếp tục các thuốc này ngay khi biết mình có thai.

Nhân viên y tế sẽ cân nhắc lợi ích cho bạn và nguy cơ cho em bé khi đưa ra khuyến nghị về một loại thuốc cụ thể. Với một số thuốc, nguy cơ nếu không dùng thuốc có thể còn nghiêm trọng hơn nguy cơ tiềm ẩn khi dùng.

Ví dụ, nếu bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), nhân viên y tế có thể kê kháng sinh. Nếu không điều trị, nhiễm trùng tiết niệu có thể gây hậu quả lâu dài cho cả mẹ và con. Khi được kê bất kỳ thuốc mới nào, hãy báo cho người kê đơn

Dinh dưỡng tốt trong thai kỳ cho bạn và em bé

Bây giờ bạn đang ăn cho cả mình và em bé. Tuy là "hai người", bạn chỉ cần tăng thêm 200 đến 300 calo mỗi ngày. Phần này sẽ giúp bạn chọn được nhiều loại thực phẩm lành mạnh để cả hai mẹ con nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Tôi nên ăn những gì?

Bạn cần thêm 200–300 calo từ các thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt nạc, sữa ít béo, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt. Điều quan trọng là cân nhắc kỹ những gì bạn ăn trong thai kỳ. Đây là lúc nên ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn, và bớt đồ ngọt, đồ ăn vặt. Hãy ăn đa dạng. Bạn có thể dùng trang web www.choosemyplate.gov làm hướng dẫn chọn lượng thức ăn trong từng nhóm thực phẩm.

Hướng dẫn ăn uống lành mạnh hằng ngày trong thai kỳ

- **Calci:** Cơ thể cần calci để xây dựng xương và răng chắc khỏe. Calci còn giúp máu đông bình thường, thần kinh hoạt động tốt và tim đập đều. Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) khuyến nghị 1.000 miligam mỗi ngày cho phụ nữ mang thai và cho con bú; phụ nữ từ 19 tuổi trở xuống cần 1.300 miligam mỗi ngày. Hãy ăn hoặc uống 4 khẩu phần sản phẩm từ sữa hoặc thực phẩm giàu calci mỗi ngày. Sữa và chế phẩm từ sữa là nguồn calci tốt nhất. Các nguồn khác gồm rau lá xanh đậm, ngũ cốc và bánh mì tăng cường vi chất, cá, nước cam bổ sung calci, hạnh nhân và vùng.
- **Acid folic:** Acid folic được dùng để tạo lượng máu tăng thêm mà cơ thể cần trong thai kỳ. ACOG và March of Dimes khuyến nghị 400 microgam mỗi ngày cho phụ nữ mang thai — lượng này đã có trong viên vitamin bà bầu. Theo March of Dimes, 70% dị tật ống thần kinh có thể phòng tránh nhờ bổ sung đủ acid folic. Một số phụ nữ có nguy cơ cao sinh con bị dị tật ống thần kinh hở (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở người có tiền sử gia đình nứt đốt sống, người dùng thuốc chống động kinh...). ACOG khuyến nghị nhóm này cần bổ sung thêm acid folic; bác sĩ sẽ trao đổi với bạn và có thể giới thiệu tư vấn di truyền. Thực phẩm giàu acid folic gồm đậu lăng, đậu tây, rau lá xanh (rau chân vịt/cải bó xôi, xà lách romaine, cải xoăn và súp lơ xanh), trái cây họ cam quýt, các loại hạt và đậu. Acid folic cũng được bổ sung vào một số thực phẩm như bánh mì, ngũ cốc, mì, gạo và bột tăng cường vi chất.
- **Sắt:** Sắt là thành phần quan trọng của hồng cầu — tế bào vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Sắt giúp bạn tăng sức chống đỡ với stress và bệnh tật, tránh mệt mỏi, yếu sức, cáu gắt và trầm cảm. ACOG khuyến nghị tổng cộng 27 miligam sắt mỗi ngày từ thức ăn và viên vitamin bà bầu. Nguồn sắt tốt gồm ngũ cốc nguyên hạt, thịt bò và thịt lợn nạc, trái cây sấy và đậu, cá mòi, rau lá xanh.
- **Vitamin A:** ACOG khuyến nghị 770 microgam vitamin A mỗi ngày. Thực phẩm giàu vitamin A gồm rau lá xanh, rau

củ màu vàng đậm hoặc cam như cà rốt, khoai lang, sữa và gan.

- **Khuyến nghị hằng ngày:** Gồm 2–3 khẩu phần rau, 2 khẩu phần trái cây, ít nhất 3 khẩu phần bánh mì/ngũ cốc/mì nguyên hạt, và 2–3 khẩu phần đạm nạc (thịt, cá, gia cầm).
- **Vitamin D:** Vitamin D phối hợp với calci giúp xương và răng của bé phát triển, đồng thời cần thiết cho làn da và thị lực khỏe mạnh. Mọi phụ nữ, kể cả khi mang thai, cần 600 đơn vị quốc tế (IU) vitamin D mỗi ngày. Nguồn tốt là sữa bổ sung vitamin D và cá béo như cá hồi. Phơi nắng cũng giúp chuyển hóa một chất trong da thành vitamin D.
- **DHA:** ACOG khuyến nghị phụ nữ mang thai và cho con bú nên đạt trung bình ít nhất 200 miligam acid docosahexaenoic (DHA) mỗi ngày, bên cạnh viên vitamin bà bầu. Vitamin bà bầu và DHA có thể mua không cần đơn hoặc theo đơn.
- **Chất đạm (protein):** Đạm là dưỡng chất quan trọng cho tăng trưởng và phát triển, cần cho việc tạo năng lượng, xây dựng và sửa chữa các bộ phận cơ thể, nhất là não, cơ và máu. Phụ nữ mang thai cần thêm đạm cho sự phát triển của em bé. Nhu cầu đạm mỗi người mỗi khác tùy thể trạng: một phụ nữ nặng 150 pound (~68 kg) cần 75 gam đạm mỗi ngày (ước tính nhanh: lấy cân nặng trước mang thai tính bằng pound chia đôi). Hãy chọn đa dạng thực phẩm giàu đạm: hải sản, thịt nạc và gia cầm, trứng, các loại đậu, sản phẩm từ đậu nành, các loại hạt không muối. Đọc nhãn thực phẩm đóng gói để biết mỗi món cung cấp bao nhiêu gam đạm.
- **Tránh rượu bia:** Rượu có liên quan đến sinh non, trẻ nhẹ cân và hội chứng rượu bào thai.
- **Caffeine:** Nên giới hạn caffeine dưới 200 miligam mỗi ngày. Một cốc cà phê 8 ounce (~240 ml) chứa khoảng 100 miligam caffeine; một cốc trà 8 ounce chứa khoảng 25–50 miligam. Cố gắng hạn chế nước ngọt có caffeine.
- **Ăn mặn vừa phải:** Muối khiến cơ thể giữ nước và có thể làm tăng huyết áp.
- **Không ăn kiêng giảm cân:** Kể cả khi thừa cân, thai kỳ không phải là lúc để giảm cân. Bạn hoặc em bé có thể bị thiếu những dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển.

Có những thực phẩm nào gây hại cần tránh khi mang thai?

Có những thực phẩm cụ thể bạn nên tránh trong thai kỳ. Thay đổi nội tiết khi mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch, khiến bạn dễ mắc bệnh lây qua thực phẩm hơn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ghi nhận nhiễm khuẩn listeria qua thực phẩm trong thai kỳ có thể gây sinh non, sảy thai, thậm chí thai chết lưu. Phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm listeria cao gấp 10 lần.

- Bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm listeria bằng cách thận trọng với xúc xích (hot dog), thịt nguội (như bologna), xúc xích lên men hoặc xúc xích khô — chỉ ăn khi đã được làm nóng đến nhiệt độ bên trong 165°F (~74°C) hoặc bốc hơi nóng ngay trước khi ăn.

- Tránh để nước từ bao bì xúc xích, thịt nguội dây sang thực phẩm khác, dụng cụ và bề mặt chế biến; rửa tay sau khi cầm nắm các loại thịt này.
- Không ăn phô mai mềm như feta, queso blanco, queso fresco, brie, Camembert, phô mai vân xanh, hay panela (queso panela), trừ khi nhãn ghi rõ làm từ sữa tiệt trùng. Hãy chắc chắn nhãn ghi "MADE WITH PASTEURIZED MILK" (làm từ sữa tiệt trùng).
- Chú ý đọc nhãn. Không ăn pate hoặc các món thịt phết bảo quản lạnh bán ở quầy thịt nguội hoặc khu hàng lạnh. Các loại không cần bảo quản lạnh như pate đóng hộp thì ăn được; sau khi mở hộp cần cất tủ lạnh.
- Các thực phẩm khác dễ gây bệnh lây qua thực phẩm gồm sushi, thịt và gia cầm (gà) tái hoặc chưa chín kỹ, thịt bò tái, trứng sống, sốt Caesar và mayonnaise. Để biết thêm về listeria, truy cập trang CDC: www.cdc.gov/listeria/prevention.html.

Một thực phẩm khác cần lưu tâm là cá. Tuy cá là nguồn đạm ít béo, tốt cho sức khỏe, một số loài cá chứa hàm lượng cao thủy ngân methyl hoặc polychlorinated biphenyls (PCBs) — một chất ô nhiễm môi trường. Ăn cá nhiễm nhiều thủy ngân methyl trong thai kỳ có liên quan đến tổn thương não và chậm phát triển ở trẻ.

- Ăn 2–3 khẩu phần mỗi tuần các loại cá ít thủy ngân là an toàn và được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai.
- March of Dimes khuyến cáo phụ nữ mang thai tránh mọi loại cá sống và cá áp chảo tái. Cá sống bao gồm sushi và sashimi, cá chưa nấu chín kỹ, và hải sản có vỏ chưa chín kỹ (như hàu, ngao, trai, sò điệp tái).
- Tránh cá mập, cá kiếm, cá thu vua và cá ngói (tile fish) kể cả khi đã nấu chín, vì chúng chứa nhiều thủy ngân hơn.
- March of Dimes cảnh báo không nên ăn các loại cá có thể chứa hàm lượng PCBs cao hơn, gồm: cá xanh (blue fish), cá vược, cá hồi nước ngọt, cá chó (pike), cá hương (trout) và cá walleye.

Để biết thêm về các loại cá an toàn, truy cập trang web của CDC hoặc March of Dimes.

Tôi nên tăng bao nhiêu cân?

Tăng cân hợp lý trong thai kỳ nhờ chế độ ăn cân đối là dấu hiệu tốt cho thấy em bé đang nhận đủ dưỡng chất và lớn với tốc độ khỏe mạnh.

Cân nặng nên tăng chậm và đều. Nhìn chung, bạn nên tăng khoảng 2–4 pound (~1–1,8 kg) trong 3 tháng đầu, và mỗi tuần 1 pound (~0,45 kg) trong phần còn lại của thai kỳ. Người có cân nặng bình thường trước mang thai thường tăng 15–35 pound (~7–16 kg) trong cả thai kỳ. Bạn có thể cần tăng nhiều hay ít hơn tùy việc bạn nhẹ cân hay thừa cân khi bắt đầu mang thai. Khuyến nghị cũng khác nếu bạn mang đa thai.

Số cân tăng thêm "đi đâu"?

- Em bé: 6–8 pound (~2,7–3,6 kg).
- Bánh rau: 2–3 pound (~0,9–1,4 kg).
- Lượng máu tăng thêm: 3–4 pound (~1,4–1,8 kg).

- Nước ối: 2–3 pound (~0,9–1,4 kg).
- Mô vú: 0–3 pound (~0–1,4 kg).
- Mô dự trữ cho cuộc sinh và cho con bú (phần cân nặng còn lại).
- Tử cung to lên: 2–5 pound (~0,9–2,3 kg).

Tổng cộng: 15–35 pound (~7–16 kg).

Nếu tôi tăng cân quá nhiều thì sao?

Hãy cố đưa cân nặng về đúng hướng. Đừng nghĩ đến việc giảm cân hay ngừng hẳn tăng cân; thay vào đó, hãy làm chậm đà tăng về mức khuyến nghị theo từng giai đoạn. Trong 3 tháng đầu, bạn nên tăng tổng cộng 2–4 pound (~1–1,8 kg); 3 tháng giữa và 3 tháng cuối, mỗi tuần nên tăng 1 pound (~0,45 kg). Hãy thử các thay đổi sau để tăng cân chậm lại:

- Ăn đúng khẩu phần và tránh lấy thêm đồ ăn lần hai.
- Chọn sản phẩm sữa ít béo.
- Tập luyện: cân nhắc đi bộ hoặc bơi vào hầu hết các ngày trong tuần.
- Dùng cách chế biến ít dầu mỡ.
- Hạn chế đồ ngọt và đồ ăn vặt nhiều calo.
- Hạn chế đồ uống ngọt, nhiều đường.

Nếu tôi tăng cân không đủ thì sao?

Mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng tăng cân với tốc độ như nhau. Hãy trao đổi với bác sĩ nếu bạn lo lắng mình tăng cân chưa đủ. Buồn nôn và nghén có thể cản trở việc tăng cân (xem gợi ý ở phần "Khi không khỏe thì nên ăn gì"). Nôn quá nhiều có thể là biểu hiện của chứng nôn nghén nặng (hyperemesis gravidarum) — bạn cần trao đổi với bác sĩ.

Hãy thử các thay đổi sau để tăng cân trong khoảng phù hợp:

- Ăn nhiều bữa hơn: thử ăn 5–6 bữa mỗi ngày.
- Chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng và giàu năng lượng như trái cây sấy, các loại hạt, bánh quy giòn phết bơ lạc, kem.
- Thêm một chút phô mai, mật ong, bơ thực vật hoặc đường vào món ăn.

Khi không khỏe thì tôi có thể ăn gì?

Triệu chứng thai nghén rất đa dạng. Có người khổ sở vì nghén, người khác vì tiêu chảy hoặc táo bón. Dưới đây là vài gợi ý ứng phó. Bạn cũng có thể xem mục "Hướng dẫn dùng thuốc trong thai kỳ" của cuốn sách này để biết các thuốc không kê đơn an toàn giúp giảm triệu chứng.

Nghén (buồn nôn buổi sáng): Thử ăn bánh quy giòn, ngũ cốc hoặc bánh quy xoắn (pretzel) trước khi ra khỏi giường. Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Tránh đồ béo, đồ chiên rán.

Táo bón: Tăng chất xơ bằng ngũ cốc giàu xơ, trái cây và rau tươi. Nhớ uống đủ nước — ít nhất 10–12 cốc mỗi ngày.

Tiêu chảy: Tăng các thực phẩm chứa pectin và chất xơ dạng gom để hút bớt nước thừa. Lựa chọn tốt gồm sốt táo, chuối, cơm trắng, yến mạch và bánh mì lúa mì tinh chế.

Ợ nóng: Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, ăn chậm nhai kỹ, tránh món cay, món nhiều dầu mỡ và caffeine. Uống nước giữa các bữa và hạn chế uống trong bữa. Cố gắng không nằm ngay sau khi ăn; khi nằm hãy kê cao đầu. Xem mục "Hướng dẫn dùng thuốc trong thai kỳ" để biết các thuốc trị ợ nóng an toàn.

Thèm ăn có bình thường không?

Nhiều phụ nữ thèm ăn khi mang thai, nhưng cũng có người không. Nếu bạn thèm món nào đó, chiều theo cơn thèm cũng không sao, miễn là vẫn nằm trong chế độ ăn lành mạnh và không quá thường xuyên.

Nếu bạn thèm những thứ không phải thực phẩm như nước đá, bột giặt, đất, đất sét, tro hay vụn sơn, bạn có thể mắc hội chứng pica (thèm ăn dị vật). Hãy trao đổi ngay với bác sĩ. Ăn những thứ không phải thực phẩm có thể gây hại cho bạn và em bé, và có thể là dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng.

Chăm sóc răng miệng trong thai kỳ

Chăm sóc tốt sức khỏe răng miệng khi mang thai là điều hết sức quan trọng. Thai kỳ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về lợi.

Sức khỏe răng miệng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi; nhiễm trùng răng miệng có liên quan đến chuyển dạ sinh non.

Dưới đây là một số gợi ý để giữ gìn sức khỏe răng miệng của bạn cũng như sức khỏe và sự an toàn của em bé trước, trong và sau thai kỳ.

Khi bạn đang mang thai

- Báo cho nha sĩ biết nếu bạn biết mình có thai, để họ lên kế hoạch điều trị hay thủ thuật phù hợp. Tốt nhất là hoàn tất mọi điều trị nha khoa lớn trước khi mang thai. Còn chăm sóc răng thông thường có thể thực hiện trong 3 tháng giữa. Để thận trọng, nên tránh tối đa các điều trị nha khoa trong 3 tháng đầu và nửa sau của 3 tháng cuối — đây là các giai đoạn then chốt trong sự tăng trưởng và phát triển của bé, nên khôn ngoan nhất là tránh cho mẹ tiếp xúc với các thủ thuật có thể ảnh hưởng đến quá trình đó. Mọi thủ thuật nha khoa không cấp thiết nên hoãn đến sau sinh.
- Cho nha sĩ biết tên và liều lượng của tất cả thuốc bạn đang dùng (kể cả thuốc và vitamin bà bầu do bác sĩ kê) cũng như mọi lời dặn cụ thể của bác sĩ. Nha sĩ có thể phải điều chỉnh kế hoạch điều trị dựa trên thông tin này. Một số thuốc, như tetracycline, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển răng của trẻ và không được dùng trong thai kỳ.
- Tránh chụp X-quang răng khi mang thai. Nếu bắt buộc phải chụp, nha sĩ sẽ dùng tấm chắn bảo vệ bạn và em bé. Nhờ tiến bộ của nha khoa, chụp X-quang ngày nay an toàn hơn nhiều so với các thập kỷ trước.
- Đừng bỏ lịch khám răng định kỳ chỉ vì bạn đang mang thai.
- Giữ vệ sinh răng miệng tốt để phòng ngừa và/hoặc giảm các vấn đề về lợi: đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày và dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần mỗi ngày. Dùng bàn chải lông mềm, chất lượng tốt. Dùng kem đánh răng có fluoride và chải ít nhất 2 phút để loại bỏ mảng bám.
- Nếu nghén khiến bạn không đánh răng được, hãy đổi sang loại kem đánh răng vị dịu nhẹ trong thai kỳ. Nhờ nha sĩ hoặc chuyên viên vệ sinh răng gợi ý nhãn hiệu.
- Súc miệng bằng nước lọc hoặc nước súc miệng nếu bạn bị nghén và nôn nhiều.
- Hỏi nha sĩ về nhu cầu bổ sung fluoride. Vì fluoride đã có trong nước máy và hầu hết các loại kem đánh răng, việc bổ sung có thể không cần thiết.
- Tránh đồ ăn vặt ngọt. Thèm ngọt là chuyện thường gặp khi mang thai, nhưng hãy nhớ: ăn vặt càng nhiều, nguy cơ sâu răng càng cao. Ngoài ra, một số vi khuẩn gây sâu răng có thể truyền từ mẹ sang con, nên hãy cẩn thận với những gì bạn ăn.

- Ăn uống cân đối, lành mạnh. Những chiếc răng đầu tiên của bé bắt đầu hình thành từ khoảng tháng thứ ba của thai kỳ. Chế độ ăn lành mạnh có sữa, phô mai và sữa chua là nguồn khoáng chất thiết yếu, tốt cho răng, lợi và xương đang phát triển của bé.
- Trao đổi với nha sĩ hoặc bác sĩ về nhu cầu gây tê hoặc dùng thuốc nếu xảy ra cấp cứu nha khoa. Hãy nói với mọi nhân viên y tế mà bạn gặp rằng bạn đang mang thai — thông tin này có thể thay đổi kế hoạch điều trị của họ.
- Nếu bạn gặp vấn đề về lợi trong thai kỳ, như viêm lợi hoặc "u lợi thai nghén" (pregnancy tumor — một khối tăng sinh lành tính ở lợi), hãy đi khám nha sĩ sớm sau sinh để được kiểm tra toàn bộ khoang miệng và đánh giá sức khỏe nha chu.

Chăm sóc sản khoa trọn gói ("global")

Hầu hết các hãng bảo hiểm thương mại chỉ trả cho chăm sóc sản khoa theo hình thức trọn gói ("global"). Mỗi chương trình bảo hiểm mỗi khác, vì vậy bạn rất nên xem kỹ quyền lợi của mình để biết những gì được và không được chi trả. Phần chi phí tự trả phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm của bạn.

Với các chương trình bảo hiểm không bao gồm dịch vụ sản khoa, bạn sẽ làm việc với chuyên viên tư vấn tài chính của Cleveland Clinic, người sẽ hướng dẫn bạn về trách nhiệm tài chính của mình.

Chăm sóc sản khoa trọn gói bao gồm toàn bộ dịch vụ cung cấp cho người bệnh trong một thai kỳ không biến chứng: chăm sóc trước sinh thường quy, cuộc sinh và chăm sóc sau sinh.

Dịch vụ trước sinh gồm:

- Khám hằng tháng đến tuần 28 (khoảng 5–6 lần).
- Khám 2 tuần một lần từ tuần 28 đến 36 (khoảng 4 lần).
- Khám hằng tuần từ tuần 36 đến khi sinh (khoảng 3–4 lần).
- Hỏi bệnh và khám thực thể lần đầu và các lần sau.
- Tổng phân tích nước tiểu thường quy.

Dịch vụ sinh gồm:

- Nhập viện.
- Hỏi bệnh và khám thực thể khi nhập viện.
- Theo dõi, xử trí cuộc chuyển dạ không biến chứng.
- Đỡ đẻ (sinh thường đường âm đạo hoặc mổ lấy thai).
- Sơ rau.
- Toàn bộ chăm sóc nội trú thường quy sau sinh.

Xét nghiệm HIV

HIV là gì?

HIV là viết tắt của human immunodeficiency virus — vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người, tác nhân gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Vi-rút này làm suy yếu khả năng chống lại nhiễm trùng và ung thư của cơ thể. Một người có thể nhiễm HIV khi tiếp xúc với dịch cơ thể của người mang vi-rút (bao gồm máu, tinh dịch, dịch âm đạo và sữa mẹ). HIV có thể lây qua:

- Quan hệ tình dục đường âm đạo, đường miệng hoặc hậu môn.
- Dùng chung bơm kim tiêm không sạch khi tiêm chích.
- Mang thai (truyền từ mẹ sang con).
- Truyền máu. (Từ năm 1985, máu hiến đã được xét nghiệm HIV thường quy, nên lây nhiễm qua truyền máu rất hiếm.)

Về xét nghiệm

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị sàng lọc HIV thường quy cho mọi người bệnh từ 13 đến 64 tuổi ở tất cả các cơ sở y tế. Chúng tôi sẽ chỉ định xét nghiệm HIV cho bạn trong bộ xét nghiệm máu thường quy. Kết quả được lưu trong hồ sơ bệnh án và được bảo mật như mọi phần khác của hồ sơ. Nếu không muốn làm xét nghiệm HIV, bạn cần báo cho chúng tôi trước khi lấy máu.

Do tính chất nghiêm trọng của nhiễm HIV và khả năng thành công cao trong dự phòng lây truyền chu sinh, việc xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, Cơ quan Y tế Công cộng Hoa Kỳ đã khuyến nghị xét nghiệm HIV cho mọi phụ nữ mang thai từ năm 1995.

- Nếu bạn mang thai và dương tính với HIV, điều then chốt là bạn phải dùng thuốc để bảo vệ thai nhi khỏi bị lây nhiễm.
- Nếu phát hiện nhiễm HIV, nhân viên y tế có thể chăm sóc bạn phù hợp hơn. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách giữ sức khỏe lâu dài hơn.
- Xét nghiệm HIV giúp ngăn ngừa lây lan HIV.

Tôi có bắt buộc phải xét nghiệm không?

Không. Tại bang Ohio, xét nghiệm HIV là tự nguyện, do bạn và người chăm sóc y tế cùng quyết định. Tại bang Florida, luật yêu cầu người chăm sóc y tế phải chỉ định xét nghiệm, nhưng người bệnh có quyền từ chối.

Quyết định xét nghiệm hay không, cũng như kết quả xét nghiệm, đều không ảnh hưởng đến việc bạn được chăm sóc y tế. Xin lưu ý: nếu bạn chọn không xét nghiệm HIV trong thai kỳ, luật bang bắt buộc em bé phải được sàng lọc HIV sau sinh. Do đó, nếu bạn có kết quả âm tính trong thai kỳ, nhiều khả năng bé sẽ không phải xét nghiệm sau sinh. Ngoài ra, nếu chưa rõ bạn có nhiễm HIV hay không, việc cho con bú — một phần quan trọng của chăm sóc trẻ — có thể bị trì hoãn. Tại Việt Nam, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai được khuyến khích và có thể làm tại các cơ sở y tế công (bệnh viện

sản, trung tâm y tế, cơ sở phòng chống HIV/AIDS), nhiều nơi miễn phí và được bảo mật. Hãy hỏi bác sĩ sản khoa nơi bạn khám thai để được tư vấn và xét nghiệm.

Kết quả âm tính nghĩa là gì?

Kết quả âm tính nghĩa là không tìm thấy dấu hiệu nhiễm HIV trong máu của bạn.

Hiếm khi, xét nghiệm có thể âm tính dù bạn đã nhiễm HIV. Điều này xảy ra nếu bạn mới nhiễm vi-rút gần đây. Vì vậy, nếu bạn có nguy cơ tiếp tục phơi nhiễm HIV hoặc có thể mới phơi nhiễm, bạn nên xét nghiệm lại sau 2–3 tháng.

Tiêm vắc-xin trong thai kỳ

Vì sao cần tiêm vắc-xin?

Vắc-xin giúp tăng cường hệ miễn dịch để cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Vắc-xin cũng có lợi cho cộng đồng bằng cách ngăn ngừa lây lan bệnh truyền nhiễm.

Vì sao phụ nữ mang thai cần tiêm vắc-xin?

Nhiều phụ nữ có thể không biết mình đã tiêm chủng chưa đầy đủ và dễ mắc những bệnh có thể gây hại cho bản thân hoặc thai nhi. Phụ nữ mang thai nên trao đổi với bác sĩ để biết cần tiêm những vắc-xin nào, và nên tiêm trong thai kỳ hay chờ đến sau khi sinh.

Làm sao biết thành phần vắc-xin có an toàn không?

Mọi vắc-xin đều được kiểm định độ an toàn dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Vắc-xin được kiểm tra độ tinh khiết, hiệu lực và an toàn; FDA và CDC theo dõi độ an toàn của từng vắc-xin trong suốt thời gian lưu hành. Một số người có thể dị ứng với thành phần trong vắc-xin, chẳng hạn trứng trong vắc-xin cúm, và không nên tiêm cho đến khi trao đổi với bác sĩ.

Vắc-xin có thể gây hại cho thai nhi không?

Một số vắc-xin, đặc biệt là vắc-xin vi-rút sống giảm độc lực, không nên tiêm cho phụ nữ mang thai vì có thể gây hại cho em bé. (Vắc-xin vi-rút sống được làm từ chủng vi-rút sống.) Một số vắc-xin có thể tiêm cho mẹ trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối, số khác chỉ nên tiêm từ 1 đến 3 tháng trước khi thụ thai hoặc ngay sau khi bé chào đời. Những vắc-xin được tiêm trong thai kỳ, như vắc-xin cúm, được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai.

Nếu tôi phơi nhiễm bệnh khi đang mang thai thì sao?

Tùy hoàn cảnh, bác sĩ sẽ cân nhắc nguy cơ của việc tiêm vắc-xin so với lợi ích mà vắc-xin mang lại.

Khi mang thai tôi nên tiêm những vắc-xin nào?

Các vắc-xin sau được coi là an toàn để tiêm cho phụ nữ có nguy cơ nhiễm bệnh:

COVID-19: Vắc-xin này có thể phòng bệnh nặng cho mẹ trong thai kỳ. Bạn có thể tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. CDC khuyến nghị mọi phụ nữ mang thai tiêm vắc-xin COVID-19.

Viêm gan B: Phụ nữ mang thai thuộc nhóm nguy cơ cao và có kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút có thể tiêm vắc-xin này, giúp bảo vệ mẹ và bé khỏi lây nhiễm cả trước và sau sinh.

Cúm (Influenza): Vắc-xin này có thể phòng bệnh nặng cho mẹ trong thai kỳ. Bạn có thể tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào. CDC khuyến nghị mọi phụ nữ mang thai tiêm vắc-xin cúm.

Uốn ván/Bạch hầu/Ho gà (Tdap): Nên tiêm Tdap trong thai kỳ, tốt nhất là trong 3 tháng cuối (sau 20 tuần thai). Nếu bạn hoặc người thân trong gia đình chưa tiêm trong thai kỳ, hãy tiêm Tdap ngay sau khi bé chào đời, khi bạn còn ở bệnh viện,

để bảo đảm miễn dịch với ho gà và giảm nguy cơ lây cho trẻ sơ sinh. CDC khuyến nghị mọi phụ nữ mang thai tiêm vắc-xin này.

Phụ nữ mang thai nên tránh những vắc-xin nào?

Các vắc-xin sau có thể lây truyền sang thai nhi và có thể gây sảy thai, sinh non hoặc dị tật bẩm sinh:

- **Viêm gan A:** Độ an toàn của vắc-xin này chưa được xác định nên cần tránh khi mang thai. Phụ nữ có nguy cơ phơi nhiễm cao nên trao đổi lợi ích và nguy cơ với bác sĩ.
- **Sởi - Quai bị - Rubella (MMR):** Phụ nữ nên chờ ít nhất một tháng sau khi tiêm các vắc-xin vi-rút sống này rồi mới mang thai. Nếu xét nghiệm rubella ban đầu cho thấy bạn chưa có miễn dịch, bạn sẽ được tiêm vắc-xin sau sinh.
- **Thủy đậu (Varicella):** Vắc-xin phòng thủy đậu này nên tiêm ít nhất một tháng trước khi mang thai.
- **Phế cầu (Pneumococcal):** Vì độ an toàn chưa rõ, nên tránh trong thai kỳ, trừ phụ nữ nguy cơ cao hoặc mắc bệnh mạn tính.
- **Vắc-xin bại liệt uống (OPV) và bất hoạt (IPV):** Cả hai loại đều không được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, nguy cơ mắc bại liệt ở Hoa Kỳ hiện rất thấp.

Sau tiêm có thể gặp tác dụng phụ gì?

Tác dụng phụ dao động từ không có gì đến những phản ứng có thể xuất hiện trong vòng 3 tuần sau tiêm. Nếu gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, hãy báo ngay cho bác sĩ. Tác dụng phụ có thể gồm:

- Mệt mỏi.
- Sốt.
- Đau đầu.
- Phát ban hoặc nổi mẩn đỏ không lây.
- Đau khớp.
- Phản ứng dị ứng nặng (rất hiếm).
- Đau và đỏ tại chỗ tiêm.
- Sưng hạch cổ và má.

Hãy xin tờ thông tin về vắc-xin bạn vừa tiêm, hoặc truy cập trang của CDC:

<http://www.cdc.gov/vaccines/spec-grps/pregnant.htm>.

Nếu tôi chưa từng bị thủy đậu thì sao?

Nếu đã từng bị thủy đậu, bạn đã có miễn dịch. Nếu chưa từng bị, nhiều khả năng bạn đã tiêm vắc-xin thủy đậu. Nếu chưa tiêm, bạn vẫn có thể có miễn dịch — xét nghiệm máu có thể xác định điều này. Nếu bạn chưa có miễn dịch và tiếp xúc với người đang mắc thủy đậu, hãy gọi cho phòng khám của bác sĩ để được hướng dẫn.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục và thai kỳ

Bệnh lây truyền qua đường tình dục (thường gọi là STI) là những bệnh lây do quan hệ tình dục với người mắc STI. STI lây qua các hoạt động tình dục liên quan đến miệng, hậu môn hoặc âm đạo.

Phụ nữ mang thai mắc STI có thể lây cho con trước, trong hoặc sau khi sinh. Vì vậy, nhân viên y tế sẽ sàng lọc phần lớn STI cho bạn ngay ở lần khám thai đầu tiên. Nếu bạn quan hệ với người nhiễm bệnh sau lần sàng lọc đầu, bạn sẽ cần xét nghiệm lại. Điều trị STI là cách tốt nhất để bảo vệ bạn và em bé.

STI bao gồm:

- Chlamydia.
- Herpes sinh dục.
- Lậu (gonorrhea).
- Viêm gan B.
- HIV/AIDS.
- HPV/mụn cóc sinh dục.
- Giang mai (syphilis).
- *Trichomonas vaginalis* ("trùng roi").

Triệu chứng của STI là gì?

Đôi khi không có triệu chứng nào. Nếu có, triệu chứng có thể gồm:

- Nốt sần, vết loét hoặc mụn cóc gần miệng, hậu môn, dương vật hoặc âm đạo.
- Sưng hoặc đỏ gần dương vật hoặc âm đạo.
- Phát ban da.
- Tiểu buốt.
- Sụt cân, đi ngoài phân lỏng, đổ mồ hôi đêm.
- Đau nhức, sốt và ớn lạnh.
- Vàng da (jaundice).
- Tiết dịch từ dương vật hoặc âm đạo (dịch âm đạo có thể có mùi).
- Ra máu âm đạo ngoài kỳ kinh nguyệt.
- Đau khi quan hệ.
- Ngứa nhiều gần dương vật hoặc âm đạo.

STI ảnh hưởng đến thai kỳ và lựa chọn điều trị như thế nào?

- **Chlamydia:** Thai kỳ dường như không bị ảnh hưởng bởi nhiễm Chlamydia. Tuy nhiên, trẻ phơi nhiễm khi sinh có thể bị nhiễm trùng mắt nặng hoặc viêm phổi. Mẹ mắc Chlamydia được điều trị bằng kháng sinh, và mọi trẻ sơ sinh đều được tra thuốc mỡ kháng sinh vào mắt sau sinh để phòng nhiễm trùng.
- **Herpes sinh dục:** Nhiễm herpes ở phụ nữ mang thai tương đối an toàn cho đến khi sắp sinh. Tổn thương

herpes đang hoạt động ở bộ phận sinh dục có khả năng lây và có thể truyền cho trẻ khi sinh. Vì vậy, nhiều phụ nữ được chỉ định mổ lấy thai. Có thể dùng thuốc kháng vi-rút, và có thể cần mổ lấy thai.

- **Lậu (Gonorrhea):** Nếu mắc trong thai kỳ, nhiễm trùng có thể gây loét miệng, sốt và nhiễm trùng máu. Em bé thường không bị ảnh hưởng, nhưng nếu bé sinh ra khi mẹ đang nhiễm hoạt động, bé có thể bị nhiễm trùng mắt hoặc mù, nhiễm trùng khớp hoặc nhiễm trùng máu. Mẹ mắc lậu được điều trị bằng kháng sinh, và mọi trẻ sơ sinh đều được tra thuốc mỡ kháng sinh vào mắt sau sinh để phòng nhiễm trùng.
- **Viêm gan B:** Đây là nhiễm trùng gan do vi-rút viêm gan B gây ra. Nếu phụ nữ mang thai nhiễm viêm gan B, họ có thể truyền cho thai nhi qua bánh rau, khiến trẻ sơ sinh bị nhiễm. Ngoài ra, phụ nữ mắc viêm gan B dễ sinh non hơn. Tuy nhiên, sàng lọc sớm và tiêm vắc-xin có thể ngăn ngừa những hậu quả xấu nhất. Nếu bạn mắc viêm gan B, bác sĩ sẽ tiêm cho trẻ sơ sinh kháng thể và vắc-xin để phòng lây nhiễm.
- **HIV/AIDS:** Nhờ các phác đồ thuốc mạnh, việc lây truyền HIV cho trẻ gần như hoàn toàn có thể phòng ngừa. Tuy nhiên, nếu bệnh vẫn lây, em bé có thể nhiễm HIV. Dù HIV/AIDS là bệnh không chữa khỏi, bạn vẫn có thể ngăn lây vi-rút sang con bằng cách dùng các thuốc theo chỉ định.
- **HPV/mụn cóc sinh dục:** Vi-rút u nhú ở người (HPV), có thể gây mụn cóc sinh dục, là một STI phổ biến, có thể biểu hiện bằng tổn thương hoặc hoàn toàn không triệu chứng. Nếu mắc mụn cóc sinh dục khi mang thai, việc điều trị có thể hoãn đến sau sinh. Cuộc sinh chỉ bị ảnh hưởng khi có mụn cóc sinh dục lớn; khi đó nhân viên y tế sẽ trao đổi phương án sinh với bạn.
- **Giang mai (Syphilis):** Giang mai rất dễ truyền sang thai nhi và có khả năng gây nhiễm trùng nặng dẫn đến tử vong. Trẻ không được điều trị có thể sinh non hoặc gặp vấn đề ở nhiều cơ quan: mắt, tai, tim, da và xương. Nhân viên y tế thường kê kháng sinh cho bạn trong thai kỳ để giảm nguy cơ lây cho em bé.
- ***Trichomonas vaginalis*:** Đây là ký sinh trùng gây tiết dịch âm đạo. Nếu không điều trị, trẻ có thể sinh non và nhẹ cân. Bệnh này dễ điều trị bằng kháng sinh.

Nếu được kê kháng sinh để điều trị STI, hãy uống hết liều dù triệu chứng đã hết. Không bao giờ dùng thuốc của người khác để điều trị bệnh của mình — làm vậy có thể khiến việc điều trị khó khăn hơn. Tương tự, bạn cũng không nên chia sẻ thuốc của mình cho người khác.

Làm sao để phòng tránh STI?

Dưới đây là một số bước cơ bản giúp bảo vệ bạn khỏi STI:

- Không quan hệ tình dục là cách duy nhất chắc chắn phòng được STI.
- Dùng bao cao su mỗi lần quan hệ. (Nếu dùng chất bôi trơn, hãy chọn loại gốc nước.)
- Hạn chế số lượng bạn tình.

- Chung thủy một vợ một chồng: chỉ quan hệ với một người, và người đó cũng chỉ quan hệ với bạn để giảm nguy cơ.
- Đi kiểm tra STI. Đừng để nguy cơ lây bệnh cho người khác hoặc cho con. Việc đã sàng lọc đầu thai kỳ không có nghĩa bạn không thể mắc STI về sau. Nếu bạn có quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ kể từ lần sàng lọc đầu, hãy đề nghị nhân viên y tế sàng lọc lại.
- Không dùng rượu hoặc ma túy trước khi quan hệ, nhất là khi mang thai — vì khi say hoặc "phê" bạn dễ quan hệ không an toàn hơn.
- Biết dấu hiệu và triệu chứng của STI. Hãy để ý ở cả bản thân và bạn tình.
- Tìm hiểu về STI. Càng hiểu rõ, bạn càng bảo vệ mình tốt hơn.
- Không quan hệ lại cho đến khi nhân viên y tế cho phép.
- Tái khám để được kiểm tra lại.
- Bảo đảm bạn tình cũng được điều trị.

Làm sao để ngăn lây lan STI?

- Ngừng quan hệ cho đến khi gặp nhân viên y tế và được điều trị.
- Tuân thủ hướng dẫn điều trị của nhân viên y tế.
- Dùng bao cao su mỗi lần quan hệ, nhất là với bạn tình mới.

Tìm hiểu thêm ở đâu?

Tại Việt Nam, bạn có thể khám và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các bệnh viện/chuyên khoa da liễu, bệnh viện sản phụ khoa hoặc trung tâm y tế địa phương. Hãy trao đổi thẳng thắn với bác sĩ sản khoa nơi bạn khám thai để được sàng lọc và điều trị kịp thời.

Hút thuốc ảnh hưởng đến bạn và em bé như thế nào

Hút thuốc khi mang thai ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và em bé cả trước, trong và sau khi bé chào đời. Nicotine (chất gây nghiện trong thuốc lá), carbon monoxide, chì, arsenic và nhiều chất độc khác bạn hít vào từ điếu thuốc sẽ theo máu đi thẳng đến em bé.

Hút thuốc khi mang thai sẽ:

- Giảm lượng oxy cung cấp cho bạn và em bé đang lớn.
- Tăng nguy cơ sảy thai, thai chết lưu và hội chứng đột tử ở trẻ nhũ nhi (SIDS).
- Tăng nguy cơ sinh non và/hoặc trẻ nhẹ cân.
- Tăng nguy cơ em bé mắc các vấn đề hô hấp.

Càng hút nhiều thuốc, nguy cơ em bé mắc các vấn đề này và các vấn đề sức khỏe khác càng cao. Không có mức hút thuốc nào là an toàn cho sức khỏe của em bé.

Dùng thuốc lá điện tử (vaping) khi mang thai cũng không an toàn. Hầu hết thuốc lá điện tử chứa nicotine, gây tổn thương vĩnh viễn cho não đang phát triển và nhiều cơ quan khác của em bé. Dung dịch thuốc lá điện tử còn chứa hóa chất, hương liệu và phụ gia khác có thể không an toàn cho bé.

Dùng cần sa khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ sinh con nhỏ hơn, và có thể tăng nhẹ nguy cơ thai chết lưu. Cần sa cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo không dùng cần sa khi mang thai.

Hút thuốc thụ động ảnh hưởng đến tôi và em bé thế nào?

Khói thuốc thụ động (còn gọi là hút thuốc bị động hoặc khói thuốc trong môi trường) là hỗn hợp khói từ điếu thuốc đang cháy và khói do người hút thở ra. Khói bốc lên từ đầu điếu thuốc lá hoặc xì gà chứa nhiều chất độc hại (hắc ín, carbon monoxide, nicotine và các chất khác) hơn cả khói mà người hút hít vào.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động, bạn làm tăng nguy cơ của mình và em bé mắc ung thư phổi, bệnh tim, khí phế thũng, dị ứng, hen suyễn và các vấn đề sức khỏe khác. Trẻ tiếp xúc khói thuốc thụ động cũng có thể bị giảm dung tích phổi và nguy cơ cao hơn mắc SIDS.

Nếu tôi tiếp tục hút thuốc sau khi sinh thì sao?

Nếu tiếp tục hút sau sinh, bạn có thể bị giảm nguồn sữa mẹ. Bạn cũng làm tăng nguy cơ bé mắc một số bệnh và vấn đề như:

- Cảm lạnh thường xuyên.
- Viêm phế quản và viêm phổi.
- Hen suyễn/khò khè.
- Ho mạn tính.
- Nhiễm trùng tai.
- Tăng huyết áp.

- Vấn đề học tập và hành vi về sau.
- Hội chứng đột tử ở trẻ nhũ nhi (SIDS).

Vì sao tôi nên bỏ thuốc?

Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh ở Hoa Kỳ. Bằng cách bỏ thuốc, bạn có thể:

- Kéo dài tuổi thọ.
- Giảm nguy cơ bệnh tim.
- Giảm nguy cơ ung thư phổi, họng, miệng, tụy và bàng quang.
- Giảm nguy cơ bệnh hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn và khí phế thũng.
- Giảm nguy cơ dị ứng.
- Tăng mức năng lượng.
- Cải thiện ngoại hình: da ít nếp nhăn hơn, đẹp hơn; ngón tay và răng không bị ố vàng.
- Cải thiện khứu giác và vị giác.
- Cảm thấy khỏe hơn nói chung, tự tin hơn.
- Tiết kiệm nhiều tiền (trung bình người hút thuốc tốn khoảng 2.000 đô-la mỗi năm cho thuốc lá).

Làm sao để bỏ thuốc?

Không có cách bỏ thuốc nào phù hợp cho tất cả mọi người, vì thói quen hút của mỗi người mỗi khác. Dưới đây là vài gợi ý:

- Cất diêm, bật lửa và gạt tàn đi.
- Quy định nhà bạn là khu vực không hút thuốc.
- Đề nghị người khác không hút thuốc quanh bạn.
- Giảm caffeine — điều này giúp giảm cơn thèm thuốc. Tránh rượu, vì rượu cũng có thể làm tăng cơn thèm và gây hại cho em bé.
- Thay đổi những thói quen gắn với hút thuốc. Nếu bạn hay hút khi lái xe hoặc khi căng thẳng, hãy thử hoạt động khác thay thế.
- Để sẵn kẹo bạc hà hoặc kẹo cao su (tốt nhất là loại không đường) cho những lúc lên cơn thèm.
- Giữ mình bận rộn để quên đi thuốc lá và giải tỏa căng thẳng: đi bộ, tập thể dục hoặc đọc sách.
- Tránh nơi có nhiều người hút thuốc.

Hãy tìm sự hỗ trợ từ người khác. Tại Việt Nam, bạn có thể nhờ bác sĩ tư vấn cai thuốc lá, hoặc liên hệ các cơ sở/chương trình tư vấn cai nghiện thuốc lá ở bệnh viện (nhiều bệnh viện lớn có phòng tư vấn cai thuốc). Người thân cùng bỏ thuốc và tránh hút thuốc trong nhà sẽ giúp bạn thành công hơn.

Tôi có nên dùng liệu pháp thay thế nicotine không?

Hãy trao đổi với nhân viên y tế xem liệu pháp thay thế nicotine có phù hợp với bạn không.

Tôi sẽ cảm thấy thế nào khi bỏ thuốc?

Lợi ích của việc không hút thuốc bắt đầu ngay trong vài ngày sau khi bỏ. Sau khi cai, nhịp tim của bạn và em bé trở lại bình thường, và bé ít có nguy cơ mắc vấn đề hô hấp hơn.

Bạn có thể gặp các triệu chứng cai vì cơ thể đã quen với nicotine — chất gây nghiện trong thuốc lá. Bạn có thể thèm thuốc, cáu gắt, mệt mỏi, đói cồn cào, ho nhiều, đau đầu hoặc khó tập trung.

Các triệu chứng cai chỉ là tạm thời. Chúng mạnh nhất khi bạn mới bỏ nhưng sẽ hết trong vòng 10–14 ngày. Khi triệu chứng cai xuất hiện, hãy giữ vững quyết tâm. Nghĩ về lý do bạn muốn bỏ thuốc. Nhắc mình rằng đây là dấu hiệu cơ thể đang hồi phục và làm quen với việc không có thuốc lá. Hãy nhớ, triệu chứng cai dễ điều trị hơn nhiều so với những căn bệnh nặng mà thuốc lá gây ra.

Kể cả sau khi hết cai, bạn vẫn có thể thỉnh thoảng lên cơn thèm. Nhưng những cơn thèm này thường ngắn và sẽ qua, dù bạn có hút hay không. Đừng hút thuốc.

Nếu bạn hút lại (tái nghiện), đừng nản lòng. 75% người bỏ thuốc từng tái nghiện; hầu hết phải bỏ đến ba lần mới thành công. Nếu tái nghiện, đừng bỏ cuộc — hãy lên kế hoạch và nghĩ trước xem lần tới lên cơn thèm bạn sẽ làm gì.

Tăng huyết áp trong thai kỳ

Trong thai kỳ, tăng huyết áp có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo cách khác với bình thường. Tăng huyết áp, nhất là khi không được kiểm soát tốt, có thể gây biến chứng thai kỳ cho cả mẹ và bé.

Tăng huyết áp là gì?

Huyết áp là lực máu đẩy vào thành mạch. Tim bơm máu vào các động mạch (mạch máu) đưa máu đi khắp cơ thể. Tăng huyết áp nghĩa là áp lực trong động mạch cao hơn mức bình thường.

Có những dạng tăng huyết áp nào trong thai kỳ?

Tăng huyết áp gặp ở khoảng 10% các thai kỳ. Có nhiều dạng khác nhau, khác nhau về mức độ nặng và tác động lên cơ thể cũng như thai kỳ. Các dạng gồm:

- **Tăng huyết áp mạn tính:** huyết áp cao đã có từ trước khi mang thai.
- **Tăng huyết áp thai kỳ:** huyết áp cao xuất hiện lần đầu từ tuần thứ 20 trở đi, nhưng không có dấu hiệu hay triệu chứng nào khác của tiền sản giật. Một số phụ nữ về sau tiến triển thành tiền sản giật, số khác có lẽ đã bị tăng huyết áp mạn tính từ trước.
- **Tiền sản giật (preeclampsia):** một tình trạng chỉ gặp trong thai kỳ, thường sau tuần 20. Tiền sản giật là tăng huyết áp, điển hình kèm protein niệu. Nó có thể gây biến chứng ở thận, gan và các cơ quan khác, và có thể liên quan đến co giật (sản giật – eclampsia). Tiền sản giật cũng có thể ảnh hưởng đến bánh rau, dẫn đến thai nhỏ.
- **Tăng huyết áp mạn tính có tiền sản giật ghép thêm:** tiền sản giật xuất hiện ở người vốn đã bị tăng huyết áp mạn tính (huyết áp cao trước khi mang thai).

Ai có nguy cơ cao bị tiền sản giật?

Một phụ nữ dễ bị tiền sản giật hơn nếu đây là lần mang thai đầu, mang đa thai, hoặc từng bị tiền sản giật ở lần mang thai trước.

Nguy cơ cũng cao hơn nếu bạn có các yếu tố sau:

- Tăng huyết áp mạn tính (huyết áp cao trước khi mang thai).
- Đái tháo đường trước khi mang thai.
- Đái tháo đường thai kỳ.
- Rối loạn đông máu.
- Lupus.
- Béo phì với BMI > 30.
- Hội chứng kháng thể kháng phospholipid.
- Tuổi mẹ từ 35 trở lên.
- Từng bị tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật ở lần mang thai trước.
- Tiền sử gia đình bị tăng huyết áp thai kỳ.

- Bệnh thận.
- Có thai bằng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
- Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Dấu hiệu và triệu chứng của tiền sản giật?

- Hai lần đo cách nhau ít nhất 4 giờ đều tăng huyết áp: huyết áp tâm thu từ 140 mmHg trở lên, hoặc tâm trương từ 90 mmHg trở lên.
- Có protein trong nước tiểu.
- Tiểu cầu thấp.
- Vấn đề về thận.
- Vấn đề về gan.
- Có dịch trong phổi.
- Đau đầu mới, dai dẳng không dứt.
- Nhìn thấy đốm đen bay hoặc lóe sáng (floaters/flashers).

Tăng huyết áp trong thai kỳ nguy hiểm ra sao?

Tăng huyết áp trong thai kỳ có thể khiến bánh rau không nhận đủ máu, oxy và dưỡng chất. Lượng máu đến bánh rau giảm có thể dẫn đến trẻ nhẹ cân. Các biến chứng khác cũng có thể xảy ra (không phải ai bị tăng huyết áp cũng gặp), bao gồm:

- Co giật ở người mẹ.
- Đột quỵ.
- Suy thận tạm thời.
- Vấn đề về gan.
- Thai chậm phát triển.
- Thiếu ối (ít nước ối quanh thai).
- Rau bong non (bánh rau tách khỏi thành tử cung).
- Sinh non.

Có thể phòng ngừa tăng huyết áp trong thai kỳ không?

Vì chưa rõ nguyên nhân, tăng huyết áp trong thai kỳ thường không thể phòng ngừa hoàn toàn. Với phụ nữ nguy cơ cao bị tiền sản giật, dùng aspirin liều thấp (baby aspirin) hằng ngày để dự phòng được khuyến nghị. Tăng huyết áp trong thai kỳ đôi khi có thể được theo dõi và kiểm soát với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Tuy nhiên, đôi khi tiền sản giật buộc phải cho sinh. Huyết áp của bạn sẽ được kiểm tra định kỳ trong các buổi khám thai. Nếu có bất kỳ lo lắng nào về huyết áp, hãy trao đổi với nhân viên y tế.

Sau sinh tôi còn bị tăng huyết áp không?

Tăng huyết áp trong thai kỳ thường hết sau sinh, nhưng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim về sau. Phụ nữ vốn bị tăng huyết áp mạn tính từ trước thường vẫn còn bệnh sau sinh. Đôi khi huyết áp vẫn cao sau sinh và cần điều trị bằng thuốc. Nhân viên y tế sẽ đồng hành với bạn sau thai kỳ để kiểm soát huyết áp.

References

- ACOG Practice Bulletin Number 222. June 2020: Gestational Hypertension and Preeclampsia.

- U.S. Department of Health & Human Services, Office on Women's Health. Pregnancy Complications. Accessed 1/22/2019.
- March of Dimes. High Blood Pressure During Pregnancy. Accessed 1/22/2019.

Đái tháo đường thai kỳ

Đái tháo đường thai kỳ là gì?

Đái tháo đường thai kỳ là tình trạng không dung nạp carbohydrate xuất hiện trong thai kỳ, có thể dẫn đến đường huyết (glucose) cao. Khoảng 2–10% phụ nữ mang thai ở Hoa Kỳ được chẩn đoán mắc đái tháo đường thai kỳ.

Tôi có nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ không?

Các yếu tố sau làm tăng nguy cơ mắc bệnh trong thai kỳ:

- Thừa cân hoặc béo phì trước khi mang thai.
- Tiền sử gia đình mắc đái tháo đường (cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc bệnh).
- Trên 25 tuổi.
- Từng sinh con nặng hơn 9 pound (~4 kg).
- Từng sinh con chết lưu.
- Từng bị đái tháo đường thai kỳ ở lần mang thai trước.
- Được chẩn đoán tiền đái tháo đường.
- Mắc hội chứng buồng trứng đa nang.
- Là người gốc Phi, gốc Tây Ban Nha/Latinh, gốc Á, người Mỹ bản địa hoặc người đảo Thái Bình Dương.
- Tăng huyết áp trước khi mang thai.
- Cholesterol cao trước khi mang thai.

Hãy nhớ rằng một nửa số phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ không có yếu tố nguy cơ nào rõ ràng.

Nguyên nhân gây đái tháo đường thai kỳ?

Đái tháo đường thai kỳ do một số thay đổi nội tiết xảy ra ở mọi phụ nữ khi mang thai. Bánh rau là cơ quan nối em bé (qua dây rốn) với tử cung và chuyển dưỡng chất từ mẹ sang con. Nồng độ tăng của một số nội tiết tố do bánh rau tạo ra có thể cản trở insulin — nội tiết tố kiểm soát đường huyết — hoạt động bình thường. Tình trạng này gọi là đề kháng insulin. Khi bánh rau lớn dần lên, nó tạo nhiều nội tiết tố hơn và làm tăng đề kháng insulin; khi đó cần nhiều insulin hơn để giữ đường huyết trong ngưỡng an toàn.

Thông thường, tụy của người mẹ có thể tạo thêm insulin (khoảng gấp 3 lần bình thường) để vượt qua đề kháng insulin. Nếu không đủ, đường huyết sẽ tăng và dẫn đến đái tháo đường thai kỳ.

Đái tháo đường thai kỳ được chẩn đoán thế nào?

Đái tháo đường thai kỳ thường được chẩn đoán trong khoảng tuần 24–28 (thời điểm đề kháng insulin thường bắt đầu). Nếu bạn từng bị đái tháo đường thai kỳ hoặc có yếu tố nguy cơ, xét nghiệm có thể làm trước tuần 13. Nếu kết quả sớm bình thường, bạn sẽ được xét nghiệm lại khoảng tuần 28.

Để sàng lọc, bạn sẽ làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống: uống nhanh một dung dịch ngọt chứa 50g glucose. Cơ thể hấp thu nhanh, khiến đường huyết tăng trong vòng 30–60 phút. Khoảng 60 phút sau khi uống, một

mẫu máu sẽ được lấy từ tĩnh mạch ở tay để đo cách cơ thể xử lý dung dịch glucose.

Nếu kết quả bất thường, bạn sẽ làm một xét nghiệm tương tự nhưng phải nhịn ăn 6–8 giờ trước đó. Bạn sẽ được lấy máu khi đến phòng xét nghiệm, sau đó uống nhanh dung dịch ngọt và đo đường huyết lúc 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ sau. Nếu từ hai giá trị trở lên vượt ngưỡng mục tiêu, bạn bị đái tháo đường thai kỳ.

Đái tháo đường thai kỳ được kiểm soát thế nào?

Đái tháo đường thai kỳ được kiểm soát bằng cách:

- Kiểm tra đường huyết lúc đói buổi sáng và 1 giờ sau khi bắt đầu mỗi bữa ăn.
- Tuân theo hướng dẫn ăn uống cụ thể từ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên viên giáo dục đái tháo đường.
- Tập luyện.
- Dùng insulin nếu cần.

Tôi theo dõi đường huyết thế nào?

Kiểm tra đường huyết vào những thời điểm nhất định trong ngày giúp xác định chế độ tập luyện và ăn uống có giữ được đường huyết trong tầm kiểm soát hay không, hoặc bạn có cần dùng insulin để bảo vệ em bé không. Bác sĩ sẽ hướng dẫn khi nào và bao lâu bạn cần đo đường huyết.

Bạn có thể được dặn kiểm tra đường huyết:

- Khi thức dậy buổi sáng (lúc đói).
- Ngay trước các bữa ăn.
- 1 giờ sau khi bắt đầu mỗi bữa ăn.

Mục tiêu đường huyết: lúc đói 70–95 mg/dL; sau khi bắt đầu mỗi bữa ăn 1 giờ < 140 mg/dL.

Các bước đo đường huyết gồm:

- Chích đầu ngón tay bằng kim chích (lancet — kim nhỏ, sắc).
- Nhỏ một giọt máu lên que thử.
- Dùng máy đo đường huyết để hiển thị kết quả.
- Ghi kết quả vào sổ theo dõi.
- Bỏ kim và que thử đúng cách (vào hộp đựng vật sắc nhọn đã qua sử dụng hoặc hộp nhựa cứng như chai nước giặt).

Bác sĩ, điều dưỡng hoặc chuyên viên giáo dục đái tháo đường sẽ hướng dẫn bạn dùng máy đo. Hãy mang sổ theo dõi đường huyết đến các buổi khám và gửi cho bác sĩ đang điều trị đái tháo đường hằng tuần. Bác sĩ sẽ đánh giá mức kiểm soát và quyết định có cần điều chỉnh phác đồ không. Hãy nhớ, khi bánh rau lớn lên và tạo nhiều nội tiết tố hơn, bạn có thể cần nhiều insulin hơn để giữ đường huyết bình thường.

Mục tiêu của việc theo dõi là giữ đường huyết càng gần bình thường càng tốt. Đường huyết càng cao và càng thường xuyên cao, nguy cơ biến chứng thai kỳ càng lớn. Dùng insulin trong thai kỳ an toàn hơn nhiều cho bạn và em bé so với để đường huyết cao.

Chế độ ăn thay đổi thế nào nếu tôi bị đái tháo đường thai kỳ?

Một số mục tiêu ăn uống lành mạnh trong thai kỳ khi bị đái tháo đường thai kỳ:

- Ăn 3 bữa nhỏ và 2-3 bữa phụ vào giờ cố định mỗi ngày. Không bỏ bữa chính hoặc bữa phụ.
- Ăn ít carbohydrate vào bữa sáng hơn các bữa khác, vì đề kháng insulin cao nhất vào lúc này.
- Cố gắng ăn lượng carbohydrate như nhau ở mỗi bữa chính và bữa phụ. Khuyến nghị: 15-30g carbohydrate bữa sáng, 30-45g bữa trưa, 45-60g bữa tối và 15-30g cho bữa phụ.
- Luôn ăn carbohydrate kèm với đạm hoặc chất béo.
- Chọn thực phẩm giàu chất xơ như bánh mì, ngũ cốc, mì, gạo nguyên hạt, trái cây và rau.
- Ăn ít đường và chất béo.
- Uống ít nhất 8 cốc (khoảng 64 ounce ~1,9 lít) nước không đường mỗi ngày.
- Bảo đảm đủ vitamin và khoáng chất trong khẩu phần hằng ngày. Hỏi bác sĩ về việc dùng viên vitamin và khoáng chất bà bầu để đáp ứng nhu cầu thai kỳ.

Tôi có nên tập thể dục không?

Mọi phụ nữ mang thai đều nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập luyện. Bác sĩ có thể đưa hướng dẫn tập luyện riêng dựa trên tiền sử bệnh. 30 phút tập mỗi ngày, hoặc hầu hết các ngày, sẽ giúp kiểm soát đái tháo đường thai kỳ. Vì cả insulin và tập luyện đều làm giảm đường huyết, bạn nên tuân theo các hướng dẫn sau để tránh hạ đường huyết:

- Luôn mang theo một dạng đường nào đó, như viên glucose hoặc kẹo cứng.
- Ăn một phần trái cây hoặc lượng tương đương 15g carbohydrate cho phần lớn hoạt động kéo dài 30 phút. Nếu tập ngay sau bữa ăn, hãy ăn bữa phụ này sau khi tập.

Tôi có cần dùng insulin không?

Dựa trên kết quả theo dõi đường huyết, bác sĩ sẽ cho biết bạn có cần tiêm insulin trong thai kỳ hay không. Nếu được kê insulin, bác sĩ, điều dưỡng hoặc chuyên viên giáo dục đái tháo đường sẽ hướng dẫn bạn cách tự tiêm.

Khi thai kỳ tiến triển, bánh rau tạo nhiều nội tiết tố thai kỳ hơn, và có thể cần liều insulin lớn hơn để kiểm soát đường huyết. Bác sĩ sẽ điều chỉnh liều insulin dựa trên đường huyết của bạn trong ngày.

Khi dùng insulin, hạ đường huyết có thể xảy ra nếu bạn:

- Ăn không đủ.
- Bỏ bữa.
- Ăn không đúng giờ.
- Tập luyện nhiều hơn thường lệ.
- Tiêm quá nhiều insulin.

Triệu chứng hạ đường huyết gồm: lú lẫn, chóng mặt, run tay, đau đầu, đói cồn cào đột ngột, vã mồ hôi, yếu sức.

Hạ đường huyết là vấn đề nghiêm trọng cần xử trí ngay. Nếu nghĩ mình bị hạ đường huyết:

- Kiểm tra đường huyết nếu có thể.
- Nếu đường huyết dưới 60 mg/dl, ăn thứ có đường: ½ cốc nước cam hoặc nước táo; 1 cốc sữa tách béo; 4-6 viên kẹo cứng (không phải loại không đường); ½ cốc nước ngọt thường; hoặc 1 thìa canh mật ong, đường nâu hay siro ngô.
- 15 phút sau khi ăn một trong các món trên, kiểm tra lại. Nếu vẫn dưới 60 mg/dl, ăn thêm một lựa chọn nữa và gọi bác sĩ hoặc nữ hộ sinh. Nếu còn hơn 45 phút mới đến bữa kế, hãy ăn thêm nguồn tinh bột và đạm để tránh tái hạ đường huyết.
- Ghi lại mọi lần hạ đường huyết vào sổ theo dõi: ngày, giờ xảy ra và cách bạn xử trí.

Đái tháo đường thai kỳ có những biến chứng gì?

Mọi biến chứng thai kỳ liên quan đến đái tháo đường đều gắn trực tiếp với việc kiểm soát đường huyết. Đường huyết càng cao và càng thường xuyên cao, mẹ và bé càng dễ gặp biến chứng.

Vì đề kháng insulin thường chỉ xuất hiện từ tuần 24, dị tật bẩm sinh không phải biến chứng thường gặp của đái tháo đường thai kỳ (dị tật bẩm sinh thường hình thành trong 3 tháng đầu). Các biến chứng khác gồm:

- Đái tháo đường thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp trong thai kỳ (tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật).
- Mổ lấy thai hay gặp hơn ở phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ.
- Em bé có thể to hơn bình thường trong tử cung.
- Có thể có nhiều nước ối quanh em bé.
- Trong lúc sinh, tăng nguy cơ kẹt vai (vai em bé mắc kẹt trong đường sinh).
- Sau sinh, em bé tăng nguy cơ hạ đường huyết, vàng da và khó tự thở.
- Phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ có 30% nguy cơ bị tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường type 2 ngay sau thai kỳ.
- 50% phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ sẽ tiến triển thành đái tháo đường type 2 trong 10 năm tới.
- Trẻ sinh ra từ mẹ mắc đái tháo đường có nguy cơ cao hơn mắc đái tháo đường type 2 và béo phì về sau.

Chuyển dạ và sinh có khác không nếu tôi bị đái tháo đường thai kỳ?

Chuyển dạ và sinh nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường thai kỳ. Tuy nhiên, nếu em bé quá to, có thể phải mổ lấy thai.

Kiểm soát đường huyết cẩn thận trong lúc chuyển dạ rất quan trọng để em bé không bị tăng insulin (do đường huyết

mẹ cao). Nếu đường huyết cao, bạn có thể cần truyền insulin qua đường tĩnh mạch trong khi chuyển dạ. Đường huyết sẽ được kiểm tra mỗi 1–2 giờ khi chuyển dạ tích cực, và đường huyết cao sẽ được điều trị bằng insulin.

Sau sinh em bé sẽ thế nào?

Đường huyết của bé sẽ được kiểm tra ngay sau sinh. Nếu đường huyết thấp, bé sẽ được cho uống sữa công thức có đường, hoặc truyền glucose qua đường tĩnh mạch. Bé có thể được chuyển đến đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) để theo dõi trong vài giờ đầu, bảo đảm không bị hạ đường huyết.

Nếu bạn bị đái tháo đường thai kỳ, trẻ sơ sinh tăng nguy cơ vàng da. Vàng da là hiện tượng da ngả vàng khi có bilirubin trong máu. Bilirubin là sắc tố được giải phóng khi hồng cầu dư thừa tích tụ và không được xử lý kịp. Vàng da hết nhanh khi điều trị; một cách điều trị là chiếu đèn đặc biệt cho bé.

Trẻ sinh ra từ mẹ mắc đái tháo đường cũng có phổi trưởng thành muộn hơn và tăng nguy cơ khó thở sau sinh. Nếu vậy, bé có thể được đưa vào NICU điều trị.

Tôi bị đái tháo đường thai kỳ thì con tôi có bị đái tháo đường không?

Đái tháo đường thai kỳ không gây đái tháo đường ở trẻ sơ sinh. Nguy cơ đái tháo đường của con liên quan đến việc kiểm soát đường huyết của bạn trong thai kỳ, tiền sử gia đình, cân nặng, thói quen ăn uống và vận động. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giảm nguy cơ bé mắc đái tháo đường và béo phì về sau.

Sau sinh tôi còn bị đái tháo đường không?

Thông thường, đường huyết trở lại bình thường sau sinh, vì bánh rau — nơi tạo ra lượng nội tiết tố dư thừa gây đề kháng insulin — đã được sổ ra. Bác sĩ sẽ làm nghiệm pháp glucose cho bạn trong khoảng 4–12 tuần sau sinh; xét nghiệm này làm lúc đói và tầm soát tiền đái tháo đường và đái tháo đường type 2.

Phụ nữ từng bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 về sau tăng thêm 60%. Vì vậy, hãy báo cho bác sĩ chăm sóc chính biết bạn từng bị đái tháo đường thai kỳ để họ kiểm tra đường huyết trong các lần khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Bằng cách duy trì cân nặng lý tưởng, ăn uống lành mạnh và tập luyện, bạn có thể giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp bạn giảm cân sau sinh và đưa đường huyết về bình thường nhanh hơn. Ngoài ra, phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ một lần có 40–50% khả năng tái mắc ở lần mang thai sau. Nếu từng bị đái tháo đường thai kỳ và dự định mang thai lại, hãy trao đổi với bác sĩ trước để có những thay đổi lối sống cần thiết. Nếu chưa mắc đái tháo đường type 2 trước lần mang thai kế tiếp, bạn nên làm nghiệm pháp glucose sớm vào cuối 3 tháng đầu trong tất cả các lần mang thai.

Bệnh Toxoplasma và thai kỳ

Bệnh Toxoplasma là gì?

Toxoplasma là bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng đơn bào Toxoplasma gondii gây ra, có thể đe dọa sức khỏe thai nhi. Bạn có thể nhiễm khi tiếp xúc với đất hoặc cát vệ sinh của mèo có chứa phân mèo nhiễm ký sinh trùng. Bạn cũng có thể nhiễm khi ăn thịt chưa nấu chín từ động vật nhiễm bệnh, hoặc từ thực phẩm sống đã tiếp xúc với thịt nhiễm bệnh. Nếu đã từng nhiễm Toxoplasma một lần, thường bạn sẽ không nhiễm lại.

Triệu chứng của Toxoplasma là gì?

Vì phần lớn người nhiễm Toxoplasma không có triệu chứng, khó biết mình đã nhiễm hay chưa. Khi có triệu chứng, chúng có thể giống cúm: sốt, mệt mỏi, đổ mồ hôi đêm, đau nhức và sưng hạch bạch huyết.

Nếu tôi nhiễm Toxoplasma trước khi mang thai, thai nhi có nguy cơ không?

Trừ trường hợp hiếm, phụ nữ đã nhiễm ít nhất 6–9 tháng trước khi thụ thai sẽ có miễn dịch với Toxoplasma và không truyền cho con.

Nếu tôi nhiễm Toxoplasma trong thai kỳ, em bé có thể bị gì?

Khoảng một nửa phụ nữ nhiễm Toxoplasma có thể truyền qua bánh rau cho thai nhi. Nhiễm sớm trong thai kỳ ít khả năng truyền hơn nhiễm muộn. Tỷ lệ truyền cho thai là 10–15% trong 3 tháng đầu, 25% trong 3 tháng giữa và trên 60% trong 3 tháng cuối. Tuy nhiên, nhiễm sớm thường nặng hơn nhiễm muộn.

Phần lớn trẻ nhiễm trong thai kỳ không có dấu hiệu bệnh khi sinh, nhưng nhiều em về sau bị khuyết tật về học tập, thị giác và thính giác.

Làm sao biết thai nhi đã nhiễm chưa?

Nếu bạn nhiễm Toxoplasma, có vài cách kiểm tra xem thai đã nhiễm hay chưa:

- Xét nghiệm nước ối quanh thai hoặc máu thai để tìm nhiễm trùng.
- Khoảng một phần ba trẻ nhiễm có bất thường có thể thấy trên siêu âm.
- Máu của bé có thể được xét nghiệm sau sinh.

Có thể điều trị Toxoplasma trong thai kỳ không?

Nhiễm Toxoplasma có thể điều trị trong thai kỳ bằng kháng sinh. Phát hiện và điều trị càng sớm, khả năng ngăn thai nhi bị nhiễm càng cao. Nếu bé đã nhiễm, điều trị có thể làm bệnh nhẹ hơn. Bé cũng có thể được điều trị trong năm đầu đời.

Làm sao phòng ngừa nhiễm Toxoplasma?

CDC khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa sau:

Nấu chín thực phẩm ở nhiệt độ an toàn (165°F ~74°C trở lên) và dùng nhiệt kế thực phẩm để bảo đảm thịt chín kỹ, không còn màu hồng; nước thịt chảy ra phải trong.

- Gọt vỏ hoặc rửa kỹ trái cây, rau trước khi ăn. Rửa thớt, bát đĩa, mặt bàn, dụng cụ và tay bằng nước nóng, xà phòng sau khi tiếp xúc thực phẩm sống.
- Đeo găng khi làm vườn hoặc tiếp xúc đất, cát, vì có thể chứa phân mèo. Rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc đất hoặc cát.
- Tránh thay cát vệ sinh mèo nếu có thể. Nếu buộc phải làm, hãy đeo găng và rửa tay kỹ sau đó. Thay khay vệ sinh hằng ngày, giữ mèo trong nhà, không tiếp xúc với mèo hoang hoặc mèo mới nhận nuôi. Không cho mèo ăn thịt sống hoặc chưa nấu chín.

Ứng phó với những thay đổi cơ thể và khó chịu của thai kỳ

Cơ thể bạn thay đổi liên tục trong thai kỳ, có thể gây một số khó chịu. Có triệu chứng xuất hiện từ những tuần đầu, có triệu chứng chỉ đến khi gần sinh; số khác xuất hiện sớm rồi biến mất, sau đó lại quay lại. Điều này là bình thường và thường không có nghĩa là có gì bất ổn.

Dưới đây là những khó chịu thường gặp nhất và cách giảm bớt. Mỗi thai kỳ mỗi khác, có thể một số khó chịu không xảy ra với bạn. Hãy trao đổi mọi lo lắng với nhân viên y tế. Xem mục "Hướng dẫn dùng thuốc" để biết các thuốc không kê đơn giúp giảm khó chịu.

KHÓ CHỊU	KHUYẾN NGHỊ
Đau và khó chịu vùng bụng Những cơn đau nhói, buốt hai bên bụng có thể do mô nâng đỡ tử cung đang lớn bị căng ra. Cơn đau cũng có thể lan xuống đùi và chân.	• Thử xoa bóp. • Bảo đảm uống đủ nước. • Thử chườm đá.
Đau dây chằng tròn Hay gặp nhất trong 3 tháng giữa. Đau nhói ở bụng hoặc vùng hông, một hoặc hai bên, có thể lan xuống bẹn. Đây được coi là hiện tượng bình thường của thai kỳ.	• Đổi tư thế hoặc hoạt động cho đến khi dễ chịu. Tránh xoay người hay cử động đột ngột. • Nếu đau bụng đột ngột, hãy gặp người về phía đau để giảm căng và thư giãn mô. • Chườm túi nước nóng hoặc miếng sưởi, hoặc tắm/ngâm nước ấm. • Nghỉ ngơi.
Co cứng cơ (gò tử cung) Cơ tử cung bắt đầu co (gò) từ khoảng tháng thứ tư. Những cơn gò không đều, thưa gọi là cơn gò Braxton Hicks.	Hãy liên hệ nhân viên y tế nếu đau nhiều hoặc liên tục, hoặc nếu bạn dưới 36 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Dấu hiệu chuyển dạ sinh non: • Hơn 4–6 cơn gò (cơ tử cung co lại, gây khó chịu hoặc đau âm ỉ vùng bụng dưới) trong một giờ. • Co cứng hoặc đau đều đặn ở lưng hoặc bụng dưới. • Cảm giác đè nặng ở vùng chậu hoặc âm đạo. • Đau quặn kiểu hành kinh. • Ra máu. • Rỉ dịch (rỉ ối). • Triệu chứng giống cúm như buồn nôn, nôn và tiêu chảy.
Đau lưng Đau lưng thường do sức căng lên cơ lưng, thay đổi nội tiết và thay đổi tư thế.	• Đi giày gót thấp (nhưng không đế bằng phẳng). • Tránh nâng vật nặng. • Ngồi xõm gập gối khi nhật đồ, thay vì cúi gập ở thắt lưng. • Tránh vận phần thân trên khi nâng vật. • Ngồi ghế có tựa lưng tốt, hoặc đặt một chiếc gối nhỏ sau thắt lưng; kê chân lên bệ hoặc ghế đầu. • Nằm nghiêng trái hoặc phải, kẹp gối giữa hai chân để nâng đỡ. • Chườm túi nước nóng/miếng sưởi, tắm nước ấm, hoặc thử chườm đá và/hoặc xoa bóp. • Dùng đệm và gối nâng đỡ tốt khi ngủ. • Tập các bài tập theo hướng dẫn của nhân viên y tế để cơ lưng khỏe hơn và giảm đau mỏi. • Gặp chuyên gia vật lý trị liệu, chỉnh hình cột sống (chiropractor), hoặc tham gia buổi khám nhóm về đau lưng – chậu (SMA). Nhân viên y tế có thể giới thiệu bạn. • Giữ tư thế đúng. Đứng thẳng giúp giảm căng lưng. Mặc áo ngực nâng đỡ tốt. • Dùng đai đỡ bụng bầu. • Nếu đau chủ yếu một bên và/hoặc lan xuống một chân, có thể là đau thần kinh tọa. Nằm nghiêng về bên/hông đối diện có thể giúp ích; cũng thử chườm đá, chườm nóng và/hoặc xoa bóp. • Liên hệ nhân viên y tế nếu đau lưng dưới lan vòng quanh bụng và không hết trong vòng 1 giờ sau khi đổi tư thế hoặc nghỉ — đây có thể là dấu hiệu chuyển dạ sinh non.

KHÓ CHỊU	KHUYẾN NGHỊ
Chảy máu và sưng lợi Lượng máu tuần hoàn tăng và một số nội tiết tố có thể khiến lợi nhạy cảm, sưng và chảy máu.	- Chăm sóc răng và lợi đúng cách. Đánh răng và dùng chỉ nha khoa đều đặn. - Khám răng sớm trong thai kỳ để bảo đảm rằng miệng khỏe mạnh. Gặp nha sĩ nếu có vấn đề.
Thay đổi ở vú Vú có thể to lên khi tuyến sữa nở ra và mô mỡ tăng — vú đang chuẩn bị tạo sữa cho bé. Tĩnh mạch xanh có thể hiện rõ khi lượng máu tăng. Núm vú sẫm màu hơn, và một loại dịch đặc gọi là sữa non (colostrum) có thể rỉ ra. Tất cả đều bình thường.	- Mặc áo ngực nâng đỡ tốt. - Chọn áo ngực cotton hoặc sợi tự nhiên khác. - Tăng cỡ áo ngực khi vú to lên. Áo ngực nên vừa vặn, không cọ xát núm vú. Thử áo ngực bà bầu hoặc áo cho con bú. - Tránh caffeine. - Lót khăn cotton hoặc gác vào mỗi bên cúp áo ngực để thấm dịch rỉ; hoặc dùng miếng lót thấm sữa mua ở hiệu thuốc. - Chỉ rửa vú bằng nước ấm. Không dùng xà phòng hay sản phẩm khác. Đây là thời điểm tốt để tìm hiểu về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.
Táo bón Nội tiết tố, cùng viên bổ sung vitamin và sắt, có thể gây táo bón. Tử cung đè lên trực tràng cũng có thể gây táo bón.	- Bổ sung thêm chất xơ (ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau tươi). - Uống nhiều nước mỗi ngày (ít nhất 10–12 cốc nước và 1–2 cốc nước ép trái cây hoặc nước mật). - Uống đồ ấm, nhất là buổi sáng. - Tập thể dục hằng ngày. - Đặt giờ đi tiêu cố định. Tránh rặn khi đi tiêu. - Xem danh mục thuốc — bạn có thể cần dùng thuốc làm mềm phân và/hoặc thuốc đặt glycerin.
Khó ngủ Tìm tư thế nghỉ thoải mái có thể trở nên khó khăn hơn về cuối thai kỳ.	- Không dùng thuốc ngủ thường xuyên. - Tập thể dục đều đặn. - Điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ ở mức dễ chịu nhất có thể. - Tránh caffeine. - Thử uống sữa ấm trước khi ngủ. - Thử tắm nước ấm trước khi ngủ. - Dùng thêm gối để nâng đỡ khi ngủ. Khi nằm nghiêng, kê gối dưới đầu, dưới bụng, sau lưng và giữa hai gối để tránh mỏi cơ. Nằm nghiêng trái thường dễ chịu hơn, giúp máu lưu thông tốt.
Chóng mặt Có thể xảy ra khi đứng lâu hoặc đổi tư thế đột ngột.	- Di chuyển thường xuyên khi phải đứng lâu, tránh khóa gối. - Nghiêng người sang một bên trước khi ngồi dậy từ tư thế nằm. - Đứng dậy chậm rãi từ tư thế ngồi. Tránh cử động đột ngột. - Nếu chóng mặt đột ngột, hãy ngồi xuống và cúi đầu, hoặc nằm nghiêng.
Mệt mỏi Em bé đang lớn cần nhiều năng lượng, có thể khiến bạn mệt. Đôi khi mệt là dấu hiệu thiếu máu (thiếu sắt), thường gặp trong thai kỳ.	- Nghỉ ngơi nhiều. Đi ngủ sớm và thử ngủ ngắn ban ngày. - Tránh caffeine. - Duy trì lịch sinh hoạt đều đặn nhưng điều tiết hoạt động; cân bằng vận động với nghỉ ngơi. - Tập thể dục hằng ngày để tăng năng lượng. - Nếu nghi ngờ thiếu máu hoặc trầm cảm, hãy đề nghị nhân viên y tế xét nghiệm máu.
Đi tiểu nhiều Trong 3 tháng đầu, tử cung và em bé đang lớn đè lên bàng quang gây một tiểu thường xuyên. Hiện tượng này lặp lại khi đầu em bé tụt vào khung	- Tránh mặc đồ lót, quần hoặc tất quần bó chặt. - Tránh uống nhiều nước trong 1–2 giờ trước khi ngủ. - Liên hệ nhân viên y tế nếu tiểu buốt hoặc rát — có thể là dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), cần điều trị ngay.

KHÓ CHỊU	KHUYẾN NGHỊ
chậu trước sinh.	
Đau đầu Tần suất và mức độ đau đầu có thể thay đổi.	• Chườm túi đá lên trán hoặc sau gáy. • Nghỉ, ngồi hoặc nằm yên trong phòng ánh sáng dịu. Nhắm mắt và thả lỏng lưng, cổ, vai. • Xem các lựa chọn giảm đau trong danh mục thuốc. • Liên hệ nhân viên y tế nếu đau đầu kèm buồn nôn; đau đầu dữ dội không dứt; hoặc mờ mắt, nhìn đôi, có điểm mù.
Ợ nóng hoặc khó tiêu Ợ nóng (khó tiêu) là cảm giác nóng rát bắt đầu từ dạ dày và dâng lên cổ họng. Xảy ra vì hệ tiêu hóa hoạt động chậm hơn do thay đổi nội tiết; tử cung to cũng chèn ép dạ dày, đẩy dịch vị lên.	• Ăn nhiều bữa nhỏ thay vì 3 bữa lớn. • Ăn chậm. • Uống đồ ấm như trà thảo mộc. • Tránh đồ chiên, cay, nhiều dầu mỡ hoặc bất kỳ món nào gây khó tiêu. • Không nằm ngay sau khi ăn. • Kê đầu giường cao hơn chân giường, hoặc kê gối dưới vai để tránh dịch vị trào lên ngực. • Xem danh mục thuốc để biết các thuốc kháng acid có thể dùng.
Trĩ Trĩ là các tĩnh mạch giãn nổi thành cục đau ở hậu môn, có thể hình thành do tăng tuần hoàn và áp lực lên trực tràng, âm đạo khi thai lớn.	• Cố gắng tránh táo bón — táo bón gây trĩ và làm trĩ đau hơn. • Tránh ngồi hoặc đứng lâu. Đổi tư thế thường xuyên. • Cố gắng không rặn khi đi tiêu. • Đắp miếng cây phi (witch hazel), túi đá hoặc gạch lạnh; hoặc ngâm bồn nước ấm vài lần mỗi ngày. Thêm muối Epsom vào nước tắm có thể giúp ích. • Tránh đồ lót, quần, tất quần bó chặt. • Trao đổi với nhân viên y tế về thuốc trị trĩ như thuốc bôi giảm đau và/hoặc sản phẩm giảm sưng.
Chuồn rút chân Áp lực từ tử cung đang lớn có thể gây chuột rút hoặc đau nhói xuống chân.	• Ăn/uống thực phẩm giàu calci (sữa, súp lơ xanh, phô mai). • Uống nước có điện giải như Powerade hoặc Gatorade — lưu ý các loại này nhiều calo do chứa đường. • Đi giày thoải mái, gót thấp. • Thử mang tất/vớ nâng đỡ, nhưng tránh loại quá chặt. • Kê cao chân khi có thể. Tránh bắt chéo chân. • Tập thể dục hằng ngày. • Duỗi chân trước khi ngủ. • Tránh nằm ngửa, vì trọng lượng cơ thể và tử cung to đè lên có thể làm chậm tuần hoàn ở chân, gây chuột rút. • Nhẹ nhàng kéo giãn cơ bị chuột rút bằng cách duỗi thẳng chân, gập bàn chân và kéo các ngón chân về phía mình. • Thử xoa bóp chỗ chuột rút, hoặc chườm nóng lên vùng đau.
Ngạt mũi Bạn có thể nghẹt mũi hoặc thấy như bị cảm. Nội tiết tố thai kỳ đôi khi làm khô niêm mạc mũi, khiến mũi viêm và sưng.	• Đắp khăn ẩm lên má, mắt và mũi để giảm nghẹt. • Không dùng thuốc xịt mũi — có thể làm nặng thêm triệu chứng. • Uống nhiều nước (ít nhất 10–12 cốc/ngày) để làm loãng dịch nhầy. • Kê cao đầu bằng một gối phụ khi ngủ để dịch nhầy không đọng ở họng. • Dùng máy tạo ẩm hoặc máy phun sương để tăng độ ẩm không khí.
Buồn nôn hoặc nôn Buồn nôn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nhưng thường nặng hơn vào buổi sáng khi bụng đói (gọi là "nghe n")	• Nếu buồn nôn buổi sáng, ăn đồ khô như ngũ cốc, bánh mì nướng hoặc bánh quy giòn trước khi ra khỏi giường. Thử ăn bữa phụ giàu đạm như thịt nạc hoặc phô mai trước khi ngủ (đạm tiêu hóa lâu hơn). • Ăn bữa nhỏ mỗi 2–3 giờ thay vì 3 bữa lớn. Ăn chậm, nhai kỹ.

KHÓ CHỊU	KHUYẾN NGHỊ
hoặc khi ăn không đủ. Đây là hệ quả của thay đổi nội tiết, thường gặp ở đầu thai kỳ cho đến khi cơ thể thích nghi.	• Nhấp nước rải rác trong ngày, tránh uống nhiều một lúc. Thử nước ép trái cây mát, trong như nước táo hoặc nho. • Tránh đồ cay, chiên, nhiều dầu mỡ. • Nếu khó chịu với mùi mạnh, ăn đồ nguội hoặc ở nhiệt độ phòng và tránh những mùi khó chịu. • Để dự phòng buồn nôn, uống vitamin B6 25mg ngày 3 lần và doxylamine 12,5mg trước khi ngủ. Cũng có thể thử cao gừng 125–250mg mỗi 6 giờ. • Nếu không dung nạp được vitamin bà bầu ở đầu thai kỳ, có thể uống riêng acid folic — hỏi ý kiến nhân viên y tế. • Một số người tiết nhiều nước bọt hơn bình thường — kẹo cứng hoặc kẹo cao su có thể giúp ích. • Vòng đeo cổ tay tạo áp lực ở một số điểm (thường gọi là sea band) cũng có thể giúp ích. • Liên hệ nhân viên y tế nếu nôn liên tục hoặc nặng đến mức không giữ được nước và thức ăn — có thể gây mất nước, cần điều trị ngay.
Khó thở Bạn có thể thấy khó thở khi leo cầu thang hoặc đi nhanh. Điều này thường gặp do thay đổi cơ thể và tuần hoàn trong thai kỳ.	• Chậm lại và nghỉ vài phút. Cố tránh thở gấp. • Giơ tay qua đầu — động tác này nâng lồng ngực, giúp hít vào nhiều không khí hơn. • Thở thở bằng lồng ngực, không phải bằng bụng. • Tránh nằm ngửa; thử ngủ kê cao đầu.
Rạn da Rạn da là những vết sẹo hình thành khi độ đàn hồi của da không đủ cho mức căng giãn cần thiết trong thai kỳ. Thường xuất hiện ở bụng, và cũng có thể ở ngực, mông hoặc đùi. Rạn da không mất hẳn nhưng sẽ mờ đi sau sinh; chúng ảnh hưởng lớp dưới da và thường không thể phòng tránh.	• Bảo đảm chế độ ăn đủ dưỡng chất cho làn da khỏe (đặc biệt vitamin C và E). • Thoa kem dưỡng để da mềm và giảm khô. • Tập thể dục hằng ngày.
Sưng phù bàn chân và cẳng chân Áp lực từ tử cung đang lớn lên các mạch máu đưa máu từ nửa dưới cơ thể gây ứ dịch, dẫn đến phù (edema) ở cẳng chân và bàn chân.	• Uống nhiều nước (ít nhất 10–12 cốc/ngày). • Tập thể dục đều đặn. • Tránh thực phẩm nhiều muối (natri). • Kê cao chân khi ngồi. Tránh bắt chéo chân. • Mặc đồ rộng rãi, thoải mái. Đồ chật làm chậm tuần hoàn và tăng ứ dịch. • Không đi giày chật. Chọn giày nâng đỡ, gót thấp và rộng; tất/vớ nâng đỡ có thể giúp ích. • Ăn đủ đạm. Thiếu đạm có thể gây ứ dịch. • Báo nhân viên y tế nếu sưng tay hoặc mặt — có thể là dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật hoặc nhiễm độc thai nghén (tăng huyết áp liên quan thai kỳ). • Nằm nghiêng nghỉ ban ngày để tăng lưu lượng máu đến thận.
Tiết dịch âm đạo Lượng máu và nội tiết tố tăng khiến âm đạo tiết dịch nhiều hơn. Dịch âm đạo bình thường có màu trắng hoặc trong, không gây kích ứng, không mùi, và có thể ngả vàng khi thấm ra đồ lót hoặc miếng lót.	• Chọn đồ lót cotton hoặc sợi tự nhiên khác. • Tránh quần jean hoặc quần bó chặt. • Không thụt rửa âm đạo — có thể đưa khí vào hệ tuần hoàn hoặc làm vỡ ối ở thai kỳ muộn. • Tránh xịt thơm hoặc khử mùi vùng kín. • Rửa vùng kín bằng xà phòng dịu nhẹ/không mùi hoặc chỉ nước sạch. • Lau từ trước ra sau.

KHÓ CHỊU	KHUYẾN NGHỊ
	Liên hệ nhân viên y tế nếu có rát, ngứa, kích ứng hoặc sưng; mùi hôi; dịch lẫn máu; hoặc dịch vàng tươi hay xanh — có thể là dấu hiệu nhiễm trùng.
Giãn tĩnh mạch Thể tích máu tăng và áp lực tử cung đang lớn có thể làm chậm tuần hoàn, đôi khi khiến tĩnh mạch ở chân to lên hoặc phồng.	Giãn tĩnh mạch thường do di truyền, nhưng có vài mẹo phòng ngừa: - Tránh đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu — hãy đứng dậy đi lại thường xuyên. - Tránh giữ bất kỳ tư thế nào cản trở tuần hoàn ở chân (như bắt chéo chân khi ngồi). - Kê cao chân khi ngồi. - Tập thể dục đều đặn. - Mang tất/vớ nâng đỡ nhưng tránh loại quá chật; loại cao đến gối hoặc cạp cao là tốt nhất, tránh loại chỉ cao đến đùi.

Tìm tư thế thoải mái: Tư thế và vận động đúng trong thai kỳ

Tư thế tốt là gì?

Tư thế là cách bạn giữ cơ thể khi đứng, ngồi hoặc nằm. Tư thế tốt trong thai kỳ là tập cho cơ thể đứng, đi, ngồi và nằm ở những vị trí ít gây căng cho lưng nhất.

Đứng đúng cách như thế nào?



1. Giữ đầu thẳng, cằm hơi thu vào. Không nghiêng đầu ra trước, ra sau hay sang bên.
2. Bảo đảm dái tai thẳng hàng với giữa vai.
3. Giữ hai bả vai ra sau và ngực hướng ra trước.
4. Giữ gối thẳng nhưng không khóa cứng.
5. Vươn đỉnh đầu lên trần nhà.
6. Hóp bụng, kéo vào và lên khi có thể. Không nghiêng khung chậu ra trước hay ra sau. Thu mông vào khi có thể.
7. Hướng hai bàn chân cùng chiều, trọng lượng dồn đều lên cả hai chân. Lòng bàn chân nên được nâng đỡ bằng gày gót thấp (nhưng không đế bằng phẳng).
8. Tránh đứng một tư thế quá lâu.
9. Nếu phải đứng lâu, điều chỉnh chiều cao bàn làm việc cho phù hợp nếu có thể. Thử kê một chân lên ghế đẩu hoặc hộp; sau vài phút đổi chân.
10. Khi làm bếp, mở tủ dưới bồn rửa và gác một chân lên bên trong tủ. Đổi chân mỗi 5–15 phút.

Ngồi đúng cách như thế nào?



Tư thế ngồi đúng: không có gối tựa lưng (trái) và có gối tựa lưng (phải).

1. Ngồi thẳng lưng, vai ra sau. Mông chạm vào lưng ghế.
2. Ngồi có điểm tựa lưng (như khăn cuộn nhỏ hoặc gối tựa thắt lưng) đặt ở chỗ hõm lưng. Cách tìm tư thế ngồi tốt khi không dùng gối tựa: ngồi ra mép ghế và thả người chùng hẳn xuống; rồi ưỡn người lên, làm nổi rõ đường cong của lưng hết mức; giữ vài giây; thả lỏng nhẹ (khoảng 10 độ).
3. Phân bố trọng lượng đều lên hai bên hông.
4. Giữ hông và gối ở góc 90 độ. Dùng bệ hoặc ghế kê chân nếu cần. Không bắt chéo chân; bàn chân đặt phẳng trên sàn.
5. Cố gắng không ngồi một tư thế quá 30 phút.
6. Ở nơi làm việc, chỉnh độ cao ghế và bàn để ngồi sát công việc và nghiêng về phía bạn. Tì khuỷu tay và cánh tay lên ghế hoặc bàn, giữ vai thả lỏng.
7. Khi ngồi ghế xoay, đừng vận eo — hãy xoay cả người.
8. Khi đứng dậy, dịch ra mép ghế rồi đứng lên bằng cách duỗi thẳng chân. Tránh gập người ở eo. Ngay sau đó duỗi lưng bằng 10 lần ưỡn lưng khi đứng.

Bạn có thể ngồi các tư thế khác trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn thời gian nên ngồi như mô tả trên để ít căng lưng nhất. Nếu đau lưng, hãy ngồi càng ít càng tốt và chỉ trong thời gian ngắn (10–15 phút).

Tư thế lái xe đúng



1. Dùng điểm tựa lưng (gối tựa thắt lưng) ở chỗ cong của lưng. Gối nên ngang bằng với hông.

- Đưa ghế gần vô-lăng để đỡ đường cong lưng. Ghế đủ gần để gối gập được và chân chạm bàn đạp.
- Luôn thắt cả dây an toàn ngang hông và dây qua vai. Đặt dây hông dưới bụng, càng thấp trên hông càng tốt, vắt qua đùi trên. Không bao giờ đặt dây trên bụng. Đặt dây vai giữa hai bầu ngực. Thắt cả hai dây càng khít càng tốt.
- Nếu xe có túi khí, việc thắt dây vai và dây hông càng quan trọng. Luôn ngồi lùi cách vị trí túi khí ít nhất 10 inch (~25 cm). Bên ghế lái, túi khí nằm trong vô-lăng. Khi lái, phụ nữ mang thai nên chỉnh vô-lăng nghiêng về phía ngực, tránh xa đầu và bụng.

Nâng vật đúng cách như thế nào?



Đúng (trái) và Sai (phải).

- Nếu phải nâng vật, đừng cố nâng vật cồng kềnh hoặc nặng hơn 20 pound (~9 kg).
- Trước khi nâng, bảo đảm đứng vững chân.
- Để nhặt vật thấp hơn thắt lưng, giữ lưng thẳng và gập ở gối và hông. Không cúi gập ở eo khi gối vẫn thẳng.
- Đứng dạng chân sát vật cần nâng, hai chân bám chắc sàn. Hóp cơ bụng cùng cơ sàn chậu (Kegel) và nâng vật bằng cơ chân. Duỗi thẳng gối đều đặn. Đừng giật mạnh vật lên người.
- Đứng thẳng hoàn toàn, không vặn người. Luôn bước chân về phía trước khi nâng vật.
- Nếu nâng vật từ trên bàn, trượt vật ra mép bàn để ôm sát vào người. Gập gối để gần vật, dùng chân nâng lên và đứng dậy.
- Tránh nâng vật nặng lên quá thắt lưng.
- Ôm gối đỡ sát người, tay gập lại. Giữ cơ bụng căng. Bước từng bước nhỏ, đi chậm.
- Để hạ vật xuống, đặt chân như khi nâng. Hóp cơ bụng và gập hông, gối.

Với đồ trên cao

- Dùng ghế đẩu hoặc ghế để nâng mình lên ngang tầm vật cần với.
- Đưa cơ thể gần vật cần với nhất có thể.
- Ước lượng rõ vật bạn định nâng nặng bao nhiêu.
- Dùng hai tay để nâng.

Tư thế ngủ và nằm nào là tốt nhất?



Tư thế nằm/ngủ tốt nhất có thể khác nhau. Dù nằm tư thế nào, hãy kê gối dưới đầu (không kê dưới vai). Gối có độ dày sao cho đầu ở vị trí bình thường để tránh căng lưng. Bạn cũng có thể kê một gối giữa hai chân để nâng đỡ. Hãy chọn tư thế thoải mái nhất với bạn.

- Thử dùng gối tựa lưng (tựa thắt lưng) ban đêm cho dễ chịu hơn. Một tấm khăn hoặc ga cuộn buộc quanh eo có thể giúp ích.
- Nếu thích nằm ngửa, kê một gối mỏng dưới một bên để nghiêng nhẹ sang bên đó. Điều này giúp bạn không bị chóng mặt, khó thở hay buồn nôn khi nằm ngửa hoàn toàn, nhờ giữ máu lưu thông bình thường ở vùng bụng.
- Khi đứng dậy từ tư thế nằm, hãy nghiêng người sang một bên, co hai gối về phía ngực, rồi nhẹ nhàng thả chân xuống mép giường. Chống tay đẩy người ngồi dậy. Tránh gập người ở eo.
- Cố ngủ ở tư thế giúp giữ đường cong của lưng (như nằm nghiêng, gối hơi cong, kẹp gối giữa hai gối). Không nằm nghiêng co gối sát ngực. Tránh nằm sấp.
- Chọn bộ đệm và khung đệm chắc, không lún. Nếu cần, kê ván dưới đệm, hoặc tạm đặt đệm xuống sàn. Nếu bạn luôn ngủ trên bề mặt mềm, việc chuyển sang bề mặt cứng có thể khó chịu hơn.

Tập luyện trong thai kỳ

Duy trì thói quen tập luyện đều đặn suốt thai kỳ giúp bạn khỏe mạnh và cảm thấy dễ chịu nhất.

Làm sao để giữ dáng khỏe?

Tập luyện đều đặn khi mang thai giúp cải thiện tư thế và giảm một số khó chịu thường gặp như đau lưng, táo bón, đầy hơi, phù và mệt mỏi. Tập luyện cũng cải thiện tâm trạng và giúp ngủ ngon. Khỏe mạnh khi mang thai nghĩa là tập nhẹ đến vừa, an toàn, ít nhất 3 lần mỗi tuần, trừ khi bác sĩ dặn khác.

Nếu trước khi mang thai bạn đã vận động thể chất, bạn có thể tiếp tục ở mức vừa phải. Đừng cố tập ở cường độ như trước; hãy làm những gì thoải mái nhất với bạn lúc này. Giữ trong khoảng 70% nhịp tim mục tiêu (nhịp tim mục tiêu $\approx$ 220 trừ đi số tuổi hiện tại).

Nếu bạn chưa từng tập đều đặn, bạn vẫn có thể bắt đầu tập an toàn trong thai kỳ sau khi hỏi ý kiến nhân viên y tế. Nếu trước khi mang thai bạn không tập 3 lần/tuần, đừng thử ngay hoạt động mới, gắng sức. Hãy bắt đầu với hoạt động cường độ thấp và tăng dần.

Tập luyện có an toàn với mọi người không?

Mọi phụ nữ mang thai đều nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi bắt đầu tập. Nhân viên y tế có thể đưa hướng dẫn riêng dựa trên tiền sử bệnh. Nếu bạn có bệnh lý như hen, bệnh tim, bệnh phổi hoặc tăng huyết áp, tập luyện có thể không phù hợp. Tập luyện cũng có thể gây hại nếu bạn có tình trạng sản khoa như:

- Mang đa thai.
- Ra máu hoặc rỉ máu âm đạo.
- Rau bám thấp.
- Hở eo tử cung.
- Dọa sảy thai hoặc sảy thai liên tiếp.
- Ối vỡ non.
- Tiền sử sinh non hoặc chuyển dạ sớm.
- Bệnh tim hoặc phổi nặng.
- Tăng huyết áp.

Những bài tập nào an toàn?

Hầu hết bài tập đều an toàn khi mang thai, miễn là bạn tập thận trọng và không quá sức. An toàn và hiệu quả nhất là bơi, đi bộ nhanh, đạp xe tại chỗ trong nhà, yoga cho bà bầu và aerobic ít va chạm (do huấn luyện viên có chứng chỉ hướng dẫn). Những hoạt động này ít nguy cơ chấn thương, có lợi cho toàn thân và có thể duy trì đến khi sinh.

Các hoạt động khác như chạy bộ có thể tập ở mức vừa phải. Bạn nên chọn bài tập không đòi hỏi giữ thăng bằng hay phối hợp cao, nhất là ở thai kỳ muộn.

Những bài tập cần tránh

Có những bài tập, hoạt động có thể gây hại nếu tập khi mang thai. Hãy tránh:

- Nín thở trong bất kỳ hoạt động nào.
- Hoạt động dễ té ngã (như trượt tuyết, thể dục dụng cụ, cưỡi ngựa).
- Môn thể thao va chạm như khúc côn cầu, bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ và bóng chuyền (để giảm nguy cơ chấn thương).
- Bài tập có thể gây chấn thương bụng dù nhẹ, như động tác giật cục hoặc đổi hướng đột ngột.
- Hoạt động đòi hỏi nhảy, nhảy lò cò, bật, nảy hoặc chạy nhiều.
- Gập gối sâu, gập bụng đầy đủ (full sit-up), nâng hai chân thẳng và động tác gập chạm ngón chân khi chân thẳng.
- Nảy người khi giãn cơ (giãn kiểu nảy không an toàn cho bất kỳ ai).
- Bài tập phải nằm ngửa hoặc nằm nghiêng phải quá 3 phút (nhất là sau tháng thứ ba).
- Động tác vặn eo khi đứng.
- Đột tập nặng xen kẽ thời gian dài không vận động.
- Nâng vật nặng trên 50 pound (~23 kg).
- Tập trong thời tiết nóng ẩm (nếu có thể tránh) hoặc ở nơi cao.
- Bồn tắm nước nóng, phòng xông hơi khô và phòng xông hơi ướt.
- Lặn bình dưỡng khí (scuba diving).

Một chương trình tập nên gồm những gì?

Để khỏe toàn diện, chương trình tập nên tăng cường và rèn luyện cơ bắp. Luôn bắt đầu bằng 5 phút khởi động và 5 phút giãn cơ. Gồm ít nhất 15 phút hoạt động tim mạch. Đo nhịp tim vào lúc gắng sức đỉnh; nhịp tim có thể dao động 140–160 nhịp/phút khi hoạt động. Sau phần aerobic, tập 5–10 phút giảm dần cường độ, kết thúc bằng giãn cơ nhẹ nhàng.

Hướng dẫn tập luyện cơ bản:

- Mặc đồ rộng, thoải mái, kèm áo ngực nâng đỡ tốt.
- Chọn giày phù hợp với loại hình vận động — giày đúng là cách bảo vệ tốt nhất khỏi chấn thương.
- Tập trên mặt phẳng, bằng để tránh chấn thương.
- Ăn đủ calo cho nhu cầu thai kỳ (thêm 300 calo/ngày so với trước khi mang thai) cùng nhu cầu tập luyện.
- Ăn xong ít nhất 1 giờ trước khi tập.
- Uống nước trước, trong và sau khi tập.
- Sau bài tập sần, đứng dậy từ từ để tránh chóng mặt.
- Không bao giờ tập đến kiệt sức. Nếu không nói chuyện bình thường được khi tập, bạn đang quá sức và cần chậm lại.

Ngừng tập và hỏi ý kiến nhân viên y tế nếu bạn:

- Đau.
- Đau bụng, ngực hoặc vùng chậu.
- Không thấy thai máy.
- Thấy ngất, chóng mặt, buồn nôn hoặc choáng váng.

- Thấy lạnh hoặc vã mồ hôi lạnh.
- Ra máu âm đạo.
- Ra dịch ồ ạt từ âm đạo hoặc rỉ dịch đều đặn (khi vỡ ối — vỡ màng ối).
- Thấy nhịp tim không đều hoặc nhanh.
- Sưng đột ngột ở cổ chân, tay, mặt hoặc đau bắp chân.
- Khó thở tăng lên.
- Cơn gò dai dẳng vẫn tiếp tục sau khi nghỉ, trước tuần 37.
- Khó đi lại.
- Em bé không máy nhiều như thường lệ.

Những thay đổi cơ thể nào ảnh hưởng đến khả năng tập luyện?

Thay đổi cơ thể trong thai kỳ tạo thêm gánh nặng. Ghi nhớ các thay đổi sau, hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh hoạt động khi cần:

- Em bé đang phát triển và các thay đổi bên trong cần nhiều oxy và năng lượng hơn.
- Nội tiết tố thai kỳ làm các dây chằng nâng đỡ khớp giãn ra, tăng nguy cơ chấn thương.
- Cân nặng tăng thêm và phân bố không đều làm thay đổi trọng tâm, tạo áp lực lên khớp và cơ vùng lưng dưới, khung chậu, và khiến bạn dễ mất thăng bằng.

Bao lâu sau sinh tôi có thể tập lại?

Tốt nhất hãy hỏi nhân viên y tế xem bao lâu sau sinh bạn có thể tập lại. Dù bạn nôn nóng lấy lại vóc dáng, hãy trở về thói quen tập trước mang thai một cách từ từ, theo khuyến nghị của nhân viên y tế.

Hầu hết phụ nữ có thể tập nhẹ nhàng, ít va chạm 1-2 tuần sau sinh thường (3-4 tuần sau mổ lấy thai). Hãy tập khoảng một nửa lượng bài tập sàn bình thường và đừng quá sức. Chờ khoảng 6 tuần sau sinh mới chạy hoặc tham gia các hoạt động va chạm mạnh.

Dưới đây là vài bài giãn và làm săn cơ cơ bản cho bà bầu. Lưu ý: trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập nào, hãy hỏi ý kiến nhân viên y tế.

Bài tập giãn cơ

Giãn cơ giúp cơ mềm dẻo và ấm. Vài bài giãn đơn giản có thể tập trước hoặc sau khi luyện tập:

- **Xoay cổ:** Thả lỏng cổ và vai. Gập đầu về trước. Từ từ xoay đầu về vai phải, về giữa, rồi sang vai trái. Xoay 4 vòng chậm mỗi chiều.
- **Xoay vai:** Đưa vai ra trước, xoay lên phía tai rồi hạ xuống. Xoay 4 vòng mỗi chiều.
- **Bơi:** Đặt tay xuôi thân. Đưa tay phải lên, vươn người về trước và xoay sang bên như bơi sải. Đổi tay trái. Lặp lại 10 lần.
- **Chuyển trọng tâm đùi:** Đứng một chân trước chân kia khoảng 2 feet (~60 cm), mũi chân cùng hướng. Nghiêng người ra trước, dồn trọng lượng lên đùi trước. Đổi bên. Làm 4 lần mỗi bên.

- **Lắc chân:** Ngồi duỗi chân và bàn chân. Đưa chân lên xuống theo động tác lắc nhẹ.
- **Xoay cổ chân:** Ngồi duỗi chân, thả lỏng ngón chân. Xoay bàn chân thành vòng lớn, dùng cả bàn chân và cổ chân. Xoay 4 lần bên phải và 4 lần bên trái.

Bài tập làm săn cơ

Các bài sau giúp tăng cường cơ âm đạo, bụng, sàn chậu, lưng và đùi.

Nghiêng khung chậu (pelvic tilt): Giúp tăng cường cơ bụng và lưng dưới, tăng độ linh hoạt của hông và giảm đau lưng dưới khi mang thai và chuyển dạ.

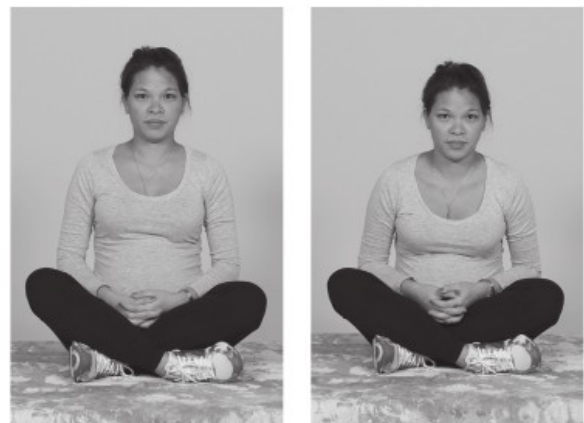


- **Tư thế bốn điểm tựa:** Quỳ chống tay và gối trên sàn, tay thẳng hàng với vai, gối thẳng hàng với hông. Giữ lưng phẳng, vai thả lỏng. Hít vào. Vừa hóp bụng, vừa thu mông và nghiêng khung chậu ra trước trong một động tác. Thở ra, thả lỏng, cẩn thận không để lưng võng. Tiếp tục thở đều. Lặp lại 10 lần.



- **Tư thế đứng:** Đứng hai chân cách nhau khoảng 10 inch (~25 cm), chân thả lỏng, gối hơi cong. Đặt tay lên hông. Hít vào. Vừa hóp bụng, vừa thu mông và nghiêng khung chậu ra trước trong một động tác. Thở ra, thả lỏng. Lặp lại 10 lần.

Bài tập kiểu "ngồi xếp bằng" (tailor)



3a

3b

- **Bài tập tailor:** Tăng cường cơ chậu, hông và đùi, giúp giảm đau lưng dưới.
- **Ngồi tailor:** Ngồi gối cong, hai cổ chân bắt chéo (xem hình 3a). Nghiêng nhẹ về trước. Giữ lưng thẳng nhưng thả lỏng (xem hình 3b). Dùng tư thế này bất cứ khi nào có thể trong ngày.



- **Ép tailor:** Ngồi gối cong, hai lòng bàn chân áp vào nhau. Nắm cổ chân và nhẹ nhàng kéo bàn chân về phía người. Đặt tay dưới đầu gối. Hít vào. Vừa ép gối xuống chống lại tay, vừa đẩy tay lên chống lại gối (lực đối kháng). Giữ đếm đến 5.

Bài tập Kegel

Bài tập Kegel, còn gọi là bài tập cơ sàn chậu, giúp tăng cường các cơ nâng đỡ bàng quang, tử cung và ruột.

Bằng cách tăng cường các cơ này trong thai kỳ, bạn có thể rèn khả năng thả lỏng và kiểm soát cơ, chuẩn bị cho chuyển dạ và sinh nở.

Bài tập Kegel được khuyến nghị nhiều trong giai đoạn sau sinh để thúc đẩy lành mô tầng sinh môn, tăng sức mạnh cơ sàn chậu và giúp các cơ này trở lại bình thường, bao gồm cải thiện kiểm soát tiểu tiện.

Cách tập Kegel

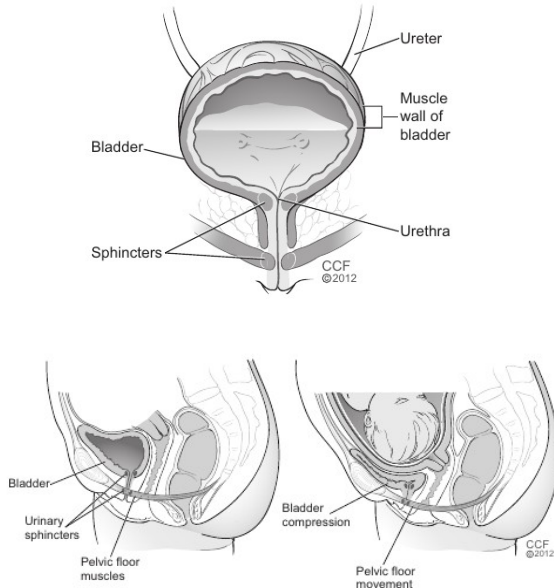
Hãy tưởng tượng bạn đang cố nhịn tiểu hoặc nhịn "xì hơi". Khi làm vậy, bạn đang co các cơ sàn chậu và đang tập Kegel. Khi tập Kegel, cố gắng không cử động cơ chân, mông hay bụng. Thực tế, không ai nên nhận ra bạn đang tập Kegel.

Nên tập Kegel bao lâu một lần?

Bài tập Kegel nên tập mỗi ngày. Chúng tôi khuyến nghị tập 3 hiệp mỗi ngày. Mỗi lần co cơ sàn chậu, giữ đếm chậm đến 10 giây rồi thả lỏng. Lặp lại 15 lần cho một hiệp Kegel.

Mang thai, sinh con và kiểm soát tiểu tiện

Nhiều phụ nữ bị rỉ nước tiểu (còn gọi là tiểu không tự chủ) trong thai kỳ hoặc sau sinh.



Bàng quang là một cơ quan tròn, có cơ, nằm trên các xương chậu, được nâng đỡ bởi các cơ vùng chậu. Một ống gọi là niệu đạo cho nước tiểu thoát ra khỏi bàng quang. Cơ bàng quang giãn ra khi bàng quang đầy nước tiểu, còn các cơ thắt giúp giữ bàng quang đóng cho đến khi bạn sẵn sàng đi tiểu.

Còn có các hệ thống khác của cơ thể giúp kiểm soát bàng quang. Thần kinh từ bàng quang gửi tín hiệu lên não khi bàng quang đầy, và thần kinh từ não báo cho bàng quang khi cần đi tiểu. Tất cả các thần kinh và cơ này phải phối hợp để bàng quang hoạt động bình thường.

Mang thai và sinh con ảnh hưởng đến kiểm soát bàng quang thế nào?

Trong thai kỳ, bạn có thể rỉ nước tiểu giữa các lần đi vệ sinh. Loại rỉ này gọi là tiểu không tự chủ khi gắng sức (stress incontinence), do áp lực em bé đè lên cơ sàn chậu, bàng quang và niệu đạo. Áp lực tăng thêm khiến bạn hay một tiểu hơn. Tiểu không tự chủ khi gắng sức có thể chỉ tạm thời và thường hết trong vài tuần sau sinh.

Mang thai, kiểu sinh và số con là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ tiểu không tự chủ. Phụ nữ đã sinh con — dù sinh thường hay mổ lấy thai — có tỉ lệ tiểu không tự chủ khi gắng sức cao hơn nhiều so với người chưa từng sinh.

Mất kiểm soát bàng quang có thể do sa tạng chậu, đôi khi xảy ra sau sinh. Cơ vùng chậu có thể giãn và yếu đi khi mang thai hoặc sinh thường. Nếu cơ vùng chậu không nâng đỡ đủ, bàng quang có thể sa xuống — tình trạng này gọi là sa bàng quang (cystocele). Khi bàng quang sa, lỗ niệu đạo có thể bị kéo giãn.

Các thần kinh vùng chậu điều hòa chức năng bàng quang có thể bị tổn thương trong cuộc sinh thường kéo dài hoặc khó. Sinh có dùng forceps (kẹp) có thể gây tổn thương cơ sàn chậu và cơ thắt hậu môn. Rặn kéo dài khi sinh thường cũng làm tăng khả năng tổn thương thần kinh vùng chậu và các vấn đề kiểm soát bàng quang sau đó.

Chẩn đoán vấn đề kiểm soát bàng quang thế nào?

Tuy phần lớn vấn đề kiểm soát bàng quang trong hoặc sau thai kỳ tự hết theo thời gian, bạn nên đi khám nếu chúng kéo dài từ 6 tuần trở lên sau sinh. Nên ghi nhật ký về số lần đi vệ sinh, tần suất rỉ nước tiểu và thời điểm xảy ra.

Bác sĩ sẽ khám thực thể để loại trừ các bệnh lý khác và đánh giá chức năng bàng quang. Bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm sau:

- **Tổng phân tích nước tiểu:** lấy mẫu nước tiểu để tìm nhiễm trùng có thể gây tiểu không tự chủ.
- **Siêu âm:** hình ảnh từ sóng siêu âm cho thấy thận, bàng quang và niệu đạo.
- **Nghiệm pháp gắng sức bàng quang:** bác sĩ kiểm tra dấu hiệu rỉ nước tiểu khi bạn ho mạnh hoặc rặn.
- **Nội soi bàng quang (cystoscopy):** một ống mảnh có camera nhỏ ở đầu được đưa vào niệu đạo để bác sĩ quan sát bàng quang và niệu đạo.
- **Niệu động học (urodynamics):** một ống mảnh được đưa vào bàng quang để bơm nước, đo áp lực bên trong bàng quang.

Điều trị vấn đề kiểm soát bàng quang thế nào?

Có nhiều cách điều trị. Tập Kegel có thể giúp cải thiện kiểm soát bàng quang và giảm rỉ nước tiểu. Ngoài ra, thay đổi chế độ ăn, giảm cân và sắp xếp giờ đi vệ sinh cũng có thể giúp ích.

Đồ uống như nước có ga, cà phê và trà có thể khiến bạn một tiểu nhiều hơn. Chuyển sang đồ uống không caffeine hoặc nước lọc có thể giúp giảm rỉ nước tiểu. Hạn chế uống sau bữa tối để giảm số lần đi vệ sinh ban đêm. Nên ăn thực phẩm giàu chất xơ để tránh táo bón, vì táo bón cũng có thể gây rỉ nước tiểu.

Thừa cân có thể tạo thêm áp lực lên bàng quang. Giảm cân sau sinh giúp giảm bớt áp lực này.

Ghi lại những thời điểm trong ngày dễ rỉ nước tiểu nhất, bạn có thể tránh rỉ bằng cách chủ động đi vệ sinh trước. Sau khi có thói quen đều đặn, bạn có thể kéo dài dần khoảng cách giữa các lần đi. Bằng cách "nhịn" lâu hơn, bạn tăng cường cơ vùng chậu và kiểm soát bàng quang tốt hơn. Ngoài ra, có thể tăng cường sàn chậu với sự hỗ trợ của chuyên gia vật lý trị liệu — hãy trao đổi với nhân viên y tế về lựa chọn này.

Làm sao phòng ngừa mất kiểm soát bàng quang do thai kỳ hoặc sinh nở?

Chuyển dạ và sinh thường có ảnh hưởng đến cơ và thần kinh sàn chậu liên quan kiểm soát bàng quang, nên bạn hãy trao đổi các lựa chọn với nhân viên y tế.

Mổ lấy thai gắn với nguy cơ tiểu không tự chủ hoặc sa tạng chậu thấp hơn sinh thường, nhưng có thể kèm nguy cơ khác. Em bé to nặng hơn 9 pound (~4 kg) khi sinh có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh trong cuộc sinh.

Tập cơ sàn chậu bằng bài Kegel có thể giúp phòng ngừa vấn đề kiểm soát bàng quang. Các vấn đề này có thể xuất hiện nhiều tháng đến nhiều năm sau sinh. Hãy trao đổi với đội ngũ y tế nếu điều này xảy ra với bạn.

Quan hệ tình dục trong thai kỳ

Tôi có thể quan hệ khi mang thai mà không hại em bé không?

Có. Không có lý do gì phải thay đổi hoạt động tình dục khi mang thai, trừ khi nhân viên y tế khuyên khác. Giao hợp hay đạt cực khoái khi mang thai sẽ không hại em bé, trừ khi bạn có bệnh lý. Hãy nhớ em bé được bảo vệ tốt trong tử cung nhờ nước ối bao quanh.

Nhân viên y tế có thể khuyên không giao hợp ở đầu thai kỳ nếu bạn có tiền sử sảy thai. Giao hợp cũng có thể bị hạn chế nếu bạn có một số biến chứng thai kỳ như chuyển dạ sinh non hoặc ra máu. Bạn có thể cần hỏi rõ nhân viên y tế xem điều đó nghĩa là không xâm nhập, không đạt cực khoái, hay không kích thích tình dục — vì mỗi biến chứng có thể đòi hỏi hạn chế khác nhau.

Thoải mái khi giao hợp

Khi thai lớn dần, có thể cần đổi tư thế cho thoải mái. Điều này cũng đúng sau khi sinh. Có thể dùng chất bôi trơn gốc nước khi giao hợp nếu cần.

Khi giao hợp, bạn không nên thấy đau. Khi đạt cực khoái, tử cung sẽ co lại, có thể hơi khó chịu. Ra ít máu âm đạo sau giao hợp là chuyện thường gặp. Hãy gọi ngay nhân viên y tế nếu ra máu âm đạo nhiều, đau dai dẳng, hoặc vỡ ối. Không được đưa bất cứ vật gì vào âm đạo sau khi vỡ ối.

Trao đổi với bạn đời

Hãy nói chuyện với bạn đời. Chia sẻ cảm nhận của bạn, nhất là khi bạn có cảm xúc lẫn lộn về chuyện quan hệ khi mang thai. Khuyến khích bạn đời cũng chia sẻ, đặc biệt nếu bạn nhận thấy thay đổi trong sự đáp ứng của họ. Trao đổi giúp cả hai hiểu rõ hơn cảm xúc và mong muốn của nhau.

Ham muốn của tôi có thay đổi không?

Ham muốn khác đi khi mang thai là chuyện thường gặp. Thay đổi nội tiết khiến một số phụ nữ tăng ham muốn, số khác lại ít hứng thú hơn trước.

Dành thời gian cho sự gần gũi

Nếu nhân viên y tế hạn chế hoạt động tình dục của bạn, hoặc bạn không có hứng giao hợp, hãy nhớ dành thời gian gần gũi với bạn đời. Gần gũi không nhất thiết phải giao hợp — tình yêu và sự triu mến có thể thể hiện bằng nhiều cách.

Bao lâu sau sinh tôi có thể quan hệ lại?

Nhìn chung, bạn có thể quan hệ lại khi đã hồi phục, khi hết ra máu, và khi cả bạn và bạn đời cảm thấy thoải mái. Nhân viên y tế có thể khuyên bạn chờ đến sau buổi khám hậu sản đầu tiên rồi mới giao hợp.

Sau sinh, một số phụ nữ thấy âm đạo thiếu chất bôi trơn khi giao hợp. Có thể dùng chất bôi trơn gốc nước để giảm khó chịu do khô âm đạo.

Phụ nữ chỉ cho con bú sữa mẹ sẽ chậm rụng trứng (khi trứng được phóng ra khỏi buồng trứng) và chậm có kinh trở lại. Tuy nhiên, rụng trứng xảy ra trước khi bạn có kinh lại, nên hãy nhớ bạn vẫn có thể mang thai trong thời gian này. Hãy làm theo khuyến nghị của nhân viên y tế về biện pháp tránh thai phù hợp.

Giấc ngủ trong thai kỳ

Thay đổi nội tiết và những khó chịu về thể chất của thai kỳ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Mỗi tam cá nguyệt mang những thay đổi riêng, bao gồm thay đổi về giấc ngủ.

Tổ chức National Sleep Foundation đưa ra những lý do phổ biến nhất khiến giấc ngủ thay đổi trong thai kỳ:

- Bạn thức dậy đi tiểu nhiều hơn.
- Ợ nóng, buồn nôn, chuột rút chân và ngạt mũi có thể gây khó chịu.
- Những thay đổi về thể chất và cảm xúc đang diễn ra trong cuộc sống của bạn.
- Bạn có thể rất buồn ngủ vào một số thời điểm trong ngày do ngủ không ngon và do tác dụng phụ của nồng độ progesterone tăng.
- Bạn có thể thấy khó chịu nói chung khi bụng to lên và cân nặng tăng.

Ngủ đủ trong thai kỳ

Nếu rối loạn giấc ngủ nặng, đừng ngần ngại nhờ bác sĩ giúp tìm giải pháp phù hợp. Một hoặc nhiều gợi ý sau có thể giúp bạn ngủ đủ:

- **Gối:** Có thể dùng gối để nâng đỡ cả bụng và lưng. Một chiếc gối kẹp giữa hai chân giúp đỡ lưng dưới và giúp nằm nghiêng dễ hơn. Một số loại gối cụ thể gồm gối hình nêm, gối ôm dài toàn thân và gối chữ U. Khuyến nghị nằm nghiêng khi ngủ.
- **Dinh dưỡng:** Uống một cốc sữa ấm có thể giúp dễ ngủ. Thực phẩm giàu carbohydrate — như một bát nhỏ ngũ cốc khô với một cốc sữa 4 ounce (~120 ml), một lát bánh mì nướng, bánh mì hoặc bánh quy giòn — giúp dễ ngủ vì làm tăng tryptophan (chất gây buồn ngủ). Một bữa phụ giàu đạm (như một thìa cà phê bơ lạc hoặc một lát phô mai ít béo với bánh quy nguyên hạt) giúp giữ đường huyết, phòng ác mộng, đau đầu và bốc hỏa. Tránh thực phẩm chứa caffeine như cà phê, trà, nước ngọt có caffeine và sô-cô-la.
- **Kỹ thuật thư giãn:** Giúp làm dịu tâm trí và thư giãn cơ, gồm giãn cơ và yoga, xoa bóp và hít thở sâu.
- **Tập luyện:** Tập đều đặn trong thai kỳ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời giúp ngủ sâu hơn. Tránh tập gắng sức trong vòng 4 giờ trước khi ngủ.

Đi lại, du lịch trong thai kỳ

Tôi có thể đi du lịch khi mang thai không?

Có, bạn có thể đi du lịch khi mang thai. Tuy nhiên, cũng như nhiều khía cạnh khác của thai kỳ, bạn cần lên kế hoạch trước. Một vài điều cần cân nhắc trước khi đi:

- **Bạn đang ở giai đoạn nào của thai kỳ:** Thực ra có một thời điểm lý tưởng để đi lại — đó là 3 tháng giữa. Với nhiều phụ nữ, 3 tháng đầu bị chi phối bởi nghén và khó chịu khi cơ thể thích nghi; 3 tháng cuối nói chung khó chịu hơn và bạn muốn ở gần nhân viên y tế khi gần đến ngày sinh. 3 tháng giữa thường là lúc bạn dễ chịu nhất, nguy cơ biến chứng thấp nhất và cơn nghén đã lui.
- **Nếu bạn có bệnh lý:** Trước khi đi, hãy trao đổi với nhân viên y tế về các bệnh bạn đang mắc. Bạn có thể cần điều chỉnh kế hoạch nếu có bệnh như tăng huyết áp, thiếu máu hoặc đái tháo đường thai kỳ, chẳng hạn dự tính đứng dậy duỗi chân sau mỗi vài giờ hoặc mang tất áp lực. Nhân viên y tế cũng có thể khuyên mang theo bản sao hồ sơ bệnh án phòng khi cần điều trị xa nhà. Tìm hiểu trước các bệnh viện, trung tâm y tế gần điểm đến và cách tới đó khi khẩn cấp.
- **Bạn mang mấy thai:** Nếu mang đa thai, nguy cơ sinh sớm tăng lên. Nhân viên y tế có thể khuyên ở gần nhà. Hãy trao đổi về thời điểm đi lại tốt nhất khi mang đa thai.
- **Nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại điểm đến:** Kiểm tra xem điểm đến có dịch bệnh đang lây lan không. Một số bệnh, như vi-rút Zika, có thể hại cả bạn và em bé nếu nhiễm khi mang thai. Nếu buộc phải đến nơi đang có dịch, hãy hỏi nhân viên y tế cách phòng bệnh.

Khi mang thai, bạn có thể đi bằng nhiều phương tiện — ô tô, tàu hỏa, máy bay, xe buýt và tàu du lịch. Dù đi cách nào, bạn cần điều chỉnh thói quen để giữ sức khỏe. Nếu ngồi lâu, hãy duỗi chân: dừng xe để nghỉ và đi bộ vài phút, hoặc rời ghế trên máy bay/tàu hỏa. Nếu vậy, hãy đặt ghế cạnh lối đi cho dễ đứng dậy. Nhớ đứng vững khi đi lại trên tàu hoặc máy bay đang chạy — tránh té ngã.

Đứng dậy và đi lại khi di chuyển giúp phòng ngừa tình trạng huyết khối tĩnh mạch sâu, xảy ra khi cục máu đông hình thành và di chuyển trong cơ thể. Nguy cơ tạo cục máu đông cao hơn khi mang thai.

Đi máy bay khi mang thai có an toàn không?

Bạn có thể đi máy bay an toàn khi mang thai. Trên các chuyến bay dài, bạn có thể cần đứng dậy duỗi chân để tránh cục máu đông. Hãy trao đổi với nhân viên y tế trước chuyến đi để đảm bảo không có bệnh lý nào có thể gây biến chứng khi bay.

Đến giai đoạn nào của thai kỳ thì không được đi máy bay?

Mỗi hãng bay có quy định riêng về thời điểm không cho bay khi mang thai. Hãy xem quy định của hãng trước khi đặt vé. Nói chung, hầu hết các hãng không cho bay trong tháng cuối; một số giới hạn sớm từ tuần 28–29. Bạn cũng nên gọi hãng

để chắc chắn được bay. Các chuyến quốc tế có thể có mốc giới hạn sớm hơn chuyến nội địa.

Khi nào tôi cần ngừng đi lại?

Càng gần ngày sinh, bạn càng nên ở gần nhà và nhân viên y tế. Hãy nhớ ngày dự sinh chỉ là ước tính; cuối thai kỳ khó lường và bạn có thể chuyển dạ bất kỳ lúc nào trong vài tuần cuối. Hầu hết nhân viên y tế khuyên ở gần nhà trong 3 tháng cuối, nhất là tháng cuối. Nếu buộc phải đi cuối thai kỳ, hãy lên kế hoạch và biết vị trí bệnh viện, trung tâm y tế gần điểm đến.

Bạn cũng có thể cần ngừng đi lại nếu có biến chứng thai kỳ. Nếu mắc tình trạng cần theo dõi sát như tiền sản giật, hãy tránh các chuyến đi dài. Bạn cũng có thể được khuyên không đi xa sớm hơn nếu mang đa thai.

Tôi có cần tiêm vắc-xin khi đi lại trong thai kỳ không?

Một số vắc-xin không được khuyến nghị khi mang thai, như vắc-xin sống MMR (sởi, quai bị, rubella). Số khác như vắc-xin cúm được coi là an toàn. Nếu đến nơi thường phải tiêm vắc-xin để phòng bệnh, hãy trao đổi với nhân viên y tế về lợi ích và nguy cơ. Đôi khi nguy cơ mắc bệnh còn lớn hơn tác dụng phụ của vắc-xin; khi đó nhân viên y tế có thể tiêm cho bạn trong thai kỳ.

Zika là gì và tôi có nên lo lắng khi đi lại?

Vi-rút Zika có thể lây qua vết muỗi đốt trực tiếp cũng như qua quan hệ tình dục. Thường gặp ở vùng nhiệt đới — như Nam Mỹ, Trung Mỹ, Mexico và vùng Caribe — vi-rút này có liên quan đến tật đầu nhỏ (microcephaly): một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, khi não em bé không phát triển đầy đủ trước sinh, làm giảm tuổi thọ.

Nếu buộc phải đến vùng đang có Zika khi mang thai, hãy trao đổi với nhân viên y tế trước. Trong chuyến đi, việc tránh muỗi đốt rất quan trọng. Vài mẹo tránh muỗi đốt:

- Dùng thuốc xua côn trùng (loại chứa DEET an toàn cho phụ nữ mang thai và giúp phòng muỗi đốt).
- Che kín vùng da hở.
- Mặc đồ màu sáng.
- Tránh nước tù đọng (muỗi sinh sản trong nước tù).
- Mặc màn khi ngủ và lắp lưới chống muỗi ở cửa sổ, cửa ra vào.

Nếu tôi ốm hoặc chuyển dạ khi đang đi lại thì sao?

Hãy luôn chuẩn bị cho tình huống cấp cứu y tế khi đi lại trong thai kỳ. Một vài biện pháp an toàn nên tuân theo:

- **Mang theo hồ sơ bệnh án:** Nếu cấp cứu hoặc cần điều trị khi ở xa nhà, hồ sơ giúp bạn được chăm sóc đúng. Toàn bộ diễn tiến thai kỳ và các bệnh sẵn có đều nằm trong đó.
- **Biết nơi có thể được chăm sóc:** Dù đi cách nào hay đến đâu, hãy biết nơi có thể được chăm sóc khi cần. Nếu đi tàu du lịch, hỏi về dịch vụ y tế trên tàu và tại các cảng dừng. Trên các chuyến đi đường dài, xem trước bệnh viện, trung tâm y tế dọc lộ trình — điều này rất hữu ích nếu cần tìm nơi chăm sóc nhanh.

- **Trao đổi với bảo hiểm y tế:** Kiểm tra với bảo hiểm trước khi đi để biết phạm vi chi trả ở từng nơi. Trong một số trường hợp như đi quốc tế, bạn có thể cần mua bảo hiểm riêng cho chuyến đi.

Cần biết thêm gì khi đi lại trong thai kỳ?

Khi đi lại, vài mẹo sau giúp bạn khỏe mạnh và an toàn:

- Uống nước đóng chai và không thêm đá vào đồ uống.
- Tuân theo nguyên tắc dinh dưỡng, gồm tránh đồ ăn hàng rong và không ăn cá sống.
- Luôn thắt dây an toàn: dây hông vắt qua hông (dưới bụng), dây vai vắt qua người và giữa hai bầu ngực.

Trầm cảm trong thai kỳ

Thai kỳ từ lâu được coi là giai đoạn hạnh phúc, được "che chở" khỏi các rối loạn tâm thần. Nhưng trầm cảm xảy ra ở phụ nữ mang thai gần như phổ biến như ở phụ nữ không mang thai.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy báo ngay cho nhân viên y tế:

- Có ý nghĩ về cái chết hoặc tự tử lặp đi lặp lại.
- Khí sắc trầm buồn gần như cả ngày, gần như mỗi ngày trong 2 tuần qua.
- Cảm thấy tội lỗi, tuyệt vọng hoặc vô dụng.
- Khó suy nghĩ, khó tập trung hoặc khó ra quyết định.
- Mất hứng thú hoặc niềm vui với hầu hết hoạt động, gần như mỗi ngày trong 2 tuần qua.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào trên, nhân viên y tế có thể hỏi bạn hai câu sau:

1. Trong 2 tuần qua, bạn có cảm thấy buồn chán, trầm cảm hoặc tuyệt vọng không?
2. Trong 2 tuần qua, bạn có thấy ít hứng thú hoặc ít niềm vui khi làm mọi việc không?

Nếu bạn trả lời "có" cho một trong hai câu, nhân viên y tế sẽ tiến hành sàng lọc trầm cảm sâu hơn.

Trầm cảm ảnh hưởng đến thai kỳ thế nào?

- Trầm cảm có thể cản trở khả năng tự chăm sóc bản thân và gia đình khi mang thai. Bạn có thể khó tuân thủ khuyến nghị y tế, khó ngủ và ăn uống điều độ.
- Trầm cảm có thể khiến bạn tăng dùng các chất có hại cho thai kỳ (thuốc lá, rượu, ma túy).

Trầm cảm có thể cản trở việc gắn kết với em bé đang lớn. Thai nhi có thể nhận ra giọng mẹ và cảm nhận cảm xúc qua cao độ, nhịp điệu và trọng âm. Người mang thai bị trầm cảm có thể khó tạo mối gắn kết này và cảm thấy cô lập về cảm xúc.

Thai kỳ ảnh hưởng đến trầm cảm thế nào?

- Những căng thẳng của thai kỳ có thể gây trầm cảm, hoặc làm tái phát/nặng thêm triệu chứng trầm cảm.
- Trầm cảm trong thai kỳ có thể khiến bạn dễ bị một đợt trầm cảm sau sinh.

Vậy tôi có những lựa chọn nào nếu bị trầm cảm khi mang thai?

- Chuẩn bị cho em bé là công việc vất vả, nhưng sức khỏe của bạn phải được đặt lên hàng đầu. Hãy tìm bớt mong muốn làm cho xong mọi thứ. Giảm việc nhà và làm những điều giúp bạn thư giãn. Hãy nhớ, chăm sóc bản thân là một phần thiết yếu của việc chăm sóc thai nhi.
- Chia sẻ lo lắng rất quan trọng. Hãy trò chuyện với bạn bè, bạn đời và gia đình. Nếu bạn ngó lơ nhờ hỗ trợ, bạn thường sẽ nhận được.

Nếu những thay đổi này không giúp bạn thuyên giảm lo âu và trầm cảm, hãy xin lời khuyên của bác sĩ hoặc giới thiệu đến chuyên gia sức khỏe tâm thần.

2. Ba tháng đầu thai kỳ

- › Ba tháng đầu thai kỳ của bạn
- › Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế
- › Siêu âm trước sinh
- › Hướng dẫn về buổi hẹn siêu âm
- › Sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể
- › Mã CPT của các xét nghiệm di truyền

Ba tháng đầu thai kỳ của bạn

Ba tháng đầu (Tuần 1 đến 12)

Ba tháng đầu kéo dài từ lúc thụ thai đến tuần 12. Trong giai đoạn này, em bé sẽ chuyển từ một nhóm nhỏ tế bào thành một thai nhi bắt đầu có các đặc điểm của em bé.

Tháng 1 (Tuần 1 đến 4)

Khi trứng đã thụ tinh lớn lên, một túi kín nước hình thành quanh nó và dần chứa đầy dịch. Đây là túi ối, giúp đệm bảo vệ phôi đang lớn.

Trong thời gian này, bánh rau cũng phát triển. Bánh rau là cơ quan tròn, dẹt, chuyển dưỡng chất từ mẹ sang con và mang chất thải của con đi. Hãy hình dung bánh rau như "nguồn thức ăn" cho em bé suốt thai kỳ.

Trong vài tuần đầu, một khuôn mặt sơ khai hình thành với hai vòng tròn sẫm màu lớn là mắt. Miệng, hàm dưới và họng đang phát triển. Tế bào máu đang hình thành và tuần hoàn bắt đầu. "Ống tim" nhỏ xíu sẽ đập 65 lần/phút vào cuối tuần thứ tư.

Cuối tháng đầu, em bé dài khoảng 1/4 inch (~0,6 cm) — nhỏ hơn một hạt gạo.

Tháng 2 (Tuần 5 đến 8)

Các đường nét khuôn mặt tiếp tục phát triển. Mỗi tai bắt đầu là một nếp da nhỏ ở bên đầu. Những chồi nhỏ sẽ thành tay và chân đang hình thành. Ngón tay, ngón chân và mắt cũng đang hình thành.

Ống thần kinh (não, tủy sống và mô thần kinh khác của hệ thần kinh trung ương) đã hình thành rõ. Ống tiêu hóa và các cơ quan cảm giác cũng bắt đầu phát triển. Xương bắt đầu thay thế sụn.

Lúc này đầu em bé lớn so với phần còn lại của cơ thể. Vào khoảng tuần thứ sáu, thường có thể phát hiện được tim thai. Sau tuần thứ tám, em bé được gọi là thai nhi (fetus) thay vì phôi (embryo).

Cuối tháng thứ hai, em bé dài khoảng 1 inch (~2,5 cm) và nặng khoảng 1/30 ounce (~1 g).

Tháng 3 (Tuần 9 đến 12)

Cánh tay, bàn tay, ngón tay, bàn chân và ngón chân của em bé đã hình thành đầy đủ. Ở giai đoạn này, em bé bắt đầu "khám phá" bằng cách nắm và mở bàn tay, miệng. Móng tay, móng chân bắt đầu phát triển và tai ngoài đã hình thành. Mầm răng đang hình thành dưới lợi. Cơ quan sinh sản cũng phát triển, nhưng khó phân biệt giới tính trên siêu âm.

Cuối tháng thứ ba, em bé đã hình thành đầy đủ. Tất cả cơ quan và chi đều có mặt và sẽ tiếp tục phát triển để hoạt động được. Hệ tuần hoàn và tiết niệu cũng đang hoạt động, và gan sản xuất mật.

Cuối tháng thứ ba, em bé dài khoảng 4 inch (~10 cm) và nặng khoảng 1 ounce (~28 g).

Vì giai đoạn phát triển quan trọng nhất đã diễn ra, nguy cơ sảy thai giảm đáng kể sau 3 tháng đầu.

Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế trong ba tháng đầu

Trong ba tháng đầu, có vài điều cần theo dõi. Hãy gọi ngay cho nhân viên y tế nếu bạn có:

- Sốt trên 100,4°F (38°C).
- Ra máu nhiều, thấm ướt hơn một băng vệ sinh mỗi giờ trong ba giờ liền.
- Đau quặn hoặc đau bụng bất thường, dữ dội.
- Nôn và/hoặc tiêu chảy nặng hoặc dai dẳng.
- Ngất hoặc chóng mặt.
- Đau, buốt hoặc khó tiểu.
- Tiết dịch âm đạo bất thường.
- Sưng tay, ngón tay hoặc mặt.
- Nhìn mờ hoặc thấy đốm trước mắt.
- Một tay hoặc một chân sưng hơn bên còn lại.
- Đau đầu dữ dội.
- Đau hoặc chuột rút ở tay, chân hoặc ngực.

Thông tin thêm về thai kỳ của bạn

Trong thai kỳ, bạn CÓ THỂ:

- Nhuộm tóc.
- Đắp móng acrylic.
- Làm test lao qua da (Mantoux®).
- Đi khám chỉnh hình cột sống (chiropractor).
- Cạo lông mu (xem dưới).
- Dùng thuốc xua côn trùng DEET.

Trong thai kỳ, bạn KHÔNG NÊN:

- Uống rượu, dùng ma túy hoặc hút thuốc.
- Nhịn ăn (fasting) trong các dịp lễ.
- Ngâm bồn sục (whirlpool) hoặc bồn nước nóng.
- Nằm giường tắm nắng (tanning bed).
- Cạo lông mu sát ngày sinh — nên tỉa (clipping) thì hơn.

Tài nguyên tham khảo

Một số trang web cung cấp tài liệu giáo dục về thai kỳ:

American College of Nurse-Midwives: www.midwife.org

Centers for Disease Control and Prevention, Pregnancy: <https://www.cdc.gov/pregnancy/index.html>

March of Dimes: <https://www.marchofdimes.org/>

The American College of Obstetricians and Gynecologists: <https://www.acog.org/>

Siêu âm trước sinh

Siêu âm là gì?

Trong siêu âm (ultrasonography), sóng âm tần số cao được phát qua bụng bạn bằng một thiết bị gọi là đầu dò (transducer). Sóng âm được ghi lại và chuyển thành hình ảnh video hoặc ảnh chụp của em bé. Siêu âm có thể dùng trong thai kỳ để cho thấy hình ảnh túi ối, bánh rau và buồng trứng.

Ý tưởng siêu âm bắt nguồn từ công nghệ sonar — dùng sóng âm để phát hiện vật dưới nước. Siêu âm có thể dùng kèm các thủ thuật chẩn đoán khác, như chọc ối, hoặc dùng riêng.

Siêu âm có tác dụng phụ không?

Các nghiên cứu cho thấy siêu âm không gây hại. Không có tác dụng phụ có hại cho bạn hoặc em bé. Ngoài ra, siêu âm không dùng tia xạ như chụp X-quang.

Siêu âm được thực hiện khi nào trong thai kỳ?

Siêu âm đầu dò âm đạo: Hầu hết siêu âm trước sinh làm trên bề mặt da, dùng gel làm môi trường dẫn để tăng chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, siêu âm đầu dò âm đạo dùng một đầu dò đưa vào ống âm đạo, cho hình ảnh chất lượng cao hơn nhiều. Siêu âm đầu dò âm đạo có thể dùng ở đầu thai kỳ để xác định tuổi thai nếu chưa chắc chắn, hoặc để quan sát rõ hơn tử cung, buồng trứng khi nghi ngờ có vấn đề.

Siêu âm thường (qua thành bụng): Thường được thực hiện cho mọi phụ nữ mang thai vào khoảng tuần 20. Trong lần siêu âm này, bác sĩ đánh giá bánh rau có bám bình thường không và em bé có phát triển tốt trong tử cung không. Có thể thấy tim thai và cử động của thân, tay, chân em bé trên siêu âm.

Nếu muốn biết giới tính, thường có thể xác định ở tuần 20. Hãy nói rõ với bác sĩ siêu âm là bạn có muốn biết giới tính hay không. Xin lưu ý siêu âm không chính xác 100% trong xác định giới tính; hình ảnh có thể bị đọc nhầm.

Siêu âm có thể làm sớm hơn để xác định: có nhiều hơn một thai hay không; ngày dự sinh hoặc tuổi thai.

Ở thai kỳ muộn hơn, siêu âm có thể dùng để xác định: sức khỏe thai; vị trí bánh rau; lượng nước ối quanh em bé; ngôi thai; cân nặng ước tính của em bé.

Trước, trong và sau khi siêu âm

Các bất thường giải phẫu lớn hoặc dị tật bẩm sinh có thể được phát hiện trước sinh trên siêu âm. Dù an toàn cho mẹ và bé, siêu âm chỉ nên làm khi cần thiết về y khoa. Nếu bạn siêu âm không vì lý do y khoa (ví dụ chỉ để xem bé hoặc biết giới tính), bảo hiểm có thể không chi trả.

Trước khi làm: Không cần chuẩn bị đặc biệt. Một số bác sĩ yêu cầu uống 4–6 cốc nước trước khi siêu âm để bàng quang đầy, giúp quan sát em bé rõ hơn; bạn sẽ được yêu cầu nhịn tiểu đến khi siêu âm xong. Bạn có thể được yêu cầu thay áo choàng bệnh viện.

Trong khi làm: Bạn nằm trên bàn khám có đệm. Một ít gel tan trong nước được bôi lên da bụng (gel không hại da,

không làm bẩn quần áo). Đầu dò được áp nhẹ lên da bụng, phát sóng âm tần số cao vào cơ thể; sóng phản xạ từ các cấu trúc bên trong (kể cả em bé) được đầu dò thu lại và chuyển thành hình ảnh trên màn hình, có thể in ra. Hầu như không khó chịu. Nếu cần bàng quang đầy, bạn có thể hơi khó chịu khi ấn đầu dò. Bạn có thể được yêu cầu nín thở vài lần trong chốc lát. Siêu âm mất khoảng 30 phút.

Sau khi làm: Gel sẽ được lau sạch. Siêu âm do kỹ thuật viên được đào tạo chuyên biệt thực hiện và do bác sĩ có chứng chỉ đọc kết quả. Bác sĩ của bạn sẽ trao đổi kết quả với bạn ở lần khám sau.

Hướng dẫn về buổi hẹn siêu âm



Siêu âm thai có thể là một sự kiện đầy háo hức, và đội ngũ chăm sóc rất vinh dự được chia sẻ trải nghiệm này. Tuy nhiên, siêu âm là một xét nghiệm y khoa do bác sĩ chỉ định. Mục tiêu chính của chúng tôi là mang lại dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Bằng cách tạo môi trường yên tĩnh, thoải mái, ít yếu tố gây xao nhãng, bạn sẽ nhận được hình ảnh chất lượng tốt nhất.

Bạn có thể giúp bằng cách:

- Giới hạn số người lớn đi cùng còn tối đa 2 người.
- Bảo đảm trẻ dưới 8 tuổi được một người lớn khác (không phải người bệnh) đi kèm và trông coi.
- Không dùng điện thoại, không quay phim/chụp ảnh trong lúc đang khám và tư vấn.

Thông tin quan trọng khác

- Hình ảnh giúp bạn và gia đình gắn kết với em bé. Tuy nhiên, độ rõ nét hay khả năng có được hình ảnh không được bảo đảm.
- Yêu cầu hình ảnh 3D không phải là phần tiêu chuẩn của lần khám và không được bảo đảm.
- Để bảo đảm lịch hẹn đúng giờ, bạn được đề nghị đến đúng giờ.
- Nếu bạn đến trễ so với giờ hẹn, bạn có thể phải chờ lâu để được sắp xếp lại, hoặc trong một số trường hợp phải hẹn lại.
- Nếu không muốn được cho biết giới tính ngay lúc siêu âm, bạn có thể nhận một phong bì niêm phong chứa thông tin đó. Các yêu cầu khác như gọi điện cho người không có mặt thì không thể đáp ứng.

Khám thai và siêu âm ở đâu tại Việt Nam?

[Đã bản địa hóa: bản gốc liệt kê các cơ sở của Cleveland Clinic tại Ohio và Florida (Hoa Kỳ).]

Bạn nên khám thai và siêu âm định kỳ tại cơ sở sản khoa mà bạn theo khám, để bác sĩ theo dõi liên tục thai kỳ. Một số bệnh viện sản khoa lớn để tham khảo:

- **Miền Bắc:** Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) — tổng đài 1900 1029.

- **Miền Nam:** Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) — tổng đài (028) 1081 / 1900 7237.
- **Hệ thống tư nhân (ví dụ):** Vinmec — tổng đài 1900 232 389.

Ngoài ra, các bệnh viện sản-nhi và bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đều có dịch vụ khám thai, siêu âm và sàng lọc trước sinh.

Sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể trong thai kỳ

Cleveland Clinic có các lựa chọn cho những người muốn xác định nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể (thừa hoặc thiếu số lượng nhiễm sắc thể) và một số dị tật bẩm sinh của em bé. Các xét nghiệm này cho phép phát hiện sớm trong thai kỳ.

Tuy nguy cơ sinh con bất thường nhiễm sắc thể tăng theo tuổi mẹ lúc sinh, phần lớn những em bé này lại sinh ra từ các bà mẹ trẻ. Vì vậy, sàng lọc là lựa chọn cho tất cả mọi người. Các xét nghiệm này tối ưu và chỉ nên làm sau khi trao đổi kỹ với nhân viên y tế. Trong một số trường hợp, bạn có thể được giới thiệu tư vấn di truyền để chọn xét nghiệm phù hợp.

Sàng lọc tuần tự (Sequential Screening)

Sàng lọc tuần tự kết hợp siêu âm và xét nghiệm máu để xác định nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, gồm hội chứng Down (trisomy 21) và trisomy 18. Nó cũng xác định nguy cơ nhóm dị tật gọi là dị tật ống thần kinh hở (ONTD), bao gồm nứt đốt sống. Siêu âm 3 tháng đầu đo độ mờ da gáy (nuchal translucency) — khoảng chứa dịch sau gáy, thường tăng kích thước ở thai bị Down, các bất thường nhiễm sắc thể khác và dị tật bẩm sinh. Xét nghiệm máu đo nồng độ một số nội tiết tố ở mẹ, được lấy vào lúc đo độ mờ da gáy và lần nữa vào tuần 15–21.

- Kết quả có sau xét nghiệm 3 tháng đầu và lại sau xét nghiệm máu 3 tháng giữa.
- Xét nghiệm này phát hiện 90–92% thai bị Down và 90% thai bị trisomy 18, với tỉ lệ dương tính giả 5%.
- Người có nguy cơ cao dựa trên kết quả sàng lọc tuần tự có thể làm thêm xét nghiệm cho câu trả lời chắc chắn hơn, như sinh thiết gai rau (CVS) hoặc chọc ối.
- Xét nghiệm tuần tự phát hiện khoảng 75–90% thai bị ONTD; kết hợp siêu âm 3 tháng giữa, khoảng 95% các trường hợp này có thể phát hiện.
- Không có nguy cơ cho mẹ hoặc thai với xét nghiệm sàng lọc tuần tự.
- Với người đến khám sau 3 tháng đầu hoặc quyết định sàng lọc muộn, có thể làm quad screen ở 3 tháng giữa (tuần 15–21). Xét nghiệm này phát hiện 75–80% Down và 60–75% trisomy 18, dương tính giả 5–7%; cũng phát hiện khoảng 80% ONTD.
- Mọi người bệnh, dù chọn sàng lọc hay không, đều được đề nghị siêu âm chi tiết đánh giá giải phẫu thai ở tuần 18–20.

Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn (NIPT) hay sàng lọc DNA tự do

NIPT đánh giá DNA của thai có trong máu mẹ để xác định nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Down, trisomy 18, trisomy 13, cũng như một số bất thường nhiễm sắc thể giới tính của thai. Đây là xét nghiệm máu của mẹ, không gây nguy cơ cho thai. NIPT có thể làm bất kỳ lúc nào

sau tuần 10. Trước đây NIPT được khuyến nghị cho người nguy cơ cao, nhưng bằng chứng gần đây ủng hộ dùng cả ở thai kỳ nguy cơ thấp và đa thai.

- NIPT phát hiện khoảng 99% thai bị Down và trisomy 18, và tới 92% thai bị trisomy 13.
- Dương tính giả hiếm nhưng có thể xảy ra, nhất là ở người trẻ.
- Không có nguy cơ cho mẹ hoặc thai.
- NIPT giảm nhu cầu xét nghiệm xâm lấn cho nhiều người; tuy nhiên, mọi kết quả dương tính cần được khẳng định bằng CVS hoặc chọc ối (đều là xét nghiệm chẩn đoán).
- NIPT không phát hiện mọi bất thường nhiễm sắc thể. Vì vậy, đôi khi vẫn cần chọc ối hoặc CVS nếu siêu âm bất thường, kể cả khi NIPT âm tính.
- NIPT không cho nguy cơ ONTD. Kết quả này có được qua xét nghiệm alpha-fetoprotein huyết thanh mẹ (MSAFP) làm ở tuần 15–21, cùng siêu âm chi tiết.
- Mọi người làm NIPT nên siêu âm chi tiết đánh giá giải phẫu thai ở tuần 18–20.

Mã CPT của các xét nghiệm di truyền

Dưới đây là danh sách các mã CPT thường gặp để bạn tham khảo. Một số xét nghiệm dưới đây được coi là xét nghiệm sàng lọc, nên bạn có thể liên hệ công ty bảo hiểm để biết thông tin chi trả trước khi làm.

THỦ THUẬT	MÃ CPT
Siêu âm sản đầu dò âm đạo	76817
Siêu âm sản < 14 tuần	76801
Siêu âm độ mờ da gáy	76813
Siêu âm giải phẫu thường quy	76805
Siêu âm giải phẫu chi tiết (nguy cơ cao)	76811
Siêu âm sản theo dõi	76816
Trắc đồ sinh vật lý thai (BPP)	76818, 76819
Doppler động mạch rốn	76820
Doppler động mạch não giữa thai	76821
Chọc ối (Amniocentesis)	59000 và 76946
Sinh thiết gai rau (CVS)	59015 và 76945
NIPT hoặc "MaterniT21" (qua Sequenom Lab)*	81420*

*Xem thêm tờ thông tin NIPT MaterniT21 (Sequenom Lab).

3. Ba tháng giữa thai kỳ

- › Ba tháng giữa thai kỳ của bạn
- › Chào mừng đến với ba tháng giữa
- › Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế
- › Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống

Ba tháng giữa thai kỳ của bạn

Cuối tháng thứ bảy, em bé dài khoảng 14 inch (~36 cm) và nặng từ 2 đến 4 pound (~900 g-1,8 kg).

Phần giữa của thai kỳ thường được coi là quãng thời gian dễ chịu nhất. Đến lúc này, cơn nghén có lẽ đã hết và những khó chịu của thai kỳ sớm đã lui. Em bé bắt đầu phát triển các đường nét khuôn mặt trong tháng này. Bạn cũng có thể bắt đầu cảm nhận cử động khi em bé lộn và xoay trong tử cung. Trong tam cá nguyệt này, nhiều người biết được giới tính của con, thường qua siêu âm hình thái (kiểm tra sự phát triển thể chất của bé) vào khoảng tuần 20.

Tháng 4 (Tuần 13 đến 16)

Có thể nghe được tim thai qua Doppler. Ngón tay, ngón chân đã rõ nét. Mi mắt, lông mày, lông mi, móng và tóc đã hình thành. Răng và xương chắc hơn. Em bé thậm chí có thể mút ngón cái, ngáp, vươn người và làm điệu bộ khuôn mặt. Hệ thần kinh bắt đầu hoạt động. Cơ quan sinh sản đã phát triển đầy đủ, và bác sĩ có thể thấy trên siêu âm bạn mang bé trai hay bé gái.

Cuối tháng thứ tư, em bé dài khoảng 6 inch (~15 cm) và nặng khoảng 4 ounce (~113 g).

Tháng 5 (Tuần 17 đến 20)

Ở giai đoạn này, bạn có thể bắt đầu cảm nhận em bé cử động. Em bé đang phát triển cơ và "tập" dùng chúng. Cử động đầu tiên này gọi là thai máu (quickening), có thể giống một cái phập phồng nhẹ. Tóc bắt đầu mọc trên đầu bé. Vai, lưng và thái dương của bé được phủ một lớp lông tơ mềm gọi là lanugo, giúp bảo vệ bé và thường rụng vào cuối tuần đầu đời.

Da bé được phủ một lớp màu trắng gọi là chất gây (vernix caseosa). Lớp "phô mai" này được cho là bảo vệ da bé khỏi tiếp xúc lâu với nước ối, và phần lớn bong ra ngay trước khi sinh.

Cuối tháng thứ năm, em bé dài khoảng 10 inch (~25 cm) và nặng từ 1/2 đến 1 pound (~230-450 g).

Tháng 6 (Tuần 21 đến 24)

Nếu nhìn vào trong tử cung lúc này, bạn sẽ thấy da bé đỏ, nhăn nheo và nhìn thấy mạch máu qua làn da trong mờ. Dấu vân tay, vân chân đã hiện. Ở giai đoạn này, mi mắt bắt đầu tách ra và mắt mở. Bé phản ứng với âm thanh bằng cách cử động hoặc tăng nhịp tim. Bạn có thể nhận thấy những cú giật khi bé nấc. Nếu sinh non, bé có thể sống sau tuần 23 với chăm sóc tích cực.

Cuối tháng thứ sáu, em bé dài khoảng 12 inch (~30 cm) và nặng khoảng 2 pound (~900 g).

Tháng 7 (Tuần 25 đến 28)

Em bé tiếp tục trưởng thành và tích mỡ dự trữ. Lúc này thính giác của bé đã phát triển đầy đủ. Bé đối tư thế thường xuyên và phản ứng với kích thích, gồm âm thanh, đau và ánh sáng. Nước ối bắt đầu giảm dần. Nếu sinh non, bé nhiều khả năng sống được sau tháng thứ bảy.

Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế trong ba tháng giữa (13–28 tuần)

Trong ba tháng giữa, có vài điều cần theo dõi. Hãy gọi ngay cho nhân viên y tế nếu bạn có:

- Đau quặn hoặc đau bụng bất thường, dữ dội.
- Thay đổi rõ rệt, như giảm cử động thai sau tuần 28 (ít hơn 6–10 cử động trong một giờ trở xuống).
- Khó thở hoặc hụt hơi có vẻ nặng dần.
- Dấu hiệu chuyển dạ sinh non, gồm: co cứng hoặc đau đều đặn vùng bụng dưới hoặc lưng; ra máu trong 3 tháng giữa hoặc cuối; rỉ ối; cảm giác đè nặng ở vùng chậu hoặc âm đạo.

Xét nghiệm yếu tố Rh trong ba tháng giữa

Yếu tố Rh là một protein kháng nguyên có trên hồng cầu của phần lớn mọi người. Nếu bạn không có protein này thì bạn là Rh âm (Rh-). Bạn sẽ được tiêm globulin miễn dịch Rh (gọi là Rhogam®) vào tuần thứ 28 để ngăn cơ thể tạo kháng thể có thể gây hại cho em bé. Bạn cũng sẽ được tiêm Rhogam® sau sinh nếu em bé có máu Rh+.

Nếu bạn Rh-, bạn cũng có thể được tiêm mũi này nếu:

- Làm thủ thuật xâm lấn (như chọc ối).
- Bị chấn thương bụng.
- Bị ra máu đáng kể trong thai kỳ.
- Cần xoay ngôi thai trong tử cung (do ngôi mông).

Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống trong thai kỳ

Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống là gì?

Nghiệm pháp này được thực hiện để sàng lọc đái tháo đường thai kỳ. Bạn uống nhanh (trong 5 phút) một dung dịch ngọt (gọi là Glucola) chứa 50 gam glucose. Khoảng 60 phút sau, một mẫu máu được lấy từ tĩnh mạch ở tay để đo cách cơ thể xử lý dung dịch glucose.

Đường huyết bình thường đạt đỉnh trong 30–60 phút sau khi uống. Đường huyết cao hơn bình thường không phải lúc nào cũng nghĩa là bạn bị đái tháo đường thai kỳ.

Nghiệm pháp được thực hiện khi nào?

Đái tháo đường thai kỳ thường được chẩn đoán trong khoảng tuần 24–28. Nếu bạn từng bị đái tháo đường thai kỳ ở lần mang thai trước, hoặc nhân viên y tế lo ngại về nguy cơ, xét nghiệm có thể làm sớm hơn.

Vào ngày làm xét nghiệm, hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế hoặc phòng xét nghiệm (nếu có).

Hướng dẫn chung

Bạn có thể ăn sáng nhẹ vào ngày xét nghiệm, tránh món nhiều đường như nước cam, bánh kẹo và bánh donut. Đến địa điểm chỉ định để uống Glucola. Sau khi uống, không ăn uống gì và không hút thuốc cho đến khi được lấy máu, một giờ sau. Nếu phòng khám có phòng xét nghiệm, có thể làm ngay trong một buổi khám thai.

Xét nghiệm chẩn đoán tiếp theo

Nếu nhân viên y tế xác định đường huyết của bạn tăng, bạn sẽ làm thêm một xét nghiệm sàng lọc đái tháo đường thai kỳ nữa. Xét nghiệm tiếp theo gọi là nghiệm pháp dung nạp glucose — dài hơn, chắc chắn hơn, để xác định bạn có bị đái tháo đường thai kỳ không. Nếu cần làm, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn thêm cho bạn về cách thực hiện.

4. Ba tháng cuối thai kỳ

- › Ba tháng cuối thai kỳ của bạn
- › Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế trong ba tháng cuối
- › Đếm cử động thai (máy đập)
- › Non-stress test (đo tim thai không kích thích)
- › Liên cầu khuẩn nhóm B và thai kỳ
- › Chuyển dạ thật và chuyển dạ giả
- › Chuyển dạ sinh non
- › Chuẩn bị đồ đi sinh
- › Ngày bé chào đời
- › Các phương pháp sinh
- › Các lựa chọn giảm đau khi sinh

Ba tháng cuối thai kỳ của bạn

Đây là phần cuối của thai kỳ. Trong tam cá nguyệt này, em bé sẽ trưởng thành và tăng cân. Bạn sẽ gặp các triệu chứng như đi tiểu nhiều, đau lưng, thậm chí nấc — vốn là bình thường ở giai đoạn này. Bạn có thể muốn đếm ngược đến ngày dự sinh và mong bé ra sớm, nhưng mỗi tuần ở giai đoạn cuối đều giúp bé chuẩn bị cho việc chào đời. Suốt tam cá nguyệt này, bé tăng cân nhanh, tích mỡ giúp ích sau sinh.

Hãy nhớ, dù người ta hay nói thai kỳ 9 tháng, thực tế bạn có thể mang thai tới 10 tháng. Một thai kỳ đủ tháng điển hình là 40 tuần, có thể kéo sang tháng thứ mười. Bạn cũng có thể vượt ngày dự sinh 1-2 tuần (41 hoặc 42 tuần). Nhân viên y tế sẽ theo dõi sát khi gần đến ngày dự sinh. Nếu quá ngày mà không chuyển dạ tự nhiên, họ có thể khởi phát chuyển dạ — dùng thuốc để giúp bạn vào chuyển dạ và sinh. Hãy trao đổi với nhân viên y tế về kế hoạch sinh trong tam cá nguyệt này.

Tháng 8 (Tuần 29 đến 32)

Em bé tiếp tục trưởng thành và tích mỡ. Bạn có thể thấy bé đạp nhiều hơn. Não bé phát triển nhanh, và bé có thể nhìn, nghe. Hầu hết các hệ cơ quan bên trong đã phát triển tốt, nhưng phổi có thể còn chưa trưởng thành. Em bé dài khoảng 18 inch (~46 cm) và nặng tới 5 pound (~2,3 kg).

Tháng 9 (Tuần 33 đến 36)

Bé tiếp tục lớn và trưởng thành. Phổi gần như đã phát triển đầy đủ. Phản xạ của bé đã phối hợp: chớp mắt, nhắm mắt, quay đầu, nắm chặt và phản ứng với âm thanh, ánh sáng, va chạm. Bé dài khoảng 17-19 inch (~43-48 cm) và nặng 5,5-6,5 pound (~2,5-3 kg).

Tháng 10 (Tuần 37 đến 40)

Trong tháng cuối này, bạn có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Bạn có thể thấy bé cử động ít hơn do không gian chật. Lúc này ngôi thai có thể đã thay đổi để chuẩn bị sinh — lý tưởng là bé chúc đầu xuống. Bạn có thể rất khó chịu ở chặng cuối này khi bé tụt xuống khung chậu. Bé đã sẵn sàng chào đời. Bé dài khoảng 18-20 inch (~46-51 cm) và nặng khoảng 7 pound (~3,2 kg).

Khi nào cần gọi cho nhân viên y tế trong ba tháng cuối (29–41 tuần)

Trong ba tháng cuối, hãy gọi ngay cho nhân viên y tế nếu bạn có:

- Đau quặn hoặc đau bụng bất thường, dữ dội.
- Thay đổi rõ rệt, như giảm cử động thai sau tuần 28 (ít hơn 6–10 cử động trong một giờ trở xuống).
- Khó thở hoặc hụt hơi có vẻ nặng dần.

(37–41 tuần) Cleveland Clinic tuân theo hướng dẫn quốc gia của ACOG về khởi phát chuyển dạ. Nếu thai kỳ khỏe mạnh, tốt nhất là để chuyển dạ tự bắt đầu. Cleveland Clinic khuyến cáo không khởi phát chuyển dạ trước tuần 41 với mẹ khỏe, con khỏe. Phụ nữ chuyển dạ tự nhiên có nguy cơ biến chứng thấp hơn, như mổ lấy thai và chảy máu quá mức.

Dấu hiệu chuyển dạ sinh non (trước 36 tuần)

- Từ 4 cơn gò trở lên (cơ tử cung co) trong một giờ, không hết sau khi đổi tư thế hoặc nghỉ ngơi.
- Co cứng đều đặn hoặc đau âm ỉ vùng lưng dưới, dai dẳng hoặc từng cơn (không đỡ khi đổi tư thế hoặc dùng biện pháp để chịu khác).
- Cảm giác đè nặng ở vùng chậu hoặc âm đạo.
- Đau quặn bụng dưới, có thể giống đau do đầy hơi (kèm hoặc không kèm tiêu chảy).
- Tăng cảm giác đè nặng ở vùng chậu hoặc âm đạo.
- Đau quặn kiểu hành kinh dai dẳng.
- Tăng tiết dịch âm đạo.
- Rỉ dịch từ âm đạo.
- Ra máu âm đạo.
- Triệu chứng giống cúm như buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Dấu hiệu chuyển dạ sau 36 tuần

- Vỡ ối.
- Cơn gò mạnh xuất hiện mỗi 5 phút trong một giờ.
- Cơn gò không dừng lại dù đổi tư thế hoặc thư giãn.
- Cơn gò khiến bạn không thể đi lại được.

Những việc cần làm trước ngày trọng đại

- Đăng ký tại bệnh viện nơi bạn sẽ sinh.
- Chọn bác sĩ nhi. Hẹn đến thăm phòng khám và gặp bác sĩ nếu muốn.
- Tham quan khoa sản. Một số bệnh viện có tour cho anh chị của bé. Tour giúp bạn biết chỗ để xe và nơi được đưa đến trong ngày sinh.
- Biết số điện thoại buổi tối của nhân viên y tế và xem lại cách liên lạc với người chờ/người hỗ trợ.
- Nếu muốn học lớp tiền sản hoặc nuôi con bằng sữa mẹ, đây là lúc. Nhiều bệnh viện sản-nhi ở Việt Nam có lớp học tiền sản; hãy hỏi nơi bạn khám thai.

- Đi khám răng nếu lâu chưa khám.
- Cập nhật hợp đồng bảo hiểm và di chúc để thêm em bé. Chúng tôi khuyến khích lập di chúc sống và giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe.
- Liên hệ bảo hiểm về máy hút sữa — họ sẽ hướng dẫn nơi lấy.
- Quyết định có lưu máu cuống rốn để dùng riêng hoặc hiến tặng không.
- Quyết định biện pháp tránh thai sau sinh.
- Cân nhắc lợi và hại của việc cắt bao quy đầu cho bé trai.
- Chuẩn bị giấy tờ nghỉ thai sản/ngỉ chăm con cho cả bạn và bạn đời.
- Mua những thứ bé cần, nhất là ghế ngồi ô tô.
- Tiếp tục uống viên bổ sung, bảo đảm đủ calci và sắt.

Đếm cử động thai (đếm cú đạp/NST)

Cử động đều đặn của em bé là dấu hiệu sức khỏe tốt

Tuy bé có thể ngủ tới một giờ, phần lớn thời gian bé hoạt động và cử động. Trung bình, một bé khỏe mạnh đạp hoặc cử động ít nhất 6–10 lần trong một giờ.

Cách dễ dàng để kiểm tra sức khỏe của bé là theo dõi cử động hai lần mỗi ngày ("đếm cú đạp"). Nên bắt đầu đếm từ tuần 28–30 và tiếp tục mỗi ngày cho đến khi sinh.

Cách đếm và ghi lại cử động của bé

Chọn một thời điểm hai lần mỗi ngày để ghi cử động của bé. Bé có thể máy nhiều nhất khi bạn nghỉ ngơi. Nhiều phụ nữ thấy sau bữa ăn là lúc tốt nhất để đếm. Ngồi tư thế thoải mái, đặt hai tay úp lên bụng.

Khi bắt đầu đếm, hãy xem giờ, ghi giờ bắt đầu và đếm mỗi lần bạn cảm nhận bé đạp, cử động, lộn, phập phồng hoặc lướt nhẹ. Tiếp tục đếm đến khi bé cử động 6–10 lần. Nếu không đếm được 6–10 cử động trong một giờ trở xuống, hãy gọi ngay nhân viên y tế để được hướng dẫn thêm.

Non-stress test (NST) – đo tim thai không kích thích

NST là xét nghiệm đặc biệt phổ biến nhất về thai. Nó đo nhịp tim của bé để đáp ứng với môi trường. NST có thể làm tại phòng khám hoặc bệnh viện, khi bạn ngồi ghế hoặc nằm. Xét nghiệm mất khoảng 20 phút.

Hai đai được đặt lên bụng bạn: một có cảm biến đo nhịp tim thai, một phát hiện cơn gò tử cung. Bạn cũng được yêu cầu ghi cử động của bé bằng cách bấm nút. Hầu hết em bé có chu kỳ ngủ/thức 20–40 phút.

Kết quả NST do nhân viên y tế đọc. Tùy kết quả, bạn có thể làm thêm xét nghiệm như trắc đồ sinh vật lý (BPP) hoặc nghiệm pháp gò (contraction stress test).

Liên cầu khuẩn nhóm B và thai kỳ

Liên cầu khuẩn nhóm B là gì?

Liên cầu khuẩn nhóm B (GBS) là một vi khuẩn (vi trùng) bình thường có ở nhiều phụ nữ mang thai. Người mang GBS có thể truyền vi khuẩn cho con khi sinh. Hầu hết trẻ sơ sinh nhiễm GBS không mắc bệnh. Tuy nhiên, vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng ở một tỉ lệ nhỏ trẻ sơ sinh.

Em bé nhiễm GBS như thế nào?

Ở phụ nữ mang thai, GBS thường thấy nhất ở âm đạo và trực tràng (khác với viêm họng liên cầu, do liên cầu nhóm A). GBS có thể sống trong cơ thể mẹ và gây triệu chứng, gây nhiễm trùng; nhưng cũng có thể sống mà không gây triệu chứng và không nguy hiểm cho sức khỏe mẹ — khi đó người mẹ được gọi là "người mang" (carrier).

Nhiễm sớm: Trong số trẻ bị nhiễm, phần lớn (75%) xảy ra trong tuần đầu đời; thực tế hầu hết biểu hiện trong vài giờ sau sinh. Nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi và viêm màng não là các vấn đề thường gặp nhất. Trẻ sinh non có nguy cơ cao hơn nếu nhiễm, nhưng hầu hết trẻ (75%) nhiễm GBS lại là trẻ đủ tháng.

Nhiễm muộn: Nhiễm GBS cũng có thể xảy ra từ một tuần đến vài tháng sau sinh. Viêm màng não hay gặp hơn ở nhiễm muộn so với nhiễm sớm. Khoảng một nửa số trẻ nhiễm muộn bị lây từ mẹ khi sinh; nguồn lây của số còn lại được cho là tiếp xúc với người mang GBS khác. Nhiễm muộn ít gặp hơn và ít gây tử vong hơn nhiễm sớm.

Tôi có được xét nghiệm GBS không?

Bác sĩ sẽ xét nghiệm GBS cho bạn vào cuối thai kỳ, khoảng tuần 35–37, bằng tăm bông lấy mẫu tế bào từ âm đạo, cổ tử cung và trực tràng. Xét nghiệm sớm hơn thời điểm này không giúp dự đoán bạn có mang GBS lúc sinh hay không.

Lúc sinh là thời điểm trẻ tăng phơi nhiễm GBS nếu vi khuẩn có ở âm đạo hoặc trực tràng của mẹ. Kết quả cấy dương tính nghĩa là bạn mang GBS, nhưng không có nghĩa bạn hoặc bé chắc chắn sẽ bị bệnh.

GBS được điều trị thế nào?

Ở người mẹ: Cách hiệu quả nhất để phòng nhiễm GBS cho bé là điều trị kháng sinh cho bạn trong lúc chuyển dạ nếu bạn dương tính. Mang GBS là tình trạng tạm thời. Điều trị vào lúc chuyển dạ là quan trọng, vì điều trị sớm hơn không hiệu quả. Nếu dương tính, nhân viên y tế sẽ truyền kháng sinh qua tĩnh mạch trong lúc chuyển dạ và sinh; cách này phòng được 90% ca nhiễm. Một ngoại lệ về thời điểm điều trị là khi phát hiện GBS trong nước tiểu — khi đó nên bắt đầu kháng sinh uống ngay khi phát hiện, bất kể giai đoạn thai kỳ, và tiêm lại qua tĩnh mạch khi chuyển dạ. Phụ nữ từng sinh con bị nhiễm GBS, hoặc bị nhiễm trùng tiết niệu do GBS trong thai kỳ này, cũng sẽ được điều trị khi chuyển dạ.

Ở trẻ sơ sinh: Dù đã xét nghiệm và điều trị kháng sinh trong lúc mẹ chuyển dạ, một số trẻ vẫn nhiễm GBS. Triệu chứng thường gặp gồm sốt, khó bú, kích thích hoặc lơ đãng (mềm nhũn hoặc khó đánh thức). Bác sĩ có thể lấy mẫu máu hoặc dịch não tủy của bé để kiểm tra. Kháng sinh sẽ được dùng nếu cần điều trị.

Chuyển dạ thật và chuyển dạ giả

Trước khi chuyển dạ thật, bạn có thể có cơn đau chuyển dạ giả, còn gọi là cơn gò Braxton Hicks. Những cơn gò tử cung không đều này hoàn toàn bình thường và có thể bắt đầu từ tháng thứ tư. Đây là cách cơ thể chuẩn bị cho "chuyện thật".

Cơn gò Braxton Hicks có cảm giác thế nào?

Cơn gò Braxton Hicks có thể mô tả như cảm giác căng cứng ở bụng đến rồi đi. Chúng không xích lại gần nhau hơn, không tăng thời lượng hay tần suất, và không mạnh dần theo thời gian. Chúng thường xuất hiện khi đổi tư thế và dừng khi nghỉ.

Cơn gò chuyển dạ thật có cảm giác thế nào?

Cảm giác cơn gò khác nhau ở mỗi người và có thể khác giữa các lần mang thai. Cơn gò chuyển dạ gây khó chịu hoặc đau âm ỉ ở lưng và bụng dưới, kèm cảm giác đè nặng ở vùng chậu. Một số người còn thấy đau hai bên hông và đùi. Có người mô tả cơn gò như đau bụng hành kinh mạnh, người khác mô tả như những đợt sóng mạnh giống đau bụng tiêu chảy.

Vậy làm sao biết là chuyển dạ thật?

Thời điểm cơn gò: Chuyển dạ giả: cơn gò thường không đều và không xích lại gần nhau. Chuyển dạ thật: cơn gò đến đều đặn và xích lại gần nhau theo thời gian, đồng thời dài hơn, mạnh hơn và dữ dội hơn (mỗi cơn kéo dài khoảng 30–70 giây).

Thay đổi khi cử động: Chuyển dạ giả: cơn gò có thể dừng khi bạn đi lại hoặc nghỉ, thậm chí khi đổi tư thế. Chuyển dạ thật: cơn gò vẫn tiếp tục dù bạn cử động hay đổi tư thế.

Cơn đau nhói, buốt hai bên bụng lan xuống bẹn có thể do các dây chằng nâng đỡ tử cung đang lớn bị căng.

Để giảm khó chịu do đau chuyển dạ giả:

- Thử đổi tư thế hoặc hoạt động.
- Bảo đảm uống đủ nước (ít nhất 10–12 cốc nước, nước ép hoặc sữa mỗi ngày).
- Cố gắng nghỉ ngơi và thư giãn.

Nhân viên y tế luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc bất cứ lúc nào. Đừng ngại gọi nếu bạn không chắc mình đang cảm thấy gì. Họ có thể hỏi vài câu để xác định bạn có thật sự chuyển dạ không. Nếu còn nghi ngờ, tốt hơn là được nhân viên y tế đánh giá.

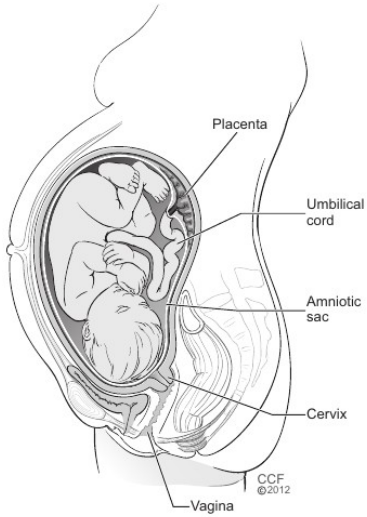
Điều cần thiết là gọi ngay cho nhân viên y tế nếu bạn có:

- Ra máu âm đạo đỏ tươi.
- Rỉ dịch hoặc ẩm ướt liên tục, hoặc vỡ ối (cảm nhận như dòng nước trào ra).
- Cơn gò mạnh mỗi 5 phút trong một giờ.
- Cơn gò khiến bạn không thể đi lại được.

- Thay đổi rõ rệt về cử động thai, hoặc thấy ít hơn 6–10 cử động trong một giờ.

Chuyển dạ sinh non

Chuyển dạ sinh non là gì?



Chuyển dạ sinh non (pre-term) là chuyển dạ bắt đầu sớm hơn 3 tuần so với ngày dự sinh. Cơ gò (cơ tử cung co) khiến cổ tử cung mở sớm hơn bình thường. Chuyển dạ sinh non có thể dẫn đến sinh một em bé non tháng.

Tuy nhiên, chuyển dạ thường có thể được ngăn lại để bé có thêm thời gian lớn và phát triển trong tử cung. Các cách ngăn chuyển dạ sinh non gồm nghỉ ngơi tại giường, truyền dịch tĩnh mạch và thuốc làm giãn tử cung.

Dấu hiệu chuyển dạ sinh non là gì?

Việc học các dấu hiệu chuyển dạ sinh non rất quan trọng để bạn được giúp đỡ kịp thời, tránh sinh quá sớm. Để kiểm tra cơ gò, đặt các đầu ngón tay lên bụng. Nếu cảm nhận tử cung căng lên rồi mềm ra, hãy ghi lại tần suất cơ gò.

Hãy gọi ngay nhân viên y tế nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây và chúng không hết trong một giờ, hoặc nếu đau dữ dội và dai dẳng:

- Từ 4 cơn gò trở lên trong một giờ, không hết sau khi đổi tư thế hoặc nghỉ.
- Co cứng đều đặn hoặc đau âm ỉ vùng lưng dưới, dai dẳng hoặc từng cơn (không đỡ khi đổi tư thế).
- Đau quặn bụng dưới, có thể giống đau do đầy hơi (kèm hoặc không kèm tiêu chảy).
- Tăng cảm giác đè nặng ở vùng chậu hoặc âm đạo.
- Đau quặn kiểu hành kinh dai dẳng.
- Tăng tiết dịch âm đạo.
- Rỉ dịch từ âm đạo.
- Ra máu âm đạo.
- Triệu chứng giống cúm như buồn nôn, nôn và tiêu chảy.
- Giảm cử động thai (ít hơn 6–10 lần trong một giờ).

Nếu nhân viên y tế bảo bạn đến bệnh viện thì sao?

Sau khi bạn trao đổi về các dấu hiệu chuyển dạ sinh non, họ có thể bảo bạn đến bệnh viện. Khi đến nơi:

- Mạch, huyết áp và nhiệt độ sẽ được kiểm tra.
- Một máy theo dõi được đặt lên bụng để kiểm tra nhịp tim thai và đánh giá cơn gò tử cung.
- Cổ tử cung sẽ được kiểm tra xem có mở không.

Nếu bạn đang chuyển dạ sinh non, bạn có thể được dùng thuốc để ngăn chuyển dạ. Nếu chuyển dạ đã tiến triển và không ngăn được, bạn có thể phải sinh. Nếu bạn không chuyển dạ sinh non, bạn sẽ được về nhà.

Chuẩn bị đồ đi sinh

Nên chuẩn bị túi đồ trước ngày dự sinh 1-2 tháng để khỏi vội vàng khi đến lúc đi!

Một số gợi ý đồ mang theo cho mẹ:

- Giấy tờ tùy thân có ảnh và thẻ bảo hiểm.
- Đồ vệ sinh cá nhân (kính áp tròng, kính, son dưỡng môi, xà phòng, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng, bàn chải và kem đánh răng...).
- Phụ kiện buộc tóc nếu cần.
- Dụng cụ xoa bóp lưng như bóng tennis, máy massage cầm tay...
- Tinh dầu thơm.
- Áo choàng.
- 1-2 áo ngủ hoặc đồ ngủ thoải mái (bệnh viện cũng có áo choàng cho bạn dùng).
- 3-4 quần lót cotton.
- Dép/tất.
- 2-3 áo ngực nâng đỡ tốt; áo cho con bú là phù hợp.
- Danh sách tên và số điện thoại người thân, bạn bè để báo tin vui!
- Đồ giải trí cá nhân: sách, tạp chí, phim đã tải sẵn... NHỚ MANG DÂY SẠC.
- Giày thoải mái để mặc khi về.

Người hỗ trợ (labor coach) nên mang theo:

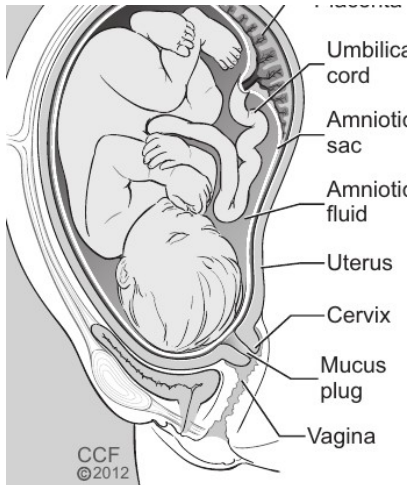
- Đồ ăn nhẹ hoặc tiền mua đồ ăn.
- Ít nhất một bộ quần áo để thay.
- Đồ vệ sinh cá nhân, dép/tất, đồ ngủ thoải mái.
- Điện thoại và bộ sạc thiết bị.

Đồ nên chuẩn bị cho em bé:

- Ghế ngồi ô tô (nếu đưa bé về bằng ô tô): nên lắp trước ngày dự sinh khoảng một tháng để chắc chắn lắp đúng. Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất; nếu chưa chắc, nhờ người có kinh nghiệm hoặc đại lý bán ghế kiểm tra giúp.
- Áo lót (không dùng loại "onesie" liền quần để không che dây rốn).
- Bộ đồ ngủ (sleeper), khăn quấn (receiving blanket), mũ.
- Quần áo mặc khi về (chọn theo thời tiết: lạnh thì đồ ấm, nóng thì đồ mát).

Xin lưu ý: Mọi thứ bé cần trong thời gian ở viện đều được cung cấp, kể cả tã.

Ngày bé chào đời: Những gì diễn ra khi chuyển dạ



Cảm thấy vừa háo hức vừa lo sợ về chuyện chuyển dạ, sinh nở là điều bình thường. Hy vọng phần này giúp giải đáp thắc mắc để bạn biết điều gì sẽ đến.

Chuyển dạ bắt đầu khi nào?

Chuyển dạ bắt đầu khi cổ tử cung mở (dilate) và mỏng đi (efface). Cơ tử cung co (gò) đều đặn. Trong cơn gò (hay đợt sóng), bụng cứng lại; giữa các cơn, bụng mềm ra khi tử cung thư giãn.

Làm sao biết tôi đang chuyển dạ?

Có người có dấu hiệu rất rõ, người khác thì không. Nhiều người cảm nhận mình đang chuyển dạ sớm mà không thật chắc chắn. Không ai biết nguyên nhân khởi phát chuyển dạ, nhưng nhiều thay đổi nội tiết và thể chất có thể báo hiệu. Cơn gò thường bắt đầu đều đặn nhưng cách quãng, rồi dần mạnh hơn và thường xuyên hơn. Bạn để ý những đợt sóng kéo dài trọn một phút. Nếu nghĩ mình chuyển dạ nhưng không chắc, hãy gọi nhân viên y tế để trao đổi.

Một số thay đổi bạn có thể gặp:

Sa bụng (Lightening): Là quá trình bé lún xuống khung chậu. Có thể xảy ra vài tuần hoặc vài giờ trước chuyển dạ. Vì tử cung đè lên bàng quang, bạn có thể thấy mót tiểu nhiều hơn.

Nút nhầy cổ tử cung (Mucous Plug): Nút nhầy tích tụ ở lỗ cổ tử cung trong thai kỳ để bảo vệ bé. Khi cổ tử cung bắt đầu mở, bạn có thể thấy một ít nhầy — trong, hồng hoặc lẫn máu. Chuyển dạ có thể bắt đầu ngay sau khi ra nút nhầy, hoặc vài tuần sau.

Cơn gò (Contractions): Chuyển dạ là khi cơn gò đến đều đặn và tăng về tần suất, thời lượng và cường độ. Cơn gò chuyển dạ gây khó chịu hoặc đau âm ỉ ở lưng và bụng dưới, kèm đè nặng vùng chậu dưới. Bạn có thể thấy ra ít máu âm đạo. Cơn gò chuyển dạ không dừng khi đổi tư thế, uống nước hay thư giãn. Dù cơn gò khó chịu, bạn vẫn có thể thư giãn giữa các cơn.

Phần đầu này gọi là giai đoạn I (pha tiềm tàng), dễ chịu đựng hơn ở nhà so với ở viện. Tất nhiên, hãy chắc chắn bé cử động bình thường — đây là lúc tốt để đếm cú đạp. Nếu lo lắng, hãy liên hệ nhân viên y tế.

Bấm giờ cơn gò

Ghi lại giờ bắt đầu và giờ kết thúc của cùng một cơn gò, gồm cả thời gian gò và thời gian nghỉ trước cơn kế tiếp.

Vài gợi ý giúp bạn vượt qua chuyển dạ sớm: nếu cơn gò thật sự và bạn đang chuyển dạ thật, bạn sẽ không làm chúng dịu đi được. Cơn nào làm dịu được thì ít khả năng là chuyển dạ thật. Hãy thử:

- Đánh lạc hướng bằng cách đi dạo, mua sắm hoặc xem phim.
- Ngâm bồn nước ấm hoặc tắm nước ấm.
- Cố gắng ngủ — bạn sẽ cần năng lượng cho cuộc chuyển dạ!

Vỡ ối

Túi ối quanh bé chỉ vỡ khoảng 10% số trường hợp. Nếu vỡ, bạn có thể thấy dòng nước trào ra đột ngột hoặc rỉ đều đặn. Dịch này thường màu vàng rơm và không mùi. Nếu vỡ ối, hãy báo nhân viên y tế. Hãy nhớ từ TACO và báo chi tiết: T (Time) = giờ vỡ ối, A (Amount) = lượng dịch, C (Color) = màu dịch, O (Odor) = mùi dịch.

Chuyển dạ có thể chưa bắt đầu ngay. Như mọi khi, hãy chắc chắn bé cử động tốt. Nếu lo lắng, hãy báo cho chúng tôi!

Xóa và mở cổ tử cung

Cổ tử cung ngắn lại và mỏng đi để căng và mở quanh đầu bé. Việc ngắn và mỏng đi gọi là xóa (effacement), đo bằng phần trăm từ 0% đến 100%. Việc căng và mở gọi là mở cổ tử cung (dilation), đo từ 1 đến 10 cm. Xóa và mở là kết quả trực tiếp của các cơn gò tử cung hiệu quả. Tiến triển chuyển dạ được đo bằng mức cổ tử cung đã mở và mỏng để bé đi qua âm đạo.

Khi nào nên gọi nhân viên y tế hoặc đến bệnh viện?

Hãy gọi theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Gọi trong lúc chuyển dạ sớm nếu bạn có thắc mắc hoặc lo lắng. Cũng gọi nếu:

- Bạn nghĩ mình đã vỡ ối.
- Bạn ra máu nhiều hơn chỉ là rỉ máu.
- Cơn gò rất mạnh — bạn không đi lại được — và đã như vậy mỗi 3–5 phút suốt một giờ. (Nếu đã sinh một lần, bạn có thể không muốn chờ lâu vậy — hãy trao đổi với nhân viên y tế.)
- Bạn lo lắng về cử động của bé.

Điều gì diễn ra khi tôi đến bệnh viện?

Khi đến viện, bạn sẽ đến khoa Chuyển dạ và Sinh (Labor and Delivery) và làm thủ tục. Thường bạn được khám ở khu vực phân loại (triage) trước, để nhập viện hoặc làm xét nghiệm. Chỉ nên có một người đi cùng bạn vào khu triage vì phòng

khá nhỏ. Nếu được nhập viện, bạn sẽ được đưa đến phòng chuyển dạ. Tại đó, bạn có thể trải qua:

- Kiểm tra mạch, huyết áp và nhiệt độ.
- Máy theo dõi được đặt lên bụng để theo dõi nhịp tim thai và cơn gò.
- Điều dưỡng hoặc nhân viên y tế khám cổ tử cung xem chuyển dạ tiến triển đến đâu.
- Đặt đường truyền tĩnh mạch (IV) ở tay để truyền dịch và thuốc.

Các giai đoạn của chuyển dạ

Giai đoạn I là phần dài nhất, chia làm hai phần: chuyển dạ sớm và chuyển dạ tích cực.

Chuyển dạ sớm: Cổ tử cung bắt đầu mở và xóa nhờ các cơn gò đều đặn, mạnh dần. Một số người thấy ra ít dịch lẫn máu. Chuyển dạ sớm có thể kéo dài hàng giờ đến hàng ngày. Tốt nhất là ở nhà, miễn là bé vẫn cử động tốt. Đây là lúc dùng các cách đánh lạc hướng đã nói. Sự hào hứng thường dâng cao trong chuyển dạ sớm.

Chuyển dạ tích cực: Cơn gò mạnh hơn và gần nhau hơn. Chúng tôi thường bảo người bệnh gọi khi cơn gò cách nhau 5 phút, kéo dài 1 phút và đã đều đặn suốt 1 giờ — hãy nhớ "5-1-1". Bạn có thể thấy cơn gò cả ở bụng và lưng. Đây là lúc gọi cho chúng tôi và đến viện. Ổi có thể vỡ (hoặc chưa). Đôi khi trong chuyển dạ tích cực, háo hức nhường chỗ cho do dự và sợ hãi; bạn có thể xin giảm đau ở giai đoạn này. Đây là lúc tốt để trao đổi với nhân viên y tế về cách giảm đau phù hợp — chỉ bạn mới biết mình muốn gì.

Giai đoạn II bắt đầu khi cổ tử cung mở trọn. Hầu hết mọi người thấy mệt rã khi bước vào giai đoạn này. Có thể mất vài phút đến vài giờ để rặn bé ra. Thời gian dài ngắn tùy việc bạn đã sinh lần nào chưa, kích thích và ngôi thai của bé. Bạn có thể thử rặn ở nhiều tư thế; đôi khi tốt nhất là ở tư thế chống tay và gối. Nhân viên y tế có thể yêu cầu bạn rặn nhẹ hơn để tăng sinh môn căng từ từ, giảm tổn thương. Khi đầu bé ra, thân sẽ ra nhanh theo. Bé sẽ được đặt lên bụng bạn nếu mọi việc thuận lợi. Thường khi không có biến chứng, bạn hoặc bạn đời có thể "đón" bé. Sau một khoảng ngắn, dây rốn được kẹp và cắt, rồi chờ sổ rau.

Giai đoạn III là lúc sổ rau. Thường bạn chỉ cần tập trung vào bé và thư giãn; đôi khi chúng tôi yêu cầu bạn rặn một hai lần. Nhớ rằng bánh rau nhỏ và mềm hơn nhiều so với em bé! Chúng tôi mong bánh rau sổ trong khoảng 30 phút. Kiểm soát chảy máu rất quan trọng, không chỉ cho sức khỏe của bạn mà còn để duy trì nguồn sữa nếu bạn định cho con bú. Chúng tôi thường dùng thuốc để tử cung co chặt khi sổ rau, giúp kiểm soát chảy máu.

Các phương pháp sinh

Sinh có hỗ trợ là gì?

Sinh thường đường âm đạo là kiểu sinh phổ biến nhất. Khi cần, các phương pháp sinh có hỗ trợ được dùng. Tuy chuyển dạ có thể đơn giản, đôi khi cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế — từ dùng thuốc đến các thủ thuật sinh cấp cứu, tùy tình huống phát sinh. Các thủ thuật sinh có hỗ trợ gồm:

Cắt tầng sinh môn (Episiotomy)

Cắt tầng sinh môn là vết rạch phẫu thuật ở tầng sinh môn (vùng da giữa âm đạo và hậu môn), giúp mở rộng cửa âm đạo để đầu bé qua dễ hơn và tránh rách da của mẹ. Hầu hết phụ nữ không cần; thủ thuật này dành cho trường hợp đặc biệt. Có hai loại vết rạch: đường giữa (thẳng về phía hậu môn) và đường chéo bên (mediolateral, chéo tránh xa hậu môn). Có thể gây tê tại chỗ cho người không dùng gây tê ngoài màng cứng khi chuyển dạ.

Bấm ối (Amniotomy)

Bấm ối là làm vỡ màng ối nhân tạo. Có thể làm trước hoặc trong chuyển dạ. Bấm ối thường được làm để: khởi phát hoặc tăng cường chuyển dạ; đặt máy theo dõi trong đánh giá cơn gò; đặt máy theo dõi trong đầu bé để đánh giá sức khỏe bé; kiểm tra phân su (chất màu xanh nâu là phân đầu tiên của bé). Nhân viên y tế dùng dụng cụ amniohook (giống móc đan) để làm vỡ túi ối. Sau thủ thuật, cần sinh trong vòng 24 giờ để tránh nhiễm trùng.

Khởi phát chuyển dạ (Induced labor)

Vì nhiều lý do, nhân viên y tế có thể cần khởi phát chuyển dạ thay vì chờ tự nhiên. Chuyển dạ thường được khởi phát trong thai kỳ có vấn đề y khoa hoặc biến chứng. Cleveland Clinic tuân theo hướng dẫn quốc gia của ACOG. Nếu bạn có lý do không phải y khoa muốn khởi phát chuyển dạ, chúng tôi khuyến khích trao đổi. Khởi phát chuyển dạ thường dành cho các chỉ định y khoa mà lợi ích vượt trội nguy cơ. Có thể khởi phát bằng cơ học (bóng làm chín cổ tử cung) hoặc thuốc như cytotec và oxytocin. Việc chọn phương pháp tùy độ "chín" của cổ tử cung. Bóng làm chín và cytotec giúp làm mềm và mỏng cổ tử cung; oxytocin truyền tĩnh mạch gây co tử cung — cơn gò cũng làm mềm, mỏng tử cung và giúp đưa bé xuống khung chậu.

Lý do y khoa thường gặp để khởi phát chuyển dạ: đái tháo đường; tăng huyết áp; vỡ ối; thai chậm phát triển; thai quá ngày.

Theo dõi tim thai (Fetal monitoring)

Đây là quá trình theo dõi nhịp tim bé trong tương quan với cơn gò. Có thể theo dõi ngoài hoặc trong.

- **Theo dõi ngoài:** Đặt hai đầu dò lên bụng, cố định bằng đai Velcro. Một đầu dò là siêu âm nhỏ ghi nhịp tim bé; đầu kia ghi thời điểm và thời lượng cơn gò. Có thể có máy dùng Bluetooth, không cần nối dây vào máy.

- **Theo dõi trong:** Đặt một điện cực nhỏ lên đầu bé để theo dõi nhịp tim — đây là cách chính xác nhất. Một cảm biến áp lực nhỏ đặt gần bé để đo cường độ cơn gò.

Sinh bằng forceps (kẹp)

Forceps giống hai chiếc thìa lớn, bác sĩ đưa vào âm đạo và quanh đầu bé để nhẹ nhàng đỡ bé ra. Bạn vẫn phải rặn bé ra; phần còn lại của bé được đỡ bình thường. Nhân viên y tế sẽ trao đổi mọi nguy cơ với bạn.

Hút chân không (Vacuum extraction)

Máy hút giống một chén hút nhỏ đặt lên đầu bé để hỗ trợ sinh. Tạo lực hút bằng bơm và dẫn bé xuống đường sinh. Bơm thường để lại vết bầm trên đầu bé, thường hết trong 48 giờ.

Mổ lấy thai (Cesarean section)

Mổ lấy thai (C-section) là phẫu thuật khi không thể sinh thường. Bé được lấy ra qua các vết rạch ở bụng và tử cung.

Khi nào tôi cần mổ lấy thai?

Mổ lấy thai có thể được lên kế hoạch trước nếu có lý do y khoa, hoặc không định trước và diễn ra trong lúc chuyển dạ khi có vấn đề. Bạn có thể cần mổ lấy thai chủ động nếu có:

- **Bất tương xứng đầu - chậu (CPD):** đầu hoặc thân bé quá lớn để qua an toàn khung chậu mẹ, hoặc khung chậu mẹ quá nhỏ.
- **Từng mổ lấy thai:** tuy có thể sinh thường sau mổ, không phải ai cũng phù hợp. Loại vết rạch tử cung ở lần mổ trước và số lần mổ ảnh hưởng đến nguy cơ vỡ tử cung khi sinh thường.
- **Đa thai:** song thai thường có thể sinh thường, nhưng từ hai bé trở lên có thể cần mổ.
- **Rau tiền đạo:** bánh rau bám quá thấp, che lối ra của bé qua cổ tử cung.
- **Ngôi ngang:** bé nằm ngang trong tử cung. Nếu không xoay được qua thao tác trên bụng, cần mổ.
- **Ngôi mông:** bé ở tư thế ra chân hoặc mông trước. Nếu không xoay được, cần mổ.

Mổ lấy thai không định trước có thể cần nếu trong chuyển dạ xuất hiện:

- **Chuyển dạ ngừng tiến triển:** cổ tử cung mở rồi ngừng trước khi mở trọn, hoặc bé ngừng đi xuống đường sinh.
- **Chèn ép dây rốn:** dây rốn quấn quanh cổ hoặc thân bé, hoặc bị kẹp giữa đầu bé và khung chậu mẹ.
- **Sa dây rốn:** hiếm gặp, dây rốn ra khỏi cổ tử cung trước bé.
- **Rau bong non:** hiếm gặp, bánh rau tách khỏi thành tử cung trước khi bé ra; bé có thể xuất hiện nhịp tim bất thường, bác sĩ có thể quyết định mổ.
- **Suy thai:** bé không dung nạp được chuyển dạ và không đáp ứng các biện pháp; bé có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Trước khi mổ lấy thai diễn ra những gì?

Nếu không phải mổ cấp cứu, các bước sau sẽ diễn ra: bạn được hỏi có đồng ý thủ thuật không (một số viện yêu cầu ký giấy đồng thuận); bác sĩ gây mê trao đổi loại vô cảm; gắn máy theo dõi tim, mạch, huyết áp; tia hồng ngoại quanh vùng rạch; đặt ống thông tiểu để bàng quang rỗng; truyền thuốc vào tĩnh mạch.

Quy trình mổ lấy thai thế nào?

Bắt đầu, thuốc vô cảm được dùng. Bụng được sát khuẩn. Đội gây mê bảo đảm bạn thoải mái. Bác sĩ rạch qua da và thành bụng — có thể là đường dọc hoặc ngang (đường ngang còn gọi là đường bikini, nằm dưới rốn). Tiếp đó rạch 3–4 inch (~8–10 cm) ở thành tử cung, lấy bé ra qua các vết rạch. Dây rốn được cắt, sơ rau và khâu lại các vết rạch. Toàn bộ mất 1–2 giờ.

Sau sinh mổ diễn ra những gì?

Vì mổ lấy thai là đại phẫu, bạn cần thời gian hồi phục lâu hơn sinh thường. Tùy tình trạng, bạn có thể ở viện 2–4 ngày. Khi thuốc tê hết, bạn sẽ bắt đầu đau ở vết mổ, nên nhớ xin thuốc giảm đau. Bạn cũng có thể đầy hơi và khó hít sâu. Bạn sẽ ra dịch âm đạo lẫn máu (sản dịch – lochia) do bong niêm mạc tử cung, giống như sau sinh thường. Dịch đầu đỏ rồi dần chuyển vàng — đây không phải kinh nguyệt. Hãy gọi nhân viên y tế nếu ra máu nhiều hoặc dịch có mùi hôi.

Mổ lấy thai có những nguy cơ gì?

Như mọi phẫu thuật, mổ lấy thai có một số nguy cơ: nhiễm trùng; mất máu hoặc cần truyền máu; cục máu đông có thể trôi vào dòng máu (thuyên tắc); tổn thương ruột hoặc bàng quang; vết rạch có thể làm yếu thành tử cung; bất thường bánh rau ở lần mang thai sau; khó có thai lại; nguy cơ tử gây mê toàn thân (nếu dùng); tổn thương thai.

Sau mổ lấy thai tôi có thể sinh thường lần sau không?

Phần lớn phụ nữ từng mổ lấy thai có thể sinh thường ở lần mang thai sau. Cơ hội sinh thường sau mổ (VBAC) tăng nhiều nếu bạn: được rạch ngang đoạn dưới tử cung ở lần mổ; khung chậu không quá nhỏ; không mang đa thai; lần mổ đầu là do ngôi mông.

Các lựa chọn giảm đau khi sinh

Chuyển dạ sẽ như thế nào?

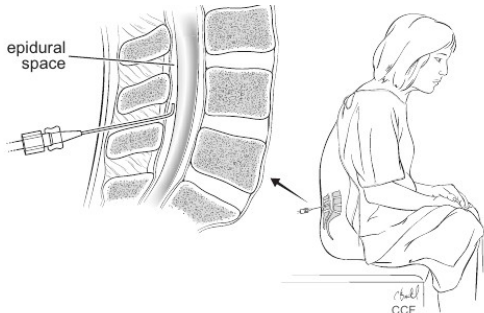
Chuyển dạ của mỗi người mỗi khác, và mỗi người cảm nhận khó chịu khác nhau. Đau khi chuyển dạ do cơ co cơ tử cung và áp lực lên cổ tử cung; cũng có thể do bé đè lên bàng quang, ruột và do đường sinh, âm đạo bị căng khi bé đi qua.

Cường độ đau không phải lúc nào cũng là lý do người ta tìm giảm đau; thường là do tính lặp đi lặp lại và thời gian đau kéo dài với mỗi cơn gò. Đôi khi nỗi sợ điều chưa biết cộng thêm sức mạnh của cơn gò có thể quá tải. Giảm đau có thể là điều cần thiết để lấy lại cảm giác kiểm soát.

Có những lựa chọn giảm đau nào khi sinh?

Hãy tìm hiểu các lựa chọn giảm đau và trao đổi với nhân viên y tế từ trước. Việc dùng giảm đau không có gì phải áy náy — chỉ bạn mới biết mình cảm thấy thế nào, nên quyết định kiểm soát đau phải do chính bạn. Nếu mục tiêu của bạn là sinh không vô cảm, hãy nói với nhân viên y tế; họ cũng có thể hỗ trợ lựa chọn này. Vào lúc nào đó trong chuyển dạ, bạn sẽ được trao đổi với đội gây mê về giảm đau. Họ có thể nói với bạn về:

- **Thuốc giảm đau (analgesic):** tiêm vào tĩnh mạch hoặc cơ để làm dịu khó chịu. Thuốc không loại bỏ hoàn toàn cơn đau nhưng làm giảm. Vì ảnh hưởng toàn thân và có thể làm cả mẹ và bé buồn ngủ, chúng chủ yếu dùng trong chuyển dạ sớm để giúp bạn nghỉ và giữ sức.
- **Gây mê toàn thân:** dùng cho cấp cứu trong sinh. Gây ngủ và phải do bác sĩ gây mê thực hiện. Tuy an toàn, gây mê toàn thân khiến bạn không thể nhìn con ngay sau sinh.
- **Gây tê tại chỗ:** nhân viên y tế có thể dùng để làm tê vùng đau khi sinh hoặc khi cần khâu sau sinh. Thuốc tê tại chỗ không làm giảm khó chịu trong lúc chuyển dạ.
- **Gây tê vùng (ngoài màng cứng, tủy sống):** là cách giảm đau phổ biến và hiệu quả nhất, giảm nhiều hoặc loại bỏ đau suốt quá trình sinh, và có thể dùng nếu cần mổ lấy thai. Do bác sĩ gây mê thực hiện trong chuyển dạ. Có 3 loại: tủy sống, ngoài màng cứng và kết hợp tủy sống/ngoài màng cứng. Với mỗi loại, thuốc được đặt gần các dây thần kinh ở lưng dưới để chặn đau ở một vùng rộng trong khi bạn vẫn tỉnh. Vì lý do an toàn, người nhà thường được yêu cầu ra khỏi phòng khi gây tê vùng.



Ba loại gây tê vùng:

1. **Ngoài màng cứng (Epidural):** đặt một ống nhựa mảnh ở lưng, có thể truyền thuốc khi cần. Ống lưu lại suốt chuyển dạ. Nếu cần mổ, có thể truyền liều mạnh hơn qua ống.
2. **Tủy sống (Spinal):** thường dùng trong mổ lấy thai chủ động. Thuốc tê được tiêm một lần bằng kim rất nhỏ. Cách này tác dụng nhanh, chỉ cần liều nhỏ.
3. **Kết hợp tủy sống – ngoài màng cứng (CSE):** kết hợp cả hai. Tủy sống làm tê nhanh, đồng thời có thể truyền thêm thuốc nếu cần.

Gây tê vùng được thực hiện thế nào?

Bác sĩ gây mê sẽ tiêm thuốc gần các dây thần kinh ở lưng dưới để chặn khó chịu do cơn gò, khi bạn ngồi hoặc nằm nghiêng. Sau khi xem tiền sử và hỏi vài câu, bác sĩ làm tê một vùng ở lưng dưới bằng thuốc tê tại chỗ, rồi đưa kim đặc biệt vào để tìm đúng vị trí tiêm. Sau khi tiêm, bác sĩ rút kim. Thường một ống nhựa nhỏ (catheter ngoài màng cứng) được lưu lại để truyền thuốc khi cần suốt chuyển dạ.

Gây tê vùng được thực hiện khi nào?

Thời điểm tốt nhất tùy đáp ứng của bạn và bé với chuyển dạ. Nếu bạn yêu cầu, nhân viên y tế sẽ liên hệ bác sĩ gây mê và cùng trao đổi nguy cơ, lợi ích và thời điểm. Bạn có thể được gây tê ngoài màng cứng, tủy sống, hoặc kết hợp — tùy sức khỏe chung và tiến triển chuyển dạ.

Gây tê vùng có ảnh hưởng đến em bé không?

Nhiều nghiên cứu cho thấy gây tê vùng an toàn cho bạn và em bé.

Gây tê vùng có tác dụng sau bao lâu và kéo dài bao lâu?

Gây tê ngoài màng cứng bắt đầu tác dụng trong 10–20 phút sau tiêm và giảm đau kéo dài suốt chuyển dạ, vì luôn có thể truyền thêm thuốc qua catheter. Gây tê tủy sống tác dụng ngay sau tiêm, giảm đau khoảng 2,5 giờ; nếu chuyển dạ dự kiến dài hơn, một catheter ngoài màng cứng sẽ được đặt để duy trì giảm đau.

Gây tê vùng làm tôi tê đến mức nào?

Tuy giảm đau đáng kể, bạn vẫn có thể cảm nhận áp lực từ cơn gò, khi nhân viên y tế khám cổ tử cung, và khi bé xuống rất thấp trong khung chậu.

Gây tê vùng có làm chậm chuyển dạ không?

Ở một số người, cơn gò có thể chậm lại sau gây tê vùng. Hầu hết thấy gây tê vùng giúp thư giãn, có thể cải thiện kiểu cơn gò và cho phép nghỉ. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên 62.000 người sinh ở Mỹ kết luận giai đoạn II (rặn) dài hơn khoảng 30 phút với gây tê ngoài màng cứng so với không.

Nếu gây tê vùng, tôi có rặn được không?

Có. Vì gây tê ngoài màng cứng cho cơ hội nghỉ, bạn có thể có nhiều năng lượng hơn để rặn. Tuy cảm giác một rặn hơi giảm, dùng gương thường giúp bạn thấy việc mình đang làm.

Bạn vẫn có thể cảm nhận áp lực bé xuống đường sinh, nhưng nhìn chung rặn dễ chịu hơn khi có gây tê ngoài màng cứng.

Gây tê vùng có tác dụng phụ không?

Bác sĩ gây mê áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt để tránh biến chứng. Tuy biến chứng hiếm, một số tác dụng phụ có thể gồm:

- **Tụt huyết áp:** bạn sẽ được truyền dịch tĩnh mạch, và huyết áp được theo dõi, xử trí cẩn thận. Đôi khi có thể ảnh hưởng đến bé; khi đó thường dùng thuốc nâng huyết áp.
- **Ngửa nhẹ khi chuyển dạ:** nếu ngửa khó chịu, bác sĩ gây mê có thể xử trí.
- **Đau đầu:** uống nước và dùng thuốc giảm đau có thể giúp. Nếu dai dẳng, báo bác sĩ gây mê để được kê thuốc khác. Đau đầu sau gây tê tùy sống là biến chứng hiếm.
- **Phản ứng thuốc tê tại chỗ:** hiếm nhưng có thể nghiêm trọng. Hãy báo ngay bác sĩ gây mê nếu bạn chóng mặt hoặc ù tai để được xử trí kịp thời.

Các lựa chọn thay thế gây tê vùng

Đội ngũ chăm sóc cũng sẵn sàng giúp bạn các cách khác để vượt qua cơn chuyển dạ:

- **Bồn nước chuyển dạ:** rất hữu ích giảm khó chịu. Cảm giác không trọng lượng hoặc áp lực nước ấm bao quanh giúp bạn dễ chịu đựng cơn gò hơn. Nếu bồn không phù hợp, cân nhắc chuyển dạ dưới vòi sen trên bóng sinh (birth ball).
- **Ép đối kháng (counter pressure):** nhân viên y tế, bạn đời hoặc điều dưỡng ép lên vùng lưng giúp các đợt sóng bớt khó chịu.
- **Liệu pháp mùi hương:** những mùi gắn với ký ức dễ chịu có thể giúp thư giãn; cũng có mùi giúp tập trung.
- **Vận động:** được khuyến khích. Chỉ việc cử động, nhip nhàng hay không, cũng giúp cải thiện cảm nhận đau.
- **Khí nitơ oxit (nitrous oxide):** khí hít giống ở phòng nha. Loại dùng khi chuyển dạ ít đậm đặc hơn, nhưng làm giảm tốt lo âu và sợ hãi. Gần 90% phụ nữ đánh giá cao!
- **Thuốc giảm đau nhóm opioid (narcotics):** hữu ích nhất trong chuyển dạ tích cực sớm. Vì có thể làm buồn ngủ và tê liệt tĩnh mạch/bắp, chúng cũng có thể làm bé hơi buồn ngủ. Tùy bạn gần giai đoạn rặn đến đâu, chúng tôi có thể ưu tiên các cách khác — vì muốn bé chào đời bằng tiếng khóc khỏe.
- **Nhạc yêu thích:** nhạc giúp bình tĩnh và thư giãn. Vì chuyển dạ phần lớn diễn ra trong tâm trí, đây có thể là điều bạn cần.
- **Câu khẳng định tích cực (affirmations):** dán quanh phòng cũng giúp bạn cảm thấy an tâm, mạnh mẽ. Viết ra thẻ nhỏ và xem giữa các cơn gò.

Thông tin thêm về giảm đau khi sinh — có 40 ngôn ngữ — tại Obstetric Anaesthetists' Association (https://www.labourpains.com/International_Translations).

5. Sau sinh

- › Những điều sẽ diễn ra sau sinh
- › Thay đổi cơ thể sau sinh
- › Rách âm đạo
- › Biện pháp tránh thai tác dụng kéo dài có hồi phục (LARC)
- › Trầm cảm sau sinh
- › Tập luyện sau sinh

Những điều sẽ diễn ra sau sinh

Ngay sau sinh, bạn có thể được ôm bé. Nếu có thể, bé sẽ được đặt da kề da với bạn ít nhất một giờ. Lúc này bé có thể tìm vú hoặc bắt đầu bú. Trong hầu hết trường hợp, bé sẽ được cân và khám ngay tại phòng sinh, trước mặt bạn.

Nếu bạn hoặc bé có nhu cầu y tế đặc biệt hoặc cần thủ thuật trong khi sinh, một ê-kíp chăm sóc nhi sẽ có mặt khi bé chào đời. Trong một số trường hợp, bé có thể cần vào phòng sơ sinh (nursery) để chăm sóc đặc biệt; thường bé ở đó một thời gian ngắn rồi trở về phòng bạn. Bạn và bạn đời được chào đón vào phòng sơ sinh để ôm và cho bé bú.

Sau khi bạn và bé đã hồi phục, bạn thường được chuyển từ phòng sinh sang phòng hậu sản. Suốt thời gian ở viện, nhịp tim, nhiệt độ và huyết áp của bạn sẽ được kiểm tra thường xuyên. Nhân viên y tế cũng kiểm tra kích thước tử cung và xoa bụng để giữ tử cung co chắc, giảm chảy máu. Bạn sẽ được khuyến khích đứng dậy đi lại càng sớm càng tốt.

Cho con bú

Bạn có thể bắt đầu cho bú ngay sau sinh. Động tác bú của bé giúp kích thích tiết sữa và kích thích tử cung co về kích thước bình thường nhanh hơn. Hãy chắc chắn bạn thoải mái khi cho bú trước khi về nhà. Nuôi con bằng sữa mẹ tuy tự nhiên nhưng cũng là kỹ năng cần luyện tập. Có hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ — hãy gặp chuyên viên tư vấn sữa mẹ hoặc điều dưỡng để được quan sát và hướng dẫn cho bú đúng cách.

Làm quen với em bé

Cách tốt nhất để học chăm sóc trẻ sơ sinh là dành nhiều thời gian với bé bằng cách ở cùng phòng (rooming-in) — bé ở cùng bạn và bạn đời từ lúc sinh đến khi về nhà. Ở cùng phòng giúp bạn học các "tín hiệu" của bé — cách bé phản ứng khi đói, mệt hoặc muốn được bế. Nhân viên y tế có thể yêu cầu bạn ghi lại thời điểm và lượng bú (thời gian bú mẹ hoặc số ounce sữa công thức). Quan trọng là ghi lại khi thay tã và đó là nước tiểu hay phân. Điều dưỡng sẽ đưa bạn mẫu ghi và giúp bạn nhận biết các tín hiệu của bé.

Khách thăm

Bạn có thể muốn hạn chế khách trong vài giờ đầu sau sinh, vì bạn và bạn đời sẽ mệt và muốn dành thời gian riêng với bé. Hãy hỏi bệnh viện về giờ thăm và quy định. Trước khi bế bé, khách nên rửa tay để bảo vệ bé khỏi vi trùng. Hãy đề nghị khách đang ốm, sốt, ho hoặc sổ mũi đợi đến khi khỏe rồi hãy thăm bé.

Tôi sẽ ở viện bao lâu?

Thời gian nằm viện tùy kiểu sinh và tình trạng của bạn và bé (thường vài ngày với sinh thường và lâu hơn với sinh mổ), theo quy định và thực tế của từng bệnh viện tại Việt Nam. Nhân viên y tế sẽ trao đổi về việc bạn và bé đã sẵn sàng về nhà chưa; hai bên cùng quyết định thời gian ở viện phù hợp nhất.

Trước khi về, nhân viên y tế sẽ khám cho bạn và hướng dẫn cách tự chăm sóc và chăm sóc bé. Nếu bạn đã xuất viện nhưng bé cần ở lại theo dõi, dùng thuốc hoặc làm thủ thuật, bạn có thể được ở lại viện nhưng ở phòng khác — hãy hỏi quy định của bệnh viện.

Chuẩn bị cho chuyến về nhà đầu tiên

Nếu đưa bé về bằng ô tô, hãy có ghế an toàn cho trẻ sơ sinh và lắp đúng cách. Đặt ghế ở hàng ghế sau, quay mặt về phía sau xe, và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để cố định chắc chắn. Nếu cần giúp, hãy hỏi nhân viên y tế. (Tại Việt Nam, từ 1/7/2026 có quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và dưới 1,35 m khi đi ô tô — xem mục "Chọn ghế ngồi ô tô cho bé" trong phần Chăm sóc bé.)

Khám lại sau sinh

Trong tuần đầu sau khi rời viện, hãy đặt lịch tái khám với nhân viên y tế vào tuần thứ 2 sau sinh và lần nữa vào 4-6 tuần sau sinh. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần tái khám sớm hơn.

Trước khi rời viện, hãy đặt lịch khám sức khỏe đầu tiên cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ nhi tại bệnh viện.

Thay đổi cơ thể sau sinh

Dưới đây là một số thay đổi thể chất bạn có thể gặp:

Sản dịch (lochia)

Sản dịch là dịch âm đạo sau sinh thường, có mùi hơi ngai ngái như dịch kinh nguyệt. Sản dịch màu đỏ sẫm trong 3 ngày đầu; vài cục máu nhỏ (không lớn hơn quả mận) là bình thường. Khoảng ngày 4 đến 10, sản dịch loãng hơn, màu hồng đến nâu. Khoảng ngày 7–10 đến ngày 14, sản dịch màu kem hoặc vàng. Bạn có thể thấy sản dịch tăng khi ngủ dậy, khi vận động hoặc khi cho con bú. Mẹ sinh mổ có thể có ít sản dịch hơn sau 24 giờ so với sinh thường. Chảy máu thường ngừng sau 4–6 tuần. Hãy dùng băng vệ sinh, không dùng tampon, vì không được đưa gì vào âm đạo trong 6 tuần.

Dịch từ vết mổ

Nếu bạn sinh mổ hoặc triệt sản (thắt vòi), việc ra một ít dịch hồng, loãng từ vết mổ là bình thường. Giữ vết mổ sạch, khô; rửa bằng xà phòng và nước ấm. Có thể tắm bình thường. Nếu dịch không ngừng hoặc chuyển đặc, vàng hoặc xanh, hãy gọi nhân viên y tế.

Sữa mẹ

Khi cho con bú, vú có thể rỉ sữa. Nếu không cho bú, rỉ sữa có thể xảy ra lúc đầu và ngừng trong 1–2 tuần. Miếng lót thấm sữa đặt trong áo ngực giúp giữ khô.

Cương tức vú

Cương tức vú là hiện tượng vú sưng, có cảm giác ấm, cứng và nặng, do tăng tuần hoàn đến vú. Có thể xảy ra khi sữa về hoặc khi bỏ một cữ bú. Nếu bạn cho bú bình, có thể giảm khó chịu bằng thuốc giảm đau theo chỉ định, chườm đá và mặc áo ngực nâng đỡ. Khi cho con bú, thường có thể phòng cương tức bằng cách cho bú thường xuyên hoặc hút sữa. Để giảm khó chịu, chườm ấm hoặc tắm ấm giúp sữa xuống (rời cho bú hoặc hút ngay sau đó). Nếu vẫn khó chịu, thử: chườm đá; vắt bớt sữa trước khi cho bú; dùng thuốc kháng viêm như ibuprofen theo chỉ định để giảm sưng; mặc áo ngực nâng đỡ. Nếu một vùng vú đỏ, hình nêm hướng về núm vú, có thể là nhiễm trùng — hãy gọi nhân viên y tế.

Cơ co tử cung

Trong vài giờ sau sinh, đáy tử cung (fundus) ở khoảng ngang rốn, giữ vậy khoảng một ngày rồi hạ dần mỗi ngày. Nếu cho con bú, việc này có thể nhanh hơn. Không biến chứng, tử cung trở về kích thước gần như trước mang thai (bằng quả lê) trong khoảng 6 tuần. Đau sau sinh (after-pains) do cơ co tử cung giúp cầm máu chỗ bánh rau bám; hay gặp hơn ở người sinh nhiều lần, có thể dữ dội (nhất là khi cho bú) trong khoảng 5 phút rồi dịu dần. Để giảm khó chịu: nằm sấp với gối kê dưới bụng dưới; đi bộ; dùng thuốc giảm đau theo chỉ định; ngâm sitz; chườm ấm lên bụng.

Tiểu tiện

Bạn có thể thấy khó chịu khi đi tiểu. Khó chịu là thường gặp, nhưng hãy báo nhân viên y tế nếu đau hoặc khó tiểu.

Khó chịu vùng tầng sinh môn

Nếu bạn được cắt tầng sinh môn, vùng da giữa âm đạo và hậu môn có thể rất đau và nhạy cảm. Chườm mát lên tầng sinh môn có thể giảm đau, sưng trong vài ngày đầu. Để giảm khó chịu, thử ngâm sitz ấm: ngồi trong bồn có ít nước ấm (không thêm sữa tắm tạo bọt hay sản phẩm khác để tránh nhiễm trùng). Có thể mua chậu nhỏ đặt trên bồn cầu; cách này cũng dùng cho khó chịu do trĩ.

Chăm sóc tầng sinh môn

Giữ tầng sinh môn sạch giúp dễ chịu và tránh nhiễm trùng. Sau mỗi lần đi vệ sinh và/hoặc thay băng, đổ nước ấm vào bình xịt vệ sinh (peri bottle được phát ở viện), xịt lên vùng giữa âm đạo và hậu môn theo chiều trước ra sau. Thấm khô bằng giấy vệ sinh, không chà xát. Thay băng sạch thường xuyên. Tiếp tục chăm sóc tầng sinh môn trong một tuần sau sinh.

Tiểu/đại tiện không tự chủ

Căng giãn cơ khi sinh có thể gây mất kiểm soát tiểu tiện và đôi khi đại tiện tạm thời. Tiểu không tự chủ hay gặp hơn khi bạn cười, ho hoặc gắng sức. Tập Kegel giúp cải thiện; tình trạng sẽ khá hơn sau vài tuần. Nếu vẫn còn sau lần khám hậu sản đầu, hãy trao đổi với nhân viên y tế.

Táo bón

Lần đi tiêu đầu sau sinh có thể muộn đến ngày thứ 3–4. Nhân viên y tế có thể kê hoặc khuyên dùng thuốc làm mềm phân không kê đơn. Tăng trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt; uống ít nhất 10–12 cốc nước mỗi ngày. Thuốc giảm đau opioid có thể làm nặng thêm táo bón, nên hạn chế nếu có thể. Kem không kê đơn và ngâm sitz giúp giảm khó chịu do trĩ. Nếu táo bón dai dẳng, hãy gọi nhân viên y tế.

Đổ mồ hôi

Tăng đổ mồ hôi, nhất là ban đêm, thường gặp sau sinh khi cơ thể điều chỉnh nồng độ nội tiết mới.

Kinh nguyệt

Nếu cho con bú, bạn có thể chưa có kinh cho đến khi bé cai sữa. Lưu ý: dù chưa có kinh khi cho bú, bạn vẫn có thể mang thai. Nếu nuôi bằng sữa công thức, thường có kinh lại sau 6–12 tuần; vài chu kỳ đầu có thể không đều.

Khi nào gọi nhân viên y tế sau sinh

Hãy gọi nhân viên y tế nếu bạn có: sốt trên 100,4°F (38°C) hoặc rét run dữ dội; sản dịch hôi; ra máu đỏ tươi kéo dài quá ngày thứ ba; ra cục máu lớn (hơn quả mận); đau, buồn hoặc khó tiểu; tăng lượng sản dịch/máu đến mức phải thay hơn một băng mỗi giờ; nhìn mờ; đau đầu dữ dội hoặc ngất; tăng đau, đỏ, chảy dịch hoặc hờ vết mổ (sinh mổ); đau, sưng hoặc đỏ dữ dội ở một chi hơn bên kia; vùng vú đỏ, ấm, đau; khó thở; bất kỳ dấu hiệu trầm cảm sau sinh nào như không uống pho được với sinh hoạt hằng ngày, có ý nghĩ hại bản thân hoặc em bé, lo âu/hoảng loạn/sợ hãi hầu hết thời gian trong ngày (xem phần "Trầm cảm sau sinh").

Rách âm đạo (rách tầng sinh môn) khi sinh

Rách âm đạo là gì?

Rách âm đạo có thể xảy ra khi sinh. Còn gọi là rách tầng sinh môn, đây là vết rách ở mô (da và cơ) quanh âm đạo và tầng sinh môn — vùng giữa cửa âm đạo và hậu môn. Trong cuộc sinh thường, da âm đạo mỏng đi để chuẩn bị; vùng này vốn được thiết kế để căng ra cho đầu và thân bé qua mà không tổn thương.

Rách âm đạo nghiêm trọng đến mức nào?

Có nhiều mức độ rách, xác định theo độ nặng:

- **Rách độ 1:** nhẹ nhất, chỉ tổn thương lớp mô đầu tiên quanh âm đạo và tầng sinh môn.
- **Rách độ 2:** mức thường gặp nhất khi sinh. Vết rách lớn hơn, sâu qua da vào mô cơ của âm đạo và tầng sinh môn.
- **Rách độ 3:** kéo dài từ âm đạo đến hậu môn, tổn thương da, mô cơ tầng sinh môn và cơ thắt hậu môn (kiểm soát đại tiện).
- **Rách độ 4:** ít gặp nhất, kéo dài từ âm đạo qua tầng sinh môn, cơ thắt hậu môn và vào trực tràng — nặng nhất.

Nguyên nhân gây rách âm đạo khi sinh?

Rách có thể do nhiều lý do, một vài yếu tố gồm: đây là lần sinh đầu; ngôi thai (bé quay mặt lên); dùng forceps hoặc hút chân không; bé to (hơn 8 pound ~3,6 kg); có cắt tầng sinh môn; người gốc Á.

Điều trị hoặc khâu rách âm đạo thế nào?

Điều trị tùy độ nặng. Rách độ 1 có thể không cần khâu. Rách độ 2, 3 và 4 sẽ được khâu; chỉ tự tiêu trong vòng 6 tuần. Trong các ca nặng nhất, nhân viên y tế có thể phải khâu phục hồi cơ thắt hậu môn (cũng bằng chỉ tự tiêu). Bạn có thể thấy khó chịu vài tuần trong khi vết rách lành. Vài mẹo giúp giảm khó chịu (áp dụng cho mọi loại rách):

- Dùng bình xịt vệ sinh (peri-bottle) để rửa sạch sau khi đi vệ sinh.
- Thấm khô nhẹ bằng giấy vệ sinh thay vì lau chà.
- Tránh táo bón bằng cách uống đủ nước và dùng thuốc làm mềm phân.

Nhân viên y tế cũng có thể cho bạn miếng làm mát dùng kèm băng vệ sinh sau sinh để giảm khó chịu. Hãy hỏi nhân viên y tế trước khi dùng bất kỳ thuốc giảm đau nào, vì thứ được và không được dùng có thể thay đổi khi cho con bú.

Rách âm đạo mất bao lâu để lành?

Hầu hết phụ nữ hết đau do rách trong khoảng hai tuần. Nếu cần khâu, chỉ tự tiêu trong 6 tuần; bạn không cần quay lại để cắt chỉ. Hãy để ý dấu hiệu nhiễm trùng khi vết rách lành, gồm: dịch hôi; sốt; đau không hết dù đã dùng thuốc. Một số phụ nữ đau khi quan hệ sau khi bị rách — nếu đau, hãy trao đổi với nhân viên y tế.

Cắt tầng sinh môn có ngăn được rách không?

Cắt tầng sinh môn là thủ thuật rạch từ mép cửa âm đạo ra ngoài để mở rộng cửa một cách có kiểm soát. Tuy làm rộng cửa âm đạo, nó không phải lúc nào cũng ngăn được rách, và còn tạo nguy cơ rách nặng hơn (độ 3 hoặc 4). Tuy nhiên có thể có lý do khác khiến cần cắt. Hãy trao đổi lợi và hại với nhân viên y tế.

Lần sau tôi có sinh thường được không nếu từng bị rách?

Trong hầu hết trường hợp, rách một lần không có nghĩa lần sau sẽ rách lại. Hầu hết vết rách nhỏ lành tốt và không cản trở sinh thường về sau. Nếu từng rách độ 3 hoặc 4, bạn có thể có nguy cơ rách khi sinh thường lần sau, nhưng nguy cơ thường đủ thấp để bạn vẫn có thể sinh thường nếu muốn. Trong một số trường hợp, nhân viên y tế có thể đề nghị mổ lấy thai để tránh rách.

Sources

Woolner A, Ayansina D, Bhattacharya S. The impact of third- or fourth-degree perineal tears on the second pregnancy: A cohort study of 182,445 Scottish women. *PLoS One*. 2019; 14(4): e0215180.

The American College of Obstetricians and Gynecologists. Assisted Vaginal Delivery. Accessed 1/29/2020. — American Pregnancy Association. Episiotomy. — Leeman L, Spearman M, Rogers R. Repair of Obstetric Perineal Lacerations. *American Family Physician*. Oct 2003; 68(8):1585-1590. — National Health Service. Episiotomy and perineal tears. — Smith L, Price N, Burns E. Incidence of and risk factors for perineal trauma. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 2013; 13:59.

Biện pháp tránh thai tác dụng kéo dài có hồi phục (LARC)

Hầu hết bảo hiểm chi trả cho que cấy và IUD.

Các biện pháp tránh thai tác dụng kéo dài có hồi phục gồm dụng cụ tử cung (IUD) và que cấy tránh thai (Nexplanon®). Chúng rất hiệu quả trong ngừa thai và có thể dùng nhiều năm tùy loại. Dễ dùng vì không cần làm gì sau khi đặt, và dễ tháo khi muốn. Có thể đặt ngay sau sinh hoặc ở lần khám lại. Rất hiệu quả, với dưới 1/100 phụ nữ dùng bị mang thai mỗi năm (dưới 1%) — tương đương triệt sản vĩnh viễn, và hiệu quả gấp 20 lần thuốc uống, miếng dán, mũi tiêm hay vòng.

IUD (Dụng cụ tử cung)

IUD là dụng cụ nhựa hình chữ T đặt vào tử cung, hoạt động bằng cách ngăn thụ tinh giữa tinh trùng và trứng. IUD nội tiết còn làm đặc dịch cổ tử cung khiến tinh trùng khó di chuyển và làm mỏng niêm mạc tử cung để ngăn làm tổ. Giai đoạn sau sinh có thể là thời điểm thuận tiện để đặt IUD vì bạn đã ở viện; bạn có thể không cảm nhận việc đặt nếu đã gây tê ngoài màng cứng hoặc tùy sống. Có hai loại:

- IUD nội tiết giải phóng nội tiết progestin vào tử cung, được phê duyệt dùng 3–5 năm tùy loại.
- IUD đồng không chứa nội tiết, được phê duyệt dùng 10 năm.

Tác dụng phụ của IUD có thể là đau quặn và ra máu, thường giảm trong năm đầu. IUD nội tiết có thể làm giảm ra máu hoặc mất kinh theo thời gian (an toàn). Một số tác dụng phụ ít gặp của IUD nội tiết: đau đầu, buồn nôn, trầm cảm và căng tức ngực — hầu hết tự khỏi theo thời gian.

Lợi ích của IUD: sau khi đặt không cần làm gì thêm; có thể đặt ngay sau sinh thường/mổ hoặc ở lần khám hậu sản; IUD nội tiết giảm đau và ra máu kinh; mọi IUD đều an toàn khi cho con bú; dễ tháo bất cứ lúc nào, không trì hoãn việc mang thai sau này.

Nguy cơ của IUD: thủng tử cung (IUD xuyên qua thành tử cung) — hiếm, 1/1.000 ca; tử cung đẩy IUD ra (5% trong năm đầu, tới 10–20% nếu đặt ngay sau sinh); viêm vùng chậu (PID) — hiếm, dưới 1/100; tăng nguy cơ thai ngoài tử cung nếu có thai (hiếm).

NEXPLANON (que cấy)

Nexplanon là một que dẻo cấy dưới da mặt trong cánh tay trên, giải phóng progestin để ngừa thai, hiệu quả tới 3 năm bằng cách ngăn rụng trứng. Tác dụng phụ có thể là ra máu thất thường (thường cải thiện theo thời gian); một số người có thay đổi tâm trạng, đau đầu và mụn.

Lợi ích của que cấy: sau khi đặt không cần làm gì trong tối đa 3 năm; dễ tháo khi muốn; an toàn khi cho con bú; có thể đặt sau sinh khi còn ở viện hoặc ở lần khám hậu sản.

Nguy cơ tiềm ẩn: khó tháo que (dưới 2% phụ nữ); nếu có thai khi que còn (hiếm) thì nguy cơ thai ngoài tử cung hơi cao hơn.

Trầm cảm sau sinh con hoặc mất thai

Trầm cảm sau sinh là gì?

Trầm cảm sau sinh là sự kết hợp phức tạp của các thay đổi thể chất, cảm xúc và hành vi xảy ra sau sinh, do những thay đổi về hóa học, xã hội và tâm lý liên quan đến việc có con.

Ai bị ảnh hưởng bởi trầm cảm sau sinh?

Trầm cảm sau sinh phổ biến. Tới 75% bà mẹ mới trải qua "baby blues" (buồn thoáng qua) sau sinh. Tới 15% trong số này sẽ tiến triển thành trầm cảm nặng và kéo dài hơn — gọi là trầm cảm sau sinh. Một trong 1.000 phụ nữ tiến triển thành tình trạng nghiêm trọng hơn là loạn thần sau sinh (postpartum psychosis).

Yếu tố nào tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh?

- Có tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị trầm cảm hoặc rối loạn khó chịu tiền kinh nguyệt (PMDD).
- Ít hỗ trợ xã hội.
- Mâu thuẫn vợ chồng.
- Cảm xúc lưỡng lự về việc mang thai.
- Tiền sử trầm cảm trong thai kỳ — 50% phụ nữ trầm cảm khi mang thai sẽ bị trầm cảm sau sinh.

Các dạng trầm cảm sau sinh

Baby blues (buồn thoáng qua): gặp ở 50–75% phụ nữ sau sinh. Bạn có thể khóc thường xuyên, kéo dài mà không rõ lý do, buồn và lo âu. Thường bắt đầu trong tuần đầu (1–4 ngày). Dù khó chịu, tình trạng thường tự hết trong hai tuần mà không cần điều trị — bạn chỉ cần được trấn an và giúp đỡ với em bé, việc nhà.

Trầm cảm sau sinh: nghiêm trọng hơn nhiều so với baby blues, ảnh hưởng khoảng 1/10 bà mẹ mới. Nếu từng bị, nguy cơ tăng lên 30%. Bạn có thể cảm xúc lên xuống thất thường, khóc nhiều, cáu gắt và mệt mỏi, kèm cảm giác tội lỗi, lo âu và không thể chăm sóc bé hoặc chính mình. Triệu chứng từ nhẹ đến nặng, có thể xuất hiện trong vài ngày sau sinh hoặc từ từ, thậm chí đến một năm sau. Điều trị bằng liệu pháp tâm lý hoặc thuốc chống trầm cảm rất hiệu quả.

Loạn thần sau sinh: dạng cực nặng, cần cấp cứu y tế. Tương đối hiếm (1/1.000 phụ nữ). Triệu chứng thường xuất hiện nhanh sau sinh và nặng, kéo dài vài tuần đến vài tháng: kích động dữ dội, lú lẫn, tuyệt vọng và xấu hổ, mất ngủ, hoang tưởng, ảo giác, tăng hoạt động, nói nhanh hoặc hưng cảm. Loạn thần sau sinh cần chăm sóc y tế ngay vì tăng nguy cơ tự tử và hại cho bé. Điều trị thường gồm nhập viện và dùng thuốc.

Nguyên nhân gây trầm cảm sau sinh?

Cần thêm nghiên cứu về mối liên hệ giữa sự sụt giảm nội tiết nhanh sau sinh và trầm cảm. Estrogen và progesterone tăng gấp mười lần khi mang thai nhưng giảm mạnh sau sinh; đến ngày thứ 3, chúng về mức trước mang thai. Cùng các thay

đổi hóa học này, những thay đổi xã hội và tâm lý khi có con làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng sau, hãy báo ngay nhân viên y tế: ý nghĩ hại bản thân hoặc em bé; ý nghĩ về cái chết hoặc tự tử lặp lại; khí sắc trầm buồn gần như cả ngày, gần như mỗi ngày trong 2 tuần qua; lo âu, tội lỗi, tuyệt vọng, sợ hãi, hoang loạn hoặc vô dụng; khó suy nghĩ, tập trung, ra quyết định hoặc ứng phó sinh hoạt hằng ngày; mất hứng thú hoặc niềm vui với hầu hết hoạt động gần như mỗi ngày trong 2 tuần qua.

Có thể phòng ngừa trầm cảm sau sinh không?

Vài mẹo giúp phòng ngừa hoặc ứng phó: thực tế về kỳ vọng với bản thân và em bé; hạn chế khách khi mới về nhà; nhờ giúp đỡ và nói rõ cách người khác có thể giúp; ngủ/ngủ khi bé ngủ; tập luyện, đi dạo, ra khỏi nhà nghỉ ngơi; lọc bớt cuộc gọi; ăn uống hợp lý, tránh rượu và caffeine; giữ liên lạc với gia đình, bạn bè, không tự cô lập; vun đắp mối quan hệ với bạn đời, dành thời gian cho nhau; chấp nhận có ngày vui ngày buồn.

Điều trị trầm cảm sau sinh

Điều trị tùy dạng và mức độ triệu chứng, gồm thuốc giải lo âu hoặc chống trầm cảm, tâm lý trị liệu và tham gia nhóm hỗ trợ. Với loạn thần sau sinh, thường thêm thuốc điều trị loạn thần và cần nhập viện. Nếu đang cho con bú, đừng cho rằng bạn không thể dùng thuốc trầm cảm, lo âu hay loạn thần — hãy trao đổi các lựa chọn với nhân viên y tế.

Tiên lượng thế nào?

Với sự giúp đỡ chuyên môn, gần như tất cả phụ nữ bị trầm cảm sau sinh đều có thể vượt qua triệu chứng.

Tập luyện sau sinh

Đi bộ cường độ nhẹ đến vừa phù hợp với hầu hết người đang hồi phục sau sinh. Nếu bạn sẵn sàng bắt đầu tập, hãy hỏi nhân viên y tế để chắc chắn an toàn, nhất là nếu bạn sinh mổ.

Nếu mục tiêu là giảm cân, tập đều đặn kết hợp ăn uống lành mạnh là cách tốt nhất để về cân nặng trước mang thai. Nhưng đừng quá sức — giảm 1-2 pound (~0,5-1 kg) mỗi tuần là mức lành mạnh. Việc mất tới 12 tháng để về cân cũ là bình thường. Mẹ cho con bú nên ăn ít nhất 1.800 calo mỗi ngày (nguồn: La Leche League, 2010; Lauwers & Swisher, 2015).

Vài câu hỏi để cân nhắc trước khi chọn cách tập: Tôi thích hoạt động nào? Thích tập nhóm hay cá nhân? Có hoạt động nào làm cùng bé được không? Chương trình nào hợp lịch của tôi? Tôi có bệnh lý nào giới hạn lựa chọn không? Mục tiêu là gì (giảm cân, tăng cơ, tăng độ dẻo)?

Bắt đầu thế nào?

Khi bắt đầu, hãy lên một lịch dễ theo và dễ duy trì. Khi đã quen, có thể thay đổi thời gian và loại hình tập.

- Chọn hoạt động bạn thích. Tập luyện nên vui, không phải gánh nặng. Bạn thậm chí có thể bao gồm cả bé: thử chạy hoặc đi bộ với xe đẩy, xem "cực cưng" như một quả tạ 12 pound. Tập luyện có thể kiêm luôn giờ chơi.
- Xếp lịch tập đều đặn vào sinh hoạt hằng ngày; thêm nhiều loại bài tập để khỏi chán.
- Bài tập bụng hiệu quả nhất sau 6 tuần.
- Kiên trì — nếu tập đều, nó sẽ sớm thành một phần lối sống.
- Nếu bạn thấy cần giám sát hoặc lời khuyên y tế để bắt đầu, hãy hỏi nhân viên y tế.
- Quy tắc chung sau sinh mổ: không nâng vật nặng hơn em bé (6-10 pound ~2,7-4,5 kg) trong 6-8 tuần đầu.

Ngừng tập và gọi bác sĩ nếu bạn có: đau dữ dội hoặc mạn tính; tăng ra máu âm đạo; ngất; buồn nôn; khó thở; mệt lả và yếu cơ.

6. Nuôi con bằng sữa mẹ

- › Lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ
- › Mẹ con ở cùng phòng 24 giờ
- › Da kề da cho mẹ và bé
- › Cho con bú những tuần đầu
- › Thuốc không kê đơn khi cho con bú
- › Tránh thai khi cho con bú

Lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ cho bé và cho mẹ

Sữa mẹ: khỏe hơn cho bé

Trẻ bú mẹ có: hệ miễn dịch mạnh hơn; ít tiêu chảy, táo bón, viêm dạ dày ruột, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và viêm ruột hoại tử ở trẻ non tháng (NEC); ít cảm lạnh và bệnh hô hấp như viêm phổi, vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) và ho gà; ít nhiễm trùng tai, nhất là loại gây hại thính giác; ít viêm màng não do vi khuẩn; thị lực tốt hơn và ít bệnh võng mạc ở trẻ non tháng; tỉ lệ tử vong sơ sinh thấp hơn; tỉ lệ SIDS thấp hơn; ít bệnh và ít nhập viện hơn nói chung; ít nguy cơ bệnh celiac.

Sữa mẹ cung cấp dồi dào các thành phần dinh dưỡng dễ hấp thu, chất chống oxy hóa, enzyme, đặc tính miễn dịch và kháng thể sống từ mẹ. Hệ miễn dịch trưởng thành của mẹ tạo kháng thể với các vi trùng mà mẹ và bé đã tiếp xúc; các kháng thể này vào sữa để bảo vệ bé. Immunoglobulin A tráng lên niêm mạc ruột non chưa trưởng thành của bé, ngăn vi trùng và dị nguyên rò qua. Sữa mẹ cũng chứa các chất tự nhiên xoa dịu trẻ.

Trẻ bú mẹ có thể trở thành trẻ khỏe hơn với: ít dị ứng, chàm và hen; ít ung thư trẻ em (bạch cầu, lymphoma); nguy cơ đái tháo đường type I và II thấp hơn; ít bệnh Crohn và viêm đại tràng; tỉ lệ bệnh hô hấp thấp hơn; ít vấn đề về nói và răng hàm; ít sâu răng; giảm nguy cơ béo phì trẻ em; trưởng thành não tốt hơn. Thiếu niên và người lớn cũng có lợi suốt đời: ít bị viêm khớp dạng thấp và lupus; ít bệnh tim khi trưởng thành; nguy cơ đa xơ cứng thấp hơn; tỉ lệ ung thư vú trước và sau mãn kinh thấp hơn.

Sữa mẹ: khỏe hơn cho mẹ về thể chất

Cho con bú: thúc đẩy giảm cân nhanh sau sinh, đốt thêm khoảng 500 calo mỗi ngày để tạo và duy trì nguồn sữa; kích thích tử cung co về kích thước bình thường; ít chảy máu sau sinh; ít nhiễm trùng tiết niệu; ít nguy cơ thiếu máu; ít trầm cảm sau sinh và tâm trạng tích cực hơn; tăng miễn dịch chống nhiễm trùng.

Khỏe hơn về cảm xúc

Cho con bú tạo ra các nội tiết tố xoa dịu tự nhiên là oxytocin và prolactin, giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác tích cực. Tăng sự tự tin và lòng tự trọng. Tăng sự bình tĩnh — trẻ bú mẹ khóc ít hơn và ít mắc bệnh trẻ em hơn. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp ích cho sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm hồn của cả gia đình. Cho con bú giúp việc đi lại dễ hơn — sữa mẹ luôn sạch và đúng nhiệt độ. Tăng gắn kết thể chất/cảm xúc giữa mẹ và con qua da kề da, bế và vuốt ve; nhiều người tìm sự gắn kết yêu thương trong những năm đầu đời giúp giảm vấn đề xã hội và hành vi. Mẹ cho con bú học cách đọc tín hiệu của bé, và bé học tin tưởng người chăm sóc.

Lợi ích suốt đời

Cho con bú có thể mang lại: nguy cơ ung thư vú, buồng trứng, tuyến giáp và nội mạc tử cung thấp hơn; nguy cơ viêm

khớp dạng thấp và lupus thấp hơn; ít lạc nội mạc tử cung; ít loãng xương khi có tuổi; ít đái tháo đường; ít tăng huyết áp (giảm huyết áp); ít bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cũng cho thấy mẹ và bé cho bú càng lâu, lợi ích càng nhiều.

Mẹ con ở cùng phòng 24 giờ: Nghỉ ngơi là để hồi phục

Sinh con là công việc hào hứng nhưng cực nhọc — đó là lý do tiếng Anh gọi nó là "labor" (lao động). Mẹ và bé thuộc về nhau. Ở cùng phòng 24 giờ là một phần trong chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm, giúp bạn học cách nghỉ ngơi và chăm sóc bé.

Nhiều phụ nữ muốn ngủ càng nhiều càng tốt sau sinh và có thể muốn gửi bé vào phòng sơ sinh để nghỉ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy bạn nghỉ được như nhau khi bé ở trong phòng. Có bé bên cạnh ngay từ đầu, theo nghiên cứu, là cách tốt nhất để mẹ và bé nghỉ ngơi và thiết lập nếp sinh hoạt. Đây là dịp tuyệt vời để làm quen và gắn kết với bé. Trẻ nhận ra giọng nói, mùi và nhịp tim của cha mẹ. Có bạn ở bên giúp bé thư giãn.

Lợi ích cho mẹ: chất lượng giấc ngủ tốt hơn; tự tin hơn khi bế và chăm bé; học được tín hiệu của bé (buồn ngủ, căng thẳng, cần yên tĩnh hoặc đói); nhận biết sớm tín hiệu đói (chép miệng, mở miệng, mút lưỡi/ngón tay/bàn tay); trải nghiệm cho con bú tốt hơn; bé ít khóc và ít quấy; ít baby blues và trầm cảm sau sinh; cả nhà nghỉ ngơi tốt hơn, thư giãn hơn vào cuối tuần đầu ở nhà; tăng cơ hội da kề da.

Lợi ích cho bé: ngủ chất lượng hơn, sớm có chu kỳ ngủ-thức đều đặn hơn; thân nhiệt ổn định hơn; nói chung dễ chịu hơn, ít khóc hơn; đường huyết ổn định hơn; bú sớm hơn, lâu hơn và dễ hơn; nồng độ hormone stress thấp hơn; được tiếp xúc vi khuẩn bình thường trên da mẹ, có thể bảo vệ bé khỏi vi trùng có hại.

Lời khuyên tốt nhất cho cha mẹ mới là học cách nghỉ khi bé ngủ, cả ngày lẫn đêm trong những ngày đầu. Giai đoạn sơ sinh sớm, bé ăn thường xuyên và tìm thấy sự an toàn khi ở gần bạn. Học cách cho bé bú dễ hơn khi bạn biết đọc tín hiệu đói sớm và trạng thái ngủ/thức của bé. Giữ bé bên bạn giúp bạn học cách cho bú và chăm bé, trong khi đội ngũ chuyên môn luôn ở gần hỗ trợ.

Cleveland Clinic cho phép thăm 24 giờ. Hãy nghĩ trước về mong muốn của bạn: thăm suốt ngày, hay giới hạn khách là người thân và giờ nhất định? Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn đặt ranh giới để nghỉ ngơi, hồi phục. Một số cha mẹ dán ghi chú ở cửa xin sự riêng tư; một số mẹ có "câu mật hiệu" báo bạn đời rằng họ mệt và muốn khách ra về.

Da kề da cho bạn và em bé

"Da kề da" nghĩa là gì?

Da kề da nghĩa là bé khỏe mạnh được đặt úp bụng, trực tiếp lên ngực bạn, ngay sau sinh. Người chăm sóc lau khô bé, đội mũ, phủ chăn ấm và đặt bé yên vị trên ngực bạn. Những giờ đầu ôm ấp da kề da giúp bạn và bé làm quen, đồng thời có lợi ích sức khỏe quan trọng, gồm điều hòa các dấu hiệu sinh tồn.



Nếu bé cần gặp bác sĩ nhi trước, hoặc bạn sinh mổ, bạn vẫn có thể mở khăn và ôm ấp bé ngay sau đó. Nếu cần, bạn đời có thể da kề da ban đầu. Trẻ sơ sinh khao khát tiếp xúc da kề da, nhưng đôi khi mẹ mới thấy quá tải — bắt đầu từ từ khi làm quen với bé cũng không sao.

Cho con bú

Hãy giữ bé da kề da nhiều nhất có thể. Ôm ấp cho bạn và bé khởi đầu tốt nhất để nuôi con bằng sữa mẹ. Nghiên cứu cho thấy trẻ được da kề da bú tốt hơn và tiếp tục bú lâu hơn trung bình 6 tuần. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị mọi trẻ bú mẹ nên da kề da ngay sau sinh. Giữ bé da kề da trong những tuần đầu giúp dễ biết khi nào cho bú, nhất là khi bé hơi buồn ngủ.

Chuyển tiếp êm ái

Ngực bạn là nơi tốt nhất để bé thích nghi với cuộc sống bên ngoài. So với trẻ được quấn khăn hoặc để trong cũi, trẻ da kề da ấm hơn, bình tĩnh hơn, khóc ít hơn và có đường huyết khỏe mạnh hơn.

Gắn kết

Ôm ấp da kề da có thể ảnh hưởng đến cách bạn gắn kết với bé. Các nhà nghiên cứu quan sát mẹ và bé trong vài ngày đầu và nhận thấy mẹ da kề da chạm và ôm bé nhiều hơn. Thậm chí một năm sau, mẹ da kề da vẫn ôm ấp bé nhiều hơn khi đi khám bác sĩ nhi.

Da kề da ngoài phòng sinh

Hãy tiếp tục ôm ấp da kề da sau khi rời viện. Bé sẽ ấm áp, dễ chịu trên ngực bạn, và lợi ích cho gắn kết, xoa dịu và bú mẹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Nếu bé buồn ngủ, da kề da giúp bé hứng thú bú hơn. Bạn đời cũng có thể ôm ấp. Cha mẹ ôm bé da kề da giúp bé bình tĩnh và ấm cúng; bé được xoa dịu khi làm thủ thuật. Da kề da có thể thúc đẩy phát triển não.

Cha và mẹ ôm bé da kề da được cho là tự tin hơn và thư giãn hơn.

Cho con bú: Những tuần đầu

Bắt đầu

Những tuần đầu cho con bú là thời gian học hỏi cho cả bạn và bé. Bạn học cách chăm và cho bé bú, còn bé khám phá cách bú và cách đòi được vú về. Hãy kiên nhẫn. Đội ngũ chăm sóc (điều dưỡng, tư vấn viên sữa mẹ, bác sĩ) sẽ giúp bạn và bé bú trước khi rời viện. Bạn có thể gọi hỗ trợ bất kỳ lúc nào trong ngày.

Trong những tuần đầu, sữa sẽ chuyển từ sữa non (dịch đặc, giàu dưỡng chất) sang sữa trưởng thành (loãng hơn, màu trắng đục), diễn ra từ từ. Sữa của bạn cung cấp mọi thức ăn và nước bé cần.

Khởi đầu tốt với việc cho con bú

- Cho bé bú ngay sau sinh.
- Giữ bé bên bạn để cho bú thường xuyên (ở cùng phòng 24 giờ).
- Cho con bú vừa để nuôi, vừa để vỗ về. Hãy cho bú khi bé có tín hiệu đói như chép miệng, liếm môi, quay về phía vú, mút nắm tay. Cho bú theo tín hiệu/nhu cầu bảo đảm nguồn sữa tốt vì bé bú chính là yếu tố tạo sữa.
- Trẻ sơ sinh bú thường xuyên, trung bình 8–12 lần mỗi ngày.
- Mỗi bé, mỗi mẹ mỗi khác. Nếu đau, hãy gọi hỗ trợ — thường do ngậm bắt vú nông thay vì sâu.
- Càng cho bú nhiều, càng tạo nhiều sữa. Kích thích núm vú thường xuyên gửi tín hiệu tạo thêm sữa.
- Khi bạn và bé đã quen, cho bú sẽ là lúc thư giãn và tận hưởng bên nhau.

Nên cho bé bú ở đâu?

Chọn nơi yên tĩnh, thoải mái. Nếu muốn, rót cho mình một cốc nước hoặc nước ép để uống khi cho bú. Chọn ghế có tựa tay và kê chân lên ghế để đưa bé gần bạn hơn; hoặc thử nằm nghiêng. Dùng gối trên đùi hoặc dưới tay để đỡ bé và tránh mỏi lưng. Nếu đau, hãy uống thuốc trước khi cho bú để dễ chịu hơn.

Bế bé thế nào?

Ôm bé sát bạn, bụng kề bụng. Toàn thân bé hướng về thân bạn. Cởi quần áo bé, chỉ để tã. Ôm bé sát nhất có thể — da kề da là tốt nhất. Giữ đầu bé cao hơn bụng bé. Dưới đây là hai tư thế cho bú khi tập; chọn tư thế thoải mái cho cả bạn và bé.



Tư thế ôm nôi chéo (Cross-Cradle): Nhiều mẹ thấy biến thể của tư thế ôm nôi, gọi là ôm nôi chéo, hữu ích trong những tuần đầu. Bé được đỡ trên một chiếc gối vắt qua đùi để nâng lên ngang tầm núm vú. Gối cũng đỡ cả hai khuỷu tay để tay bạn không phải chịu sức nặng của bé. Nếu chuẩn bị cho bú bên vú trái, tay trái đỡ vú theo kiểu chữ "U". Bạn đỡ bé bằng các ngón tay phải: nhẹ nhàng đặt bàn tay sau tai và gáy bé, ngón cái và ngón trỏ sau mỗi tai; gáy bé tựa vào phần lõm giữa ngón cái, ngón trỏ và lòng bàn tay. Lòng bàn tay đặt giữa hai bả vai bé. Khi chuẩn bị cho ngậm bắt vú, bảo đảm miệng bé rất gần núm vú ngay từ đầu; hướng núm vú về phía mũi bé. Khi bé há miệng rộng, dùng lòng bàn tay đẩy từ giữa hai bả vai. Miệng bé sẽ ngậm ít nhất nửa inch (~1,3 cm) từ chân núm vú.



Tư thế ôm ngang hông/bóng bầu dục (Clutch/Football): Tư thế tốt cho mẹ sinh mổ vì giữ bé xa vết mổ. Hầu hết trẻ sơ sinh rất thoải mái ở tư thế này. Nó cũng giúp khi mẹ có phản xạ xuống sữa mạnh, vì bé xử lý dòng sữa dễ hơn. Bạn đỡ đầu bé trong lòng bàn tay, lưng bé dọc theo cánh tay bên cạnh bạn. Bạn đỡ vú theo kiểu chữ "C". Bé hướng về bạn, miệng ngang tầm núm vú. Chân bé thu dưới cánh tay bạn, hông gập, chân dọc theo lưng tựa sao cho lòng bàn chân hướng lên trần (giúp bé không đạp vào ghế). Gối giúp nâng bé đến đúng độ cao.

Đặt bé vào vú thế nào?

Giữ vú bằng một tay: đặt ngón cái trên vú và bốn ngón dưới, tránh xa vùng quầng thâm quanh núm vú (quầng vú). Khi bé há miệng rộng (như ngáp), nhanh chóng đưa bé vào vú, môi dưới chạm trước, đầu bé hơi ngửa ra sau. Kiểm tra miệng bé: môi dưới bè ra ngoài, cằm chạm vú, miệng cách núm vú khoảng 1 inch (~2,5 cm) và ngậm vào quầng vú, không phải chỉ núm vú.

Việc này không nên đau. Nếu đau, hãy ngắt lực hút (nhẹ nhàng luồn ngón tay vào khoe miệng bé) rồi cho bé ngậm lại.

Làm sao biết bé đang nhận được sữa?

Thay đổi kiểu mút giúp bạn biết khi sữa xuống. Bé bắt đầu bằng những nhịp mút nhanh, ngắn. Ngay sau đó bạn sẽ thấy nhịp mút chậm, đều và nghe bé nuốt (âm "kuh" là tiếng nuốt).

Nên cho bú bao lâu một lần?

Cho bé bú theo nhu cầu mỗi 1–3 giờ cả ngày lẫn đêm. Hầu hết trẻ sơ sinh cần bú khoảng 8–12 lần mỗi ngày. Bé có thể muốn bú mỗi giờ trong vài cử liên tiếp (gọi là bú chùm – cluster feeding). Hãy để bé bú lâu ở vú thứ nhất đến khi có vẻ no; không cần giới hạn thời gian trừ khi núm vú đau. Vỗ ợ hơi rồi cho bú vú kia. Bé không bú cả hai vú mỗi cử cũng không sao — cứ sau bắt đầu bằng vú còn lại.

Làm sao biết bé bú đủ sữa?

Đến một tuần tuổi, bé nên có ít nhất 6–8 tã ướt và 3–4 lần phân vàng, nhiều hạt, lượng nhiều mỗi 24 giờ. Nước tiểu nên nhạt màu sau tuần đầu; nếu bé không đủ sữa, nước tiểu sẽ vàng sẫm và ít đi. Nếu khó nhận biết tã ướt, đặt một mảnh giấy vệ sinh lên tã — khi bé tiểu, giấy sẽ ướt (một số tã có vạch đổi màu khi có nước tiểu). Trẻ bú mẹ có phân vàng, nhiều hạt, lỏng, thường mỗi cử; về sau một số bé chỉ đi tiêu một lần mỗi tuần. Để xem bé lên cân đủ chưa, có thể cân tại nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hoặc gọi phòng khám.

Chăm sóc vú

Rửa tay trước khi cho bú. Tắm mỗi ngày một lần là đủ để giữ núm vú sạch. Không dùng xà phòng hay sản phẩm khác khi rửa núm vú — chỉ dùng nước ấm. Để núm vú khô sau cử bú.

Làm sao tránh đau núm vú?

Đau núm vú thường gặp những tuần đầu, hay do ngậm bắt vú hoặc tư thế chưa đúng. Để tránh:

- Bảo đảm miệng bé há rộng (như ngáp) trước khi ngậm vú.
- Đổi tư thế cho bú.
- Bảo đảm bé ngậm sâu để tránh đau.
- Xoa sữa non hoặc sữa mẹ lên núm vú và quầng vú sau mỗi cử, để khô tự nhiên.
- Nếu núm vú đau, khô hoặc nứt, bắt đầu cho bú bên ít đau trước.
- Dùng acetaminophen (như Tylenol®), thuốc kháng viêm (như ibuprofen) hoặc thuốc giảm đau khác theo chỉ định để giảm đau ngắn hạn.

Nếu núm vú vẫn đau, hãy gọi tư vấn viên sữa mẹ.

Khi nào có thể tập bú bình?

Dừng cho bú bình đến khi bạn và bé đã quen với bú mẹ (một số gia đình không bao giờ dùng bình). Sau 3–4 tuần đầu, khi đã quen, có thể tập bình; có thể sẽ dễ hơn nếu người khác cho bé bú bình đầu tiên. Bạn có thể hút sữa và dùng sữa này cho cử bình bình thường hoặc thường xuyên. Viện Hàn lâm

Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, tiếp tục kèm thức ăn bổ sung đến hết 2 năm đầu và hơn nữa.

Nếu bạn sẽ đi làm lại, hãy gọi tư vấn viên sữa mẹ hoặc bác sĩ y học sữa mẹ trước 2–4 tuần để bàn các lựa chọn. Thông tin thêm tại womenshealth.gov/breastfeeding.

Có cần bổ sung không?

Trẻ khỏe, đủ tháng không cần bổ sung trong những tuần đầu, trừ khi được nhân viên y tế khuyên. Thực tế, hãy tránh bổ sung vì chúng làm giảm nguồn sữa. Vắt cạn vú thường xuyên là quan trọng để tạo sữa. Tránh núm vú giả, ti giả và bình trong 4 tuần đầu vì có thể làm giảm nguồn sữa. Bé điều khiển nguồn sữa bằng cách bú thường xuyên. Khi bé lớn, có lúc bé bú nhiều hơn bình thường, và điều này sẽ tăng nguồn sữa.

Tự chăm sóc bản thân những tuần đầu thế nào?

Nghỉ đủ. Bất cứ khi nào bé ngủ, bạn cũng nên nghỉ. Để người thân, bạn bè giúp trông con lớn và việc nhà. Việc của bạn những tuần đầu là làm quen với bé. Dinh dưỡng tốt vẫn quan trọng — theo cùng hướng dẫn ăn lành mạnh như khi mang thai. Nhân viên y tế có thể khuyên tiếp tục uống vitamin bà bầu khi cho con bú. Nếu bạn khó chịu sau sinh, hãy dùng thuốc giảm đau theo chỉ định — đau có thể làm bú khó hơn vì cản trở việc xuống sữa; thuốc giảm đau do nhân viên y tế kê sẽ không hại bé.

Hãy hỏi nhân viên y tế hoặc tư vấn viên sữa mẹ về mức an toàn của bất kỳ thuốc nào bạn cần dùng khi cho con bú. Hầu hết thuốc kê đơn hoặc không kê đơn đều an toàn khi cho bú.

Những lo lắng thường gặp về việc cho con bú

Ngực tôi quá nhỏ để cho con bú? Kích thước ngực không ảnh hưởng đến khả năng cho bú. Lượng sữa chủ yếu phụ thuộc lượng bé bú, một số tình trạng bệnh và lượng mô tuyến. Nếu lo về nguy cơ ít sữa hoặc từng ít sữa, hãy trao đổi với bác sĩ sản, tư vấn viên hoặc chuyên gia y học sữa mẹ.

Cho con bú có đau không? Không nên đau nếu bé ngậm bắt vú tốt. Nhân viên y tế có thể giúp bạn học cách bế bé khi cho bú lần đầu. Ngực có thể hơi căng tức vài ngày đầu, nhưng cảm giác này sẽ hết khi bạn tiếp tục cho bú.

Cho con bú có khó không? Đây là kỹ năng cần luyện tập, nhưng lợi ích sức khỏe cho bạn và bé rất xứng đáng. Có nhiều cách học: lớp học ở bệnh viện, điều dưỡng và tư vấn viên sữa mẹ, và trò chuyện với các mẹ khác.

Tôi ngại, sợ cho con bú sẽ ngượng. Bạn có thể cho bú kín đáo, hoặc cho bú trước mặt người khác mà không lộ gì — mặc áo kéo từ dưới lên vừa đủ cho bé bú, hoặc phủ khăn qua vai/quanh bé.

Có phải uống sữa mới tạo được sữa mẹ? Không. Nguồn thực phẩm giàu calci khác gồm sữa chua, phô mai, đậu phụ, cá hồi, hạnh nhân, nước ép bổ sung calci, bánh ngô, rau lá xanh, súp lơ xanh, đậu khô. Ăn 4 khẩu phần thực phẩm giàu calci mỗi ngày.

Nếu tôi cần ra ngoài? Nếu mang bé theo được, bé có thể bú khi đói. Nếu phải xa bé, bạn có thể học vắt/hút sữa và trữ để người khác cho bé bú.

Cho con bú khi đi làm lại thế nào? Bạn có thể học vắt/hút sữa và trữ để người khác cho bé bú khi bạn ở nơi làm. Thông tin thêm tại womenshealth.gov.

Cho con bú có quá tốn thời gian? Cho bé ăn cách nào cũng tốn thời gian. Lựa chọn cho con bú là quyết định cá nhân — hãy trao đổi lo lắng với nhân viên y tế hoặc tư vấn viên.

Bố/bạn đời gắn kết với bé thế nào nếu tôi cho con bú?

Bố/bạn đời có thể da kề da — cách yêu thương để gắn kết và cho mẹ chút thời gian riêng. Cũng có thể bế bé đi dạo bằng đệm và giúp chăm sóc cơ bản.

Trước sinh làm sao biết mình có nguy cơ gặp khó khăn khi cho con bú?

Phụ nữ có các yếu tố nguy cơ sau nên hẹn tư vấn viên sữa mẹ hoặc chuyên gia y học sữa mẹ trước sinh để chuẩn bị tốt hơn. Tiền sử: khó khăn khi cho con trước bú; ít sữa hoặc mất sữa; thừa sữa; phẫu thuật vú; bệnh lý mẹ có thể cản trở việc cho bú (rối loạn tuyến giáp, ung thư vú, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì). Hiện tại: mang đa thai; thuốc mẹ đang dùng có thể ảnh hưởng nguồn sữa và mẹ/bé; dự kiến bé có chẩn đoán cản trở bú (khuyết tật vùng mặt, hội chứng Down, dị tật tim bẩm sinh); ngực cách xa nhau, ngực hình nón hoặc dấu hiệu thiếu mô tuyến.

Tại Việt Nam, nhiều bệnh viện sản-nhi có phòng tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và hỗ trợ cho bú ngay sau sinh (ví dụ Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở Hà Nội — 1900 1029; Bệnh viện Từ Dũ ở TP.HCM — (028) 1081). Hãy hỏi bệnh viện nơi bạn sinh, bác sĩ nhi hoặc nữ hộ sinh về dịch vụ tư vấn sữa mẹ và các nhóm hỗ trợ ở địa phương.

Thuốc không kê đơn và việc cho con bú

Dùng thuốc không kê đơn khi đang cho con bú có an toàn không? Câu trả lời thường là "có". Một số điều đã biết về thuốc và sữa mẹ:

- Gần như mọi thuốc mẹ dùng đều vào sữa mẹ, nhưng chỉ với lượng rất nhỏ — thường dưới 1% liều mẹ dùng.
- Vì chỉ một lượng rất nhỏ vào sữa, rất ít thuốc mà mẹ đang cho con bú không được dùng.
- Trong hầu hết trường hợp, mẹ cho con bú không cần ngừng bú để dùng thuốc kê đơn hoặc không kê đơn. Trong tình huống hiếm không nên dùng một thuốc, có thể thử thuốc khác, cách không dùng thuốc, hoặc một thủ thuật.

Hai quy tắc đơn giản giúp xác định thuốc có an toàn khi cho con bú:

- Nếu thuốc thường được kê cho trẻ nhũ nhi, thì có thể an toàn khi cho bú, vì bé nhận liều từ sữa mẹ thấp hơn nhiều so với dùng trực tiếp.
- Thuốc được coi là an toàn khi mang thai thì, trừ vài ngoại lệ, cũng an toàn khi cho con bú.

Có biện pháp an toàn bổ sung nào khi cho con bú?

- Dùng liều thấp nhất có thể, trong thời gian ngắn nhất có thể.
- Tránh công thức "extra-strength". Cũng tránh loại "phóng thích kéo dài" và thuốc chỉ uống 1-2 lần/ngày — đây là thuốc tác dụng dài, lưu trong máu và sữa mẹ lâu hơn thuốc cần uống nhiều lần.
- Khi có thể, dùng chế phẩm đơn chất thay vì công thức đa triệu chứng.
- Để ý dấu hiệu phản ứng thuốc ở bé như buồn ngủ, phát ban, tiêu chảy hoặc đau bụng co thắt. Dù hiếm, hãy gọi nhân viên y tế nếu thấy các thay đổi này.
- Luôn đọc nhãn và tờ hướng dẫn về cảnh báo khi dùng thuốc lúc cho con bú. Đừng ngại gọi bác sĩ, bác sĩ nhi của bé, tư vấn viên sữa mẹ hoặc dược sĩ nếu lo lắng.

Thuốc nào không an toàn khi cho con bú?

Một số thuốc cần cai sữa tạm thời là thuốc chứa hợp chất phóng xạ và thuốc điều trị ung thư. Hầu hết thuốc gây lo ngại là thuốc kê đơn, không phải thuốc không kê đơn. Thông tin thêm về thuốc không an toàn cho mẹ cho con bú tại LactMed của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (hơn 450 hồ sơ thuốc): <https://www.nlm.nih.gov/databases/download/lactmed.html>.

Nếu tôi hút thuốc, có thể vừa hút vừa cho con bú không?

Không hút thuốc là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn và bé. Tuy nhiên, nếu không thể bỏ, hãy cố giảm. Nếu hút dưới nửa bao mỗi ngày, nguy cơ cho bé nhỏ. Càng ít điếu, càng ít nguy cơ. Nicotine liều cao có thể gây ít sữa, phản xạ

xuống sữa kém và rối loạn tiêu hóa ở một số bé (buồn nôn/nôn, đau bụng co thắt, tiêu chảy). Nếu phải hút: đừng hút quanh bé, hút sau khi cho bú; rửa tay và mặt sau khi hút; che tóc và thay quần áo; không hút trong nhà.

Có thể uống rượu khi cho con bú không?

Uống thỉnh thoảng hoặc ít — như một ly rượu vang hoặc một cốc bia — chưa được thấy gây hại cho trẻ bú mẹ. Để an toàn, hãy chờ ít nhất 2 giờ cho mỗi ly rượu trước khi cho bú, hoặc dùng sữa đã vắt sau khi uống rượu. Cũng nên chọn đồ ít cồn hoặc pha loãng với nước/nước ép. Uống rượu ở mức trung bình đến nhiều được thấy cản trở phản xạ xuống sữa, giảm lượng bú, ảnh hưởng phát triển vận động của bé, chậm lên cân, ức chế tăng trưởng và gây buồn ngủ ở bé.

Có thể uống cà phê khi cho con bú không?

Uống tới hai cốc cà phê 5-ounce (~150 ml) mỗi ngày dường như không gây vấn đề cho mẹ và bé bú. Uống nhiều hơn có thể khiến bé cáu kỉnh, quấy và ngủ kém. Một số bé nhạy cảm với bất kỳ lượng caffeine nào. Hãy nhớ tính tổng caffeine từ mọi đồ uống, gồm cà phê, trà, cola và cả sô-cô-la; cân nhắc giảm bớt hoặc chuyển sang đồ không caffeine. Hãy hỏi ý kiến nhân viên y tế.

Những hiểu lầm thường gặp của cha mẹ về việc cho con bú

1. **"Cho con bú dễ hoặc tự nhiên."** Học cho con bú thường là kỹ năng cần luyện tập cho cả mẹ và bé, nhưng quá trình học có thể dễ hơn nếu có hỗ trợ.
2. **"Tôi không đủ sữa vì bé bú mỗi giờ."** Bé khóc vì nhiều lý do ngoài đói là rất thường gặp. Hãy tìm dấu hiệu đói và loại trừ lý do khác. Bú chụm và bú thường xuyên (mỗi giờ trong những tuần đầu) cũng bình thường. Hãy theo dõi với bác sĩ nhi để biết bé có lớn phù hợp không.
3. **"Sữa sẽ về đây ngay và bé cần lượng lớn ngay."** Sữa ban đầu về là sữa non — chất vàng đặc, đầy tế bào chống nhiễm trùng với lượng nhỏ, rồi tăng dần khi dạ dày bé lớn lên. Với sinh lý bình thường, sữa thường về vào ngày 3-5, nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi số lần sinh, sinh mổ, tiền sản giật...
4. **"Nếu không cho bú hoàn toàn được ngay thì nên bỏ luôn."** Chúng tôi khuyến khích mẹ tìm hỗ trợ từ bác sĩ nhi, tư vấn viên hoặc chuyên gia y học sữa mẹ. Chúng tôi thường giúp bạn vượt qua khó khăn ban đầu và đạt mục tiêu nuôi con bằng sữa mẹ.

Tránh thai khi cho con bú

Nghe nói không thể mang thai khi cho con bú — có đúng không?

Không hẳn. Khi cho con bú, khả năng mang thai thấp hơn. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn có thể mang thai.

Khi nào nên bắt đầu tránh thai?

Nên trao đổi về tránh thai với bác sĩ trước khi sinh. Phụ nữ cho con bú có nhiều lựa chọn.

Biện pháp tránh thai không nội tiết

- **Bao cao su và thuốc diệt tinh trùng:** có thể dùng, không ảnh hưởng việc cho bú. Âm đạo của mẹ cho con bú có thể khô hơn bình thường, khiến bao cao su gây kích ứng — nếu vậy, dùng thêm chất bôi trơn.
- **Biện pháp màng chắn:** như màng ngăn âm đạo và mũ cổ tử cung kèm thuốc diệt tinh trùng, không ảnh hưởng việc cho bú. Hãy nhờ bác sĩ đo lại kích cỡ vì bạn có thể cần cỡ lớn hơn sau sinh.
- **IUD không nội tiết:** loại chứa đồng (ParaGard®), không ảnh hưởng chất lượng và lượng sữa; an toàn, hiệu quả 10 năm.
- **Triệt sản (thắt vòi):** biện pháp phẫu thuật vĩnh viễn, chỉ ảnh hưởng việc cho bú nếu cần gây mê toàn thân (thuốc mê có thể qua sữa mẹ).

Biện pháp tránh thai nội tiết

- **Thuốc uống chỉ chứa progestin (Mini-Pill):** dùng hằng ngày rất hiệu quả cho phụ nữ cho con bú. Tỷ lệ thất bại hơi cao hơn thuốc kết hợp estrogen-progestin, nhưng khi cho bú phụ nữ ít khả năng sinh sản hơn. Một lượng nhỏ nội tiết vào sữa nhưng không có tác dụng xấu nào được biết đến với bé; một số nghiên cứu còn gợi ý tác dụng tốt lên lượng và chất lượng sữa. Khi ngừng cho bú hoặc có kinh lại, một số bác sĩ khuyên chuyển sang thuốc kết hợp (hiệu quả cao hơn một chút).
- **Thuốc uống kết hợp (The Pill):** chứa cả estrogen và progestin. AAP đã chấp thuận dùng thuốc kết hợp liều thấp cho phụ nữ cho con bú khi đã tạo sữa ổn định.
- **NuvaRing®:** chứa estrogen và progestin, nhưng hấp thu toàn thân thấp hơn thuốc uống.
- **IUD nội tiết:** loại chứa progesterone (Mirena®) giải phóng một lượng rất nhỏ nội tiết vào tử cung, tác dụng tại chỗ, không ảnh hưởng chất lượng và lượng sữa; an toàn, hiệu quả 5 năm.
- **Medroxyprogesterone:** mũi tiêm có thể dùng an toàn khi cho con bú và không ức chế tạo sữa.
- **Nexplanon:** que cấy giải phóng nội tiết đặt dưới da, hiệu quả 3 năm.

Hãy nhớ: Nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI), hãy dùng bao cao su để bảo vệ. STI có thể xảy ra với bất kỳ ai có hoạt động tình dục, kể cả khi cho con bú. Đừng tự ý ngừng biện pháp tránh thai — luôn gọi bác sĩ để trao đổi.

7. Chăm sóc bé

- › Giấc ngủ an toàn
- › Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện
- › Ngoại hình trẻ sơ sinh
- › Hành vi của trẻ sơ sinh
- › Khi nào cần gọi bác sĩ
- › Chăm sóc và theo dõi rốn
- › Cắt bao quy đầu
- › Tiêm chủng cho trẻ
- › Thêm bé vào hợp đồng bảo hiểm
- › Bạn đang tìm bác sĩ nhi?
- › Chọn ghế ngồi ô tô cho bé

Giấc ngủ an toàn

Giấc ngủ an toàn cho bé

- Luôn đặt bé nằm ngửa khi ngủ, cả giấc ngày và ban đêm, để giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ nhũ nhi (SIDS).
- Dùng bề mặt ngủ chắc, phủ ga vừa khít, để giảm nguy cơ SIDS và các nguyên nhân tử vong liên quan giấc ngủ.
- Bé không nên ngủ trên giường người lớn, ghế sofa hoặc ghế bành — một mình, với bạn hay với bất kỳ ai.
- Giữ vật mềm, đồ chơi và chăn ga lông lẻo ra khỏi khu vực ngủ của bé.
- Để giảm nguy cơ SIDS, phụ nữ nên: chăm sóc y tế đều đặn khi mang thai; không uống rượu hoặc dùng ma túy khi mang thai hoặc sau sinh.
- Để giảm nguy cơ SIDS, không hút thuốc khi mang thai và không hút hoặc để người khác hút quanh bé.
- Cho con bú để giảm nguy cơ SIDS.
- Cho bé ngậm ti giả (không gắn dây) khi ngủ trưa và ngủ tối, sau khi việc bú mẹ đã ổn định.
- Không để bé quá nóng khi ngủ.
- Theo hướng dẫn của nhân viên y tế về tiêm chủng và khám sức khỏe định kỳ của bé.
- Tránh các sản phẩm quảng cáo giảm nguy cơ SIDS và các nguyên nhân tử vong liên quan giấc ngủ.
- Không dùng máy theo dõi tim hoặc thở tại nhà để giảm nguy cơ SIDS.
- Cho bé nhiều thời gian nằm sấp (tummy time) khi bé thức và có người trông.

Nhớ giờ nằm sấp (Tummy Time)! Đặt bé nằm sấp khi bé thức và có người trông. Nằm sấp giúp cơ đầu, cổ và vai của bé khỏe hơn và giúp phòng bẹp đầu.



Môi trường ngủ an toàn trông như thế nào?

Để giảm nguy cơ SIDS và các nguyên nhân tử vong liên quan giấc ngủ:

- Dùng bề mặt ngủ chắc, như nệm trong cũi đạt chuẩn an toàn, phủ ga vừa khít.
- Không dùng gối, chăn, da cừu hoặc thanh đệm cũi ở bất kỳ đâu trong khu vực ngủ của bé.

- Giữ vật mềm, đồ chơi và chăn ga lông lẻo ra khỏi khu vực ngủ.
- Không hút thuốc hoặc để người khác hút quanh bé.
- Bảo đảm không có gì che đầu bé.
- Luôn đặt bé nằm ngửa khi ngủ, cả giấc ngày và ban đêm.
- Mặc cho bé đồ ngủ nhẹ, như bộ liền một mảnh, và không dùng chăn.

Nguyên tắc ABC: A (Alone) – bé ngủ MỘT MÌNH trong cũi, không ngủ chung giường hay có ai khác trong cũi. B (Back) – luôn đặt bé nằm NGỬA khi ngủ, cả ban đêm lẫn giấc ngày. C (Crib) – trong CƯÍ, trên nệm chắc chỉ có ga vừa khít, không chăn, không thú bông. (Đây là khuyến cáo về giấc ngủ an toàn phổ quát; bản gốc dẫn nguồn chương trình Giấc ngủ an toàn của Sở Y tế bang Ohio, Hoa Kỳ.)

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Sau khi bé chào đời, bác sĩ hoặc điều dưỡng sẽ làm một loạt kiểm tra để đánh giá tình trạng thể chất của bé. Một đánh giá thường quy gọi là chỉ số Apgar được dùng để xác định bé có cần chăm sóc y tế khẩn cấp không. Sau sinh, bé cũng được tiêm vitamin K, nhỏ mắt, đo thính lực và làm các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Bé cũng có thể được tiêm vắc-xin viêm gan B nếu bạn đồng ý.

Chỉ số Apgar là gì?

Khi đánh giá Apgar, nhịp tim, hô hấp, phản xạ, trương lực cơ và màu da của bé được đo. Năm dấu hiệu này được đánh giá vào phút thứ 1 và phút thứ 5 sau sinh. Mỗi mục được cho điểm 0-2, cộng lại thành chỉ số Apgar.

Chỉ số Apgar nghĩa là gì?

Nếu bé đạt Apgar từ 7 trở lên, bé có lẽ ở tình trạng thể chất tốt. Bé hiếm khi đạt 10 điểm tuyệt đối vì màu da có thể hơi xanh cho đến khi ấm lên. Apgar thấp có thể chỉ vấn đề tim hoặc phổi, hoặc do cuộc chuyển dạ khó. Bé có thể ở tình trạng tốt nhưng điểm thấp ngay sau sinh. Trẻ non tháng có thể điểm thấp do phát triển chưa hoàn thiện. Nhớ rằng chỉ số Apgar không dự đoán sức khỏe tương lai của bé.

Vì sao bé cần tiêm vitamin K?

Bé thường có nồng độ vitamin K thấp khi sinh. Vitamin K cần cho đông máu, nên bé thường được tiêm vitamin K ngay sau sinh để phòng một vấn đề chảy máu hiếm nhưng nghiêm trọng gọi là bệnh xuất huyết ở trẻ sơ sinh.

Vì sao bé cần nhỏ mắt?

Bé sẽ được tra thuốc mỡ hoặc nhỏ thuốc kháng sinh vào mắt để phòng nhiễm khuẩn có thể mắc phải khi sinh.

Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh là gì?

Mọi trẻ sơ sinh đều được sàng lọc một số tình trạng. Nhờ phát hiện sớm, các tình trạng này có thể được phòng hoặc điều trị. Gót chân bé sẽ được chích và lấy mẫu máu để xét nghiệm nhiều tình trạng khác nhau. Tại Việt Nam, sàng lọc sơ sinh (lấy mẫu gót chân) được thực hiện tại các bệnh viện sản/nhi, giúp phát hiện sớm một số bệnh bẩm sinh như thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sản thượng thận bẩm sinh... Hãy hỏi bệnh viện nơi bạn sinh về dịch vụ này.

Vì sao trẻ sơ sinh cần đo thính lực?

Sàng lọc thính lực cho mọi trẻ sơ sinh là tiêu chuẩn chăm sóc trên toàn Hoa Kỳ. Điều trị sớm mất thính lực có thể phòng vấn đề nói và ngôn ngữ về sau. Một tai nghe hoặc micro nhỏ được đặt vào tai bé để xem não bé phản ứng với âm thanh thế nào. Bé cần ngủ để xét nghiệm chính xác. Nếu bé không qua, không có nghĩa bé mất thính lực — xét nghiệm sẽ được lặp lại.

Sàng lọc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng (CCHD) là gì?

Bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng là nhóm vấn đề tim hoặc mạch máu có từ khi sinh. Khoảng 11/10.000 trẻ sinh ra mắc CCHD. CCHD có thể đe dọa tính mạng và cần can thiệp ở giai đoạn nhũ nhi. Nó không phải lúc nào cũng được phát hiện trước sinh hoặc khi khám ở phòng sơ sinh. Để cải thiện phát hiện sớm, khuyến nghị thêm sàng lọc này vào sàng lọc sơ sinh trước khi xuất viện. Một máy đo độ bão hòa oxy (pulse oximeter) thiết kế cho trẻ sơ sinh được dùng: một cảm biến quấn quanh tay và một cảm biến đặt ở một bàn chân. Cách này có thể phát hiện một số trẻ CCHD trước khi có triệu chứng.

Vì sao trẻ sơ sinh cần vắc-xin viêm gan B?

Vắc-xin viêm gan B bảo vệ khỏi vi-rút viêm gan B gây tổn thương gan. Vắc-xin là chuỗi 3 mũi; bé thường tiêm mũi đầu sau sinh, hai mũi tiếp theo trước 18 tháng tuổi.

Vì sao đặt bé nằm ngửa khi ngủ lại quan trọng?

Phòng ngừa SIDS bắt đầu ngay ở phòng sơ sinh. Đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ đã giảm tỉ lệ SIDS gần 50% trong 12 năm qua.

Ngoại hình trẻ sơ sinh

Hãy trao đổi với nhân viên y tế về những điều bạn nên chờ đợi ở ngoại hình của bé. Danh sách này có thể giúp bạn yên tâm, nhất là sau khi sinh con đầu lòng. Bạn có thể chờ đợi:

- Cuống rốn còn lại trong 10–14 ngày đầu, nhưng có thể chưa rụng đến tuần thứ ba.
- Da bé khô và bong tróc.
- Lông tơ trên cơ thể bé, có thể phủ vai, lưng, thái dương hoặc tai — lông này bảo vệ bé trong tử cung và thường rụng trong tuần đầu.
- Ngực bé sưng trong 2–4 tuần (cả bé trai và gái), do estrogen từ bánh rau của mẹ.
- Đầu bé sưng, ở đỉnh hoặc thành các cục nhỏ ở nhiều chỗ trên hộp sọ, do dịch bị ép vào da đầu khi sinh hoặc do bé cọ vào xương chậu mẹ. Sưng ở đỉnh đầu thường xẹp trong vài ngày; sưng do cọ sát xẹp trong 2–3 tháng. Gọi bác sĩ nếu sưng tăng hoặc kéo dài hơn bình thường.
- Bộ phận sinh dục sưng ở cả bé trai và gái. Bé trai có thể sưng bìu (kéo dài 6–12 tháng); màng trinh ở bé gái có thể sưng, biến mất trong 2–4 tuần.
- Tinh hoàn ẩn — một tỉ lệ nhỏ bé trai có tinh hoàn ẩn, nhiều khả năng cần phẫu thuật sau này để điều chỉnh.
- Dương vật bóng và đỏ — nếu bé trai được cắt bao quy đầu, quy đầu sẽ bóng, đỏ và có thể rỉ ít dịch vàng; thường lành trong 7–10 ngày.
- Dịch âm đạo — bé gái có thể ra dịch trong, trắng hoặc hồng kéo dài 3–10 ngày; bình thường, do estrogen truyền từ mẹ.
- Mắt — đôi khi một mạch máu ở lòng trắng vỡ khi sinh; không hiếm và lành trong 2–3 tuần. Ống lệ của bé có thể bị tắc gây chảy nước mắt liên tục, thường tự hết trong năm đầu; hãy hỏi bác sĩ hoặc gọi ngay nếu mắt có vẻ nhiễm trùng, có mủ hoặc dịch vàng.
- Chân cong hoặc bàn chân vẹo lên do bị bó chặt trong tử cung; chân bé sẽ thẳng ra trong 6–12 tháng.

Hành vi của trẻ sơ sinh

Nhiều cha mẹ mới có thể chưa biết đâu là hành vi bình thường của trẻ sơ sinh. Trẻ phát triển với tốc độ khác nhau nhưng vẫn có nhiều hành vi giống nhau. Đừng lo nếu bé có vẻ hơi chậm. Biết những hành vi nào cần chờ đợi giúp bạn nhận ra khi có vấn đề.

Nếu bé sinh non, đừng so sánh với trẻ đủ tháng — trẻ non thường phát triển chậm hơn. Nếu bé sinh sớm 2 tháng, bé có thể chậm hơn trẻ đủ tháng 2 tháng. Bác sĩ sẽ theo dõi tiến trình phát triển của bé non. Hãy liên hệ bác sĩ nếu bạn nghĩ bé phát triển chậm bất thường.

Ngủ

Trẻ sơ sinh thường ngủ 20 phút đến 4 giờ mỗi lần, tới 20 giờ mỗi ngày. Dạ dày bé quá nhỏ nên không no lâu, cần bú mỗi vài giờ. Mỗi bé có thói quen ngủ khác nhau, nhưng ở 3 tháng hầu hết bé ngủ 6–8 giờ mỗi đêm.

Khóc

Trẻ sơ sinh có thể khóc vài giờ mỗi ngày — đó là cách bé báo bé cần gì hoặc có gì đó không ổn. Trẻ khóc khi: đói; mệt; quá lạnh hoặc quá nóng; cần thay tã; cần được vỗ về; đầy hơi; bị kích thích quá mức; ốm. Trẻ sơ sinh cũng thường nấc, hắt hơi, ngáp, trớ, ợ và ọc ọc. Đôi khi bé khóc không vì lý do gì; hãy thử ru, hát, nói nhẹ hoặc quấn bé. Sớm thôi bạn sẽ đoán được bé cần gì qua tiếng khóc.

Bạn không phải lúc nào cũng dỗ được bé, và đó không phải lỗi của bạn. Hãy cố kiên nhẫn và giữ bình tĩnh. Nếu cần, nhờ người khác trông bé để bạn nghỉ. TUYỆT ĐỐI không bao giờ lắc bé trong bất kỳ tình huống nào — lắc bé có thể gây tổn thương não nghiêm trọng (hội chứng rung lắc trẻ), dẫn đến khuyết tật suốt đời. Hãy liên hệ bác sĩ nếu bé khóc nhiều hơn bình thường, khóc vào giờ khác thường, hoặc tiếng khóc nghe khác lạ — đây có thể là dấu hiệu bé ốm.

Phản xạ

Trong những tuần đầu, trẻ sơ sinh giữ tư thế như trong tử cung (tư thế thai): nắm tay, gập khuỷu, hông, gối; tay chân gần phía trước cơ thể. Điều này thay đổi khi bé kiểm soát cử động tốt hơn. Trẻ sơ sinh có nhiều phản xạ tự nhiên:

- **Phản xạ tìm vú (rooting):** bé quay về phía thức ăn và sẵn sàng bú; vuốt má bé sẽ gây phản xạ này.
- **Phản xạ mút (sucking):** đặt vật vào miệng bé, bé tự nhiên bắt đầu mút.
- **Phản xạ giật mình (startle/Moro):** bé bung tay chân rồi co lại khi giật mình, thường kèm khóc.
- **Phản xạ cổ trương lực (tonic neck):** bé quay đầu sang một bên và duỗi tay cùng bên.
- **Phản xạ nắm (grasp):** ngón tay bé nắm chặt vật đặt vào lòng bàn tay.
- **Phản xạ bước (stepping):** bàn chân bé làm động tác bước khi được giữ đứng, chân chạm bề mặt cứng.

- **Lưu ý:** tay, chân và cằm bé có thể run, nhất là khi khóc, vì hệ thần kinh chưa phát triển đầy đủ.

Thở

Trẻ sơ sinh thở không đều là không hiếm — bé ngừng thở 5–10 giây rồi tự thở lại ngay. Đây là bình thường. Tuy nhiên, hãy gọi bác sĩ hoặc đưa bé đến cấp cứu nếu bé ngừng thở hơn 10 giây hoặc bắt đầu tím tái.

Thị giác

Trẻ sơ sinh nhìn được, nhưng mắt có thể lác vì khó tập trung lúc đầu. Bé thấy chuyển động và độ tương phản đen–trắng. Vài tháng đầu, bé nhìn nghiêng dễ hơn. Đến 2–3 tháng, bé kiểm soát cơ mắt tốt hơn, tập trung vào một vật và nhìn theo vật bằng mắt.

Thính giác

Trẻ sơ sinh phân biệt được các âm thanh khác nhau. Bé nhận ra giọng quen thuộc, nên hãy nói chuyện với bé thường xuyên. Bạn có thể sớm thấy bé quay về phía giọng bạn. Với trẻ, tiếng nói giống âm nhạc với các cao độ và nhịp điệu khác nhau.

Em bé của bạn: Khi nào cần gọi bác sĩ

Trong năm đầu đời, bạn sẽ đưa bé đến phòng khám nhi nhiều lần. Hầu hết là khám thường quy, nhưng có lúc bé cần chăm sóc y tế ngay. Các vấn đề nhỏ như ho nhẹ, thỉnh thoảng tiêu chảy, quấy khóc thường có thể chờ đến giờ hành chính. Tuy nhiên, nếu bé có biểu hiện bất thường, đừng ngần ngại gọi bác sĩ ngay. Hãy tin vào trực giác của bạn — thường nó đúng.

Rất quan trọng là được bác sĩ tư vấn, vì một điều đơn giản như tiêu chảy có thể chuyển thành tình trạng nguy hiểm. Trước khi bé sinh, hãy tìm hiểu giờ khám, giờ trực và cách xử lý cấp cứu ngoài giờ của bác sĩ.

Trước khi gọi, chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi hướng dẫn. Khi gọi, hãy có sẵn: hồ sơ tiêm chủng của bé; tên và liều các thuốc bé đang dùng (kê đơn và không kê đơn); các bệnh bé có thể có; nhiệt độ của bé.

Gọi cấp cứu 115 (hoặc đưa bé đến khoa cấp cứu gần nhất) ngay nếu bé:

- Khó thở.
- Mềm nhũn hoặc không cử động được.
- Không chịu tỉnh.
- Có máu trong chất nôn hoặc phân.
- Co giật.
- Bị ngộ độc bất kỳ loại nào.
- Chảy máu mà bạn không cầm được.
- Bị ngộ độc (nuốt phải hóa chất, thuốc...) — gọi 115 và có thể gọi Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội): 024.3869.3731 (máy lẻ 6821).

Các số khẩn cấp hữu ích ở Việt Nam: 115 – cấp cứu y tế; 114 – cứu hỏa/cứu nạn; 113 – công an; 111 – Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (tư vấn, hỗ trợ 24/7, miễn phí).

Khi nào nên gọi bác sĩ?

Hãy gọi phòng khám sớm nếu bé:

- Nhiệt độ trực tràng từ 100,4°F (38°C) trở lên.
- Da hoặc mắt vàng.
- Ngủ nhiều hơn bình thường.
- Bỏ bú nhiều cữ liên tiếp.
- Nôn hoặc tiêu chảy nhiều hơn bình thường.
- Có dấu hiệu mất nước (giảm số tã ướt — nên có 6–8 tã/ngày; không có nước mắt khi khóc; hoặc thóp trên đầu lõm xuống).
- Cảm lạnh không đỡ sau vài ngày hoặc nặng hơn.
- Chảy dịch tại.
- Khóc không dứt.

Hãy nhớ bạn hiểu bé nhất. Nếu bạn cực kỳ lo lắng, luôn gọi bác sĩ hoặc cấp cứu 115 và/hoặc đưa bé đến khoa cấp cứu.

Chăm sóc và theo dõi rốn

Dây rốn là gì?

Dây rốn là "đường sống" của bé với mẹ trong thai kỳ, chuyển dưỡng chất đến bé và mang chất thải đi. Nó gồm hai động mạch và một tĩnh mạch.

Dây rốn trông thế nào?

Dây rốn là cấu trúc dẻo, dạng ống, trông xoắn, bao quanh bởi một chất giống thạch. Sau sinh, dây được kẹp rồi cắt, để lại một móm. Khoảng một tuần, móm teo lại và rụng, đổi màu từ vàng lục sang nâu rồi đen trước khi rụng.

Chăm sóc rốn cho bé thế nào?

Giữ rốn sạch để phòng nhiễm trùng là quan trọng. Tắm cho rốn dính nước không làm tăng nhiễm trùng hay khiến móm rụng lâu hơn. Hãy để rốn khô tự nhiên, không cần bôi chất như cồn.

Một số mẹo thêm

Khi mặc tã, gấp mép tã xuống để rốn được khô (một số tã sơ sinh có phần khoét sẵn cho rốn). Để móm rốn tự rụng — không bao giờ cố kéo, dù nó có vẻ lủng lẳng, vì có thể gây chảy máu và hại bé. Theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng như đỏ và viêm; đôi khi có dịch màu hoặc chảy máu. Hãy gọi bác sĩ ngay nếu nghi nhiễm trùng.

Cắt bao quy đầu

Cắt bao quy đầu là gì?

Cắt bao quy đầu là phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu — lớp mô che quy đầu dương vật. Đây là tập tục cổ xưa có nguồn gốc từ nghi lễ tôn giáo. Ngày nay, nhiều cha mẹ cho con trai cắt bao quy đầu vì lý do tôn giáo hoặc lý do khác.

Cắt bao quy đầu được làm thế nào?

Khi cắt, bao quy đầu được tách khỏi quy đầu và phần thừa được cắt bỏ. Ở trẻ sơ sinh, thủ thuật mất khoảng 5–10 phút; ở người lớn mất khoảng một giờ. Thường lành trong 5–7 ngày.

Cắt bao quy đầu được làm khi nào?

Nếu chọn làm tại bệnh viện, thường thực hiện vào ngày thứ nhất hoặc thứ hai sau sinh.

Cắt bao quy đầu có cần thiết không?

Việc cắt bao quy đầu vì lý do y tế/sức khỏe vẫn còn tranh luận. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cho rằng cắt bao quy đầu có lợi ích và cả nguy cơ; thủ thuật không thiết yếu cho sức khỏe hiện tại của trẻ. AAP khuyến nghị quyết định nên do cha mẹ đưa ra sau khi trao đổi với bác sĩ nhi, cân nhắc lợi ích tốt nhất cho trẻ, gồm các truyền thống y tế, tôn giáo, văn hóa và sắc tộc. Cha mẹ nên trao đổi lợi ích và nguy cơ với bác sĩ trước khi quyết định.

Lợi ích của cắt bao quy đầu?

Có một số bằng chứng cho thấy lợi ích y tế, gồm: giảm nhẹ nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu; giảm nhẹ nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) ở nam; có thể bảo vệ khỏi ung thư dương vật và giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung ở bạn tình nữ; phòng viêm quy đầu – bao quy đầu (balanoposthitis); phòng hẹp bao quy đầu (phimosis) và nghẹt bao quy đầu (paraphimosis); giúp giữ sạch đầu dương vật dễ hơn.

Nguy cơ của cắt bao quy đầu?

Chảy máu; nhiễm trùng; tổn thương quy đầu. Lưu ý: một số nghiên cứu cho thấy vệ sinh tốt có thể giúp phòng một số vấn đề của dương vật, gồm nhiễm trùng và sưng, ngay cả khi không cắt bao quy đầu. Ngoài ra, quan hệ tình dục an toàn là yếu tố quan trọng giảm nguy cơ STI và các nhiễm trùng khác.

Tiêm chủng cho trẻ

Tiêm chủng là gì?

Tiêm chủng là cách bảo vệ trẻ khỏi mắc nhiều bệnh. Nhiều bệnh trong số này dễ lây từ trẻ sang trẻ và có thể gây vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Trong hai năm đầu đời, trẻ nên được tiêm vắc-xin để phòng: COVID-19; bạch hầu; Haemophilus influenzae type B (bệnh Hib); viêm gan A; viêm gan B; cúm; quai bị; ho gà; bệnh phế cầu; bại liệt; rotavirus; rubella (sởi Đức); sởi (rubeola); uốn ván; thủy đậu (varicella). Các vắc-xin này rất an toàn và đã giúp hàng nghìn trẻ khỏi bệnh. Thông tin thêm tại CDC www.cdc.gov/vaccines.

Con tôi nên tiêm chủng khi nào?

Trẻ nên được tiêm chủng trong hai năm đầu đời, cần nhiều liều để được bảo vệ đầy đủ. Ví dụ, khuyến nghị trẻ tiêm mũi MMR (sởi, quai bị, rubella) đầu tiên lúc 12 tháng trở lên và mũi hai trước khi vào tiểu học (khoảng 4–6 tuổi). Trẻ có thể tiêm ở các buổi khám sức khỏe định kỳ.

Vắc-xin được tiêm thế nào?

Hầu hết vắc-xin được tiêm dưới dạng mũi chích.

Vắc-xin có an toàn không?

Có. Vắc-xin cho bệnh trẻ em rất an toàn. Đôi khi vắc-xin gây tác dụng phụ nhẹ như đau tay/chân hoặc sốt nhẹ. Tác dụng phụ nặng khó xảy ra. Bệnh trẻ em là nguy cơ sức khỏe lớn hơn nhiều so với vắc-xin. Hãy hỏi nhân viên y tế về nguy cơ và tác dụng phụ.

Khi nào trẻ không nên tiêm?

Trong một vài trường hợp, tốt hơn nên chờ. Một số trẻ rất ốm không nên tiêm. Lý do nên chờ hoặc không tiêm gồm: đang ốm nặng hơn cảm lạnh; có phản ứng nặng sau liều vắc-xin đầu; từng co giật (cử động giật cục đột ngột) được cho là do vắc-xin.

Con tôi trên hai tuổi vẫn tiêm được không?

Có. Vắc-xin có thể tiêm cho trẻ lớn và người lớn. Trẻ được tiêm sớm để ít nguy cơ mắc bệnh hơn. Loại vắc-xin có thể khác với trẻ lớn — hãy trao đổi với nhân viên y tế.

Tôi có nên tiêm nếu dự định mang thai?

Nếu bạn không biết mình đã từng bị rubella (sởi Đức) hay thủy đậu chưa, hoặc chưa tiêm, hãy trao đổi với nhân viên y tế về việc tiêm. Nếu phụ nữ mang thai mắc rubella hoặc thủy đậu, bé có thể sinh ra bị dị tật. Tuy nhiên, bạn không nên tiêm các vắc-xin này nếu dự định mang thai trong tháng tới hoặc đã mang thai; có thể tiêm sau sinh, đôi khi ngay trong thời gian nằm viện hậu sản.

Vì sao phải quan tâm đến vắc-xin?

Nhờ vắc-xin, bệnh trẻ em ít gặp hơn. Nhưng các bệnh này vẫn có thể mắc và có thể gây tử vong. Trẻ vẫn bị nghẹt thở, tổn thương não, liệt, vấn đề tim, mù và các vấn đề khác do bệnh trẻ em. Ở hầu hết các bang, trẻ phải được tiêm chủng

trước khi vào học. Giữ hồ sơ tiêm chủng của con là rất quan trọng — đây là phần quan trọng trong bệnh sử của trẻ.

Tìm thêm thông tin ở đâu (tại Việt Nam)?

Tại Việt Nam, trẻ được tiêm miễn phí nhiều vắc-xin theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế phường/xã. Ngoài ra, bạn có thể tiêm dịch vụ tại các trung tâm tiêm chủng như VNVC (tổng đài 028 7102 6595, làm việc 7h30–21h) hoặc tại các bệnh viện sản-nhi. Hãy hỏi trạm y tế, bác sĩ nhi hoặc cơ sở tiêm chủng về lịch tiêm phù hợp và luôn giữ sổ tiêm chủng của bé để theo dõi. (Bản gốc dẫn nguồn tham khảo của CDC Hoa Kỳ: www.cdc.gov/vaccines.)

Làm giấy tờ và bảo hiểm y tế cho bé

[Phần này đã được bản địa hóa cho Việt Nam. Bản gốc hướng dẫn theo hệ thống bảo hiểm tư nhân của Hoa Kỳ — MyChart, FMLA, Medicaid, "Birthday Rule"... không áp dụng ở Việt Nam.]

Tại Việt Nam, sau khi bé chào đời có hai việc giấy tờ quan trọng cần làm sớm: đăng ký khai sinh và tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho bé.

Đăng ký khai sinh

Nên đăng ký khai sinh cho bé trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh, tại UBND phường/xã nơi cư trú. Hồ sơ thường gồm: giấy chứng sinh do bệnh viện/cơ sở y tế cấp, giấy tờ tùy thân của cha mẹ và giấy tờ cư trú. Nhiều địa phương đã cho phép đăng ký khai sinh trực tuyến, thường theo cơ chế "liên thông" ba thủ tục: đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi

Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí và được khám, chữa bệnh không phải trả tiền trong phạm vi quyền lợi khi khám đúng nơi đăng ký/đúng tuyến tại cơ sở y tế công lập. Khi làm thủ tục liên thông khai sinh, cơ quan chức năng thường cấp luôn thẻ BHYT cho bé. Nếu chưa có thẻ, hãy liên hệ UBND phường/xã hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Vài lưu ý

- Mang theo giấy chứng sinh và giấy tờ tùy thân của cha/mẹ khi đi làm thủ tục.
- Giữ cẩn thận thẻ BHYT của bé và mang theo mỗi lần đi khám để được hưởng quyền lợi.
- Nếu gia đình có tham gia thêm bảo hiểm sức khỏe tư nhân, hãy liên hệ hãng bảo hiểm để bổ sung bé vào hợp đồng theo quy định của hãng.

Tìm bác sĩ nhi và nơi khám cho bé

[Phần này đã được bản địa hóa cho Việt Nam. Bản gốc giới thiệu dịch vụ tìm bác sĩ nhi của Cleveland Clinic Children's tại Hoa Kỳ.]

Ở Việt Nam, bạn có thể chọn khám và theo dõi sức khỏe cho bé tại nhiều loại cơ sở: bệnh viện chuyên khoa nhi, khoa nhi của bệnh viện sản-nhi hoặc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, các phòng khám nhi, và các hệ thống y tế tư nhân. Hãy chọn nơi thuận tiện đi lại, có bác sĩ nhi bạn tin tưởng và có khả năng cấp cứu khi cần.

Một số cơ sở nhi khoa lớn để tham khảo

- **Miền Bắc:** Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) — tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 866 615.
- **Miền Nam:** Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) — (028) 3927 1119, tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em 1900 0154; Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) — (028) 3829 5723, chăm sóc khách hàng 1900 1215.
- **Hệ thống y tế tư nhân (ví dụ):** Vinmec — tổng đài 1900 232 389, đặt lịch qua ứng dụng MyVinmec hoặc website www.vinmec.com.
- **Ngoài ra:** trạm y tế phường/xã, các bệnh viện sản-nhi và bệnh viện đa khoa địa phương đều có khám và theo dõi sức khỏe cho trẻ.

Khi chọn bác sĩ nhi, nên cân nhắc

- Khoảng cách và thời gian đi lại từ nhà — quan trọng khi bé cần khám gấp.
- Cơ sở có khám ngoài giờ hoặc cấp cứu 24/24 không.
- Bác sĩ có kiên nhẫn, giải thích rõ ràng và bạn thấy tin tưởng không.
- Có hồ sơ sức khỏe/sổ tiêm chủng theo dõi liên tục và đặt lịch thuận tiện (điện thoại hoặc trực tuyến) không.
- Chi phí và việc có áp dụng bảo hiểm y tế (BHYT) hay không.

Chọn ghế ngồi ô tô cho bé

[Lưu ý bản địa hóa: các quy định pháp lý trong phần này của bản gốc là của Hoa Kỳ. Xem khung quy định Việt Nam ngay dưới đây; phần còn lại là kiến thức an toàn phổ quát vẫn áp dụng tốt.]

Quy định tại Việt Nam (từ 1/7/2026): Khi chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m trên ô tô, người lái không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) và phải dùng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ (ghế/đệm chuyên dụng — hệ thống CRS/ECRS). Vi phạm có thể bị phạt tiền (mức 800.000 – 1.000.000 đồng theo quy định hiện hành). Hãy cập nhật quy định mới nhất khi áp dụng.

Vì sao chọn đúng ghế ngồi ô tô lại quan trọng?

Chọn ghế ngồi ô tô cho bé là một trong những việc quan trọng nhất trước khi bé chào đời. Có nhiều nhãn hiệu và loại ghế; hãy dành thời gian và công sức chọn loại phù hợp với bé và với xe của bạn.

Cần tìm gì ở một chiếc ghế ô tô cho trẻ?

Hãy chọn ghế phù hợp nhất với bé và với xe của bạn. Không phải ghế nào cũng như nhau và cũng không hợp với mọi loại xe. Ghế nên chọn dựa trên chiều cao và cân nặng của bé; hãy thử để chắc chắn ghế vừa với bé và xe. Để lắp đúng, đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc liên hệ kỹ thuật viên ghế ô tô có chứng chỉ ở gần bạn.

Ghế đắt tiền hơn có tốt hơn không?

Giá không nên là tiêu chí duy nhất. Mọi ghế đều đạt cùng tiêu chuẩn an toàn và phải qua cùng các bài kiểm tra va chạm. Ghế đắt hơn thường có thêm tính năng, nhưng không hẳn an toàn hơn hay dễ dùng hơn.

Có thể mua ghế cũ không?

Quy định an toàn ghế thay đổi thường xuyên, nên nếu có thể, đừng mua ghế cũ. Không bao giờ dùng ghế đã va chạm, thiếu bộ phận hoặc hư hỏng. Cũng khó biết ghế có được bảo quản đúng hay từng bị tai nạn hay không, nên mua ghế cũ mà không rõ lai lịch là không khuyến khích. Dù mua ghế nào, hãy đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất (có thể lấy trực tuyến hoặc từ hãng), đăng ký ghế với nhà sản xuất và kiểm tra ghế có bị thu hồi không.

Ghế nên vừa với bé thế nào?

Ghế cho trẻ nhỏ nên có đai an toàn 5 điểm: hai điểm ở vai (mỗi vai một), hai điểm ở hông (mỗi hông một), và một điểm khóa giữa hai chân. Với dây vai, điểm gắn vào ghế nên ở ngang hoặc ngay dưới vai bé (hầu hết ghế cho phép chỉnh độ cao lưng ghế để tạo độ cao dây vai đúng). Dây vai cũng nên có kẹp giữ (retainer clip) giữ dây trên ngực; kẹp này cài ngang ngực ở ngang nách và giữ ở vị trí đó khi dây được siết chặt. Khi mọi kẹp đã cài, siết dây sao cho bạn không "véo" được đoạn dây thừa nào giữa các ngón tay (thử bằng cách đặt một ngón ngay trên và một ngón ngay dưới ngang xương đòn).

Có những loại ghế ô tô nào?

Có bốn loại ghế cho trẻ: quay mặt về sau (chỉ dành cho trẻ nhỏ – infant-only); ghế chuyển đổi (convertible); ghế kết hợp (combination); ghế nâng (booster). Cũng có ghế và đai làm riêng cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Mỗi loại có tính năng phù hợp với giai đoạn của bé và có giới hạn cân nặng khác nhau. Luôn xem thông tin nhà sản xuất kèm theo ghế trước khi mua.

- **Ghế chỉ cho trẻ nhỏ (infant-only):** còn gọi là ghế quay mặt về sau — tư thế an toàn nhất cho trẻ nhỏ. Để bảo vệ tốt nhất, giữ bé quay mặt về sau ở ghế sau càng lâu càng tốt; khuyến nghị đến 3 tuổi. Ghế nên ngã khoảng 45 độ và không bao giờ đặt trước túi khí. Độ cao dây vai ở ngang vai bé hoặc ngay dưới. Không vượt quá chiều cao/cân nặng tối đa; nếu vượt, chuyển bé sang ghế chuyển đổi ở tư thế quay mặt về sau.
- **Ghế chuyển đổi (convertible):** về cơ bản là hai ghế trong một, đặt ở ghế sau, quay mặt về sau đến khi bé khoảng 3 tuổi và ít nhất 20 pound (~9 kg) (nhiều ghế cho phép cân nặng quay sau cao hơn). Sau đó xoay ghế về phía trước; khi đã quay trước, đặt độ cao dây vai ngay trên vai bé.
- **Ghế kết hợp (combination):** đặt ở ghế sau, quay mặt về trước, dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên và nặng khoảng 20–40 pound (~9–18 kg). Có thể chuyển thành ghế nâng định vị đai khi bé nặng ít nhất 40 pound (~18 kg) và ít nhất 4 tuổi. Không dùng quay mặt về sau.
- **Ghế nâng (booster):** dành cho trẻ 4–8 tuổi và cao ít nhất 4 feet 9 inch (~145 cm). Bắt đầu dùng khi bé lớn quá ghế cũ (tai cao hơn lưng ghế, vai cao hơn khe dây trên) hoặc đạt giới hạn cân nặng. Thường dùng đến khi bé ít nhất 8 tuổi và cao 4'9", rồi mới dùng đai an toàn thường ở ghế sau.

Có bắt buộc phải có ghế ô tô không?

Dù quy định pháp luật thế nào, bé vẫn an toàn nhất khi dùng ghế/thiết bị an toàn phù hợp. Trẻ nhỏ không dùng loại thiết bị nào sẽ không được bảo vệ khỏi chấn thương nghiêm trọng. Quy tắc chung là giữ trẻ trong ghế phù hợp cho đến khi bé cao khoảng 1,35 m (4'9"). (Tại Việt Nam, xem khung quy định ở đầu mục này.)

Khi nào bé có thể dùng đai an toàn thường?

Bé sẵn sàng dùng đai an toàn ô tô thường khi đạt các tiêu chí: vượt giới hạn cân nặng của ghế nâng (khoảng 80 pound ~36 kg); ngồi tựa lưng vào ghế; gấp gối được qua mép ghế. Trẻ dưới 13 tuổi nên ngồi ghế sau. Mọi người luôn nên thắt dây an toàn.

Tìm thêm thông tin về ghế ô tô ở đâu?

Truy cập trang của National Highway Traffic Safety Administration (www.nhtsa.gov) — có công cụ giúp tìm ghế an toàn cho bé bằng cách nhập ngày sinh, chiều cao và cân nặng của bé (<https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats#car-seat-finder>).

References

US Department of Transportation, NHTSA. Car Seats and Booster Seats. Accessed 1/28/2020. — American Academy of Pediatrics, healthychildren.org. Car Seats: Information for Families. — Safe Kids Worldwide. Car Seat Safety Tips. — Governors Highway Safety Association. Child Passenger Safety.

This information is provided by the Cleveland Clinic and is not intended to replace the medical advice of your doctor or healthcare provider. © Copyright 1995–2023 The Cleveland Clinic Foundation. All rights reserved.